中医师承学堂

一所没有围墙的大学

胡希恕医学全集

跟师胡希恕辨析五十证

陈雁黎 著

胡希恕先生嫡传弟子陈雁黎主任医师，曾跟随胡希恕老师临床见习（1961年）与实习（1963年），并亲自在胡希恕老师家中听课、做笔记（持续到1966年）。

本书作者陈雁黎遵胡老所嘱，对《伤寒论》五十证进行辨析，尽显跟师所悟、跟师所得！

中国中医药出版社

中医师承学堂

一所没有围墙的大学

胡希恕医学全集

跟师胡希恕辨析五十证

陈雁黎 著

胡希恕先生嫡传弟子陈雁黎主任医师，曾跟随胡希恕老师临床见习（1961年）与实习（1963年），并亲自在胡希恕老师家中听课、做笔记（持续到1966年）。

本书作者陈雁黎遵胡老所嘱，对《伤寒论》五十证进行辨析，尽显跟师所悟、跟师所得！

全国百佳图书出版单位
中国中医药出版社

作者简介：

陈雁黎，主任医师。1960 年考入北京中医学院（现北京中医药大学）中医系（本科六年制），跟随经方大家胡希恕老师临床见习（1961 年）与实习（1963 年），并聆听老师在家中讲课（持续到 1966 年）。1967 年底，响应国家号召，被分配到新疆从事中医临床工作。退休后于 2004 年受聘为昌吉州中医医院外聘专家。从事中医临床工作至今已五十余年。主编《胡希恕伤寒论方证辨证》，为纪念胡希恕先生诞辰 120 周年，曾填词《满江红》并制作成视频。

内容简介：

本书作者陈雁黎主任医师遵恩师胡希恕先生所嘱，对《伤寒论》五十证进行辨析，尽显跟师所悟、跟师所得。遵胡老“读《伤寒论》要上下联系、前后对照、要以论释论，用仲景的话解释仲景的论”的指导原则，对《伤寒论》的 40 个证候和 10 个证治，进行了归纳、分析和鉴别，以冀初学者对《伤寒论》所述的“证”有所了解，有利于认识疾病和明确诊断，从而达到辨证准确之目的。黄煌教授评价此书道：“秉承胡希恕先生求真务实的学术精神，立足经典，贴近临床，不空谈，不随俗，内容实在，是学习研究胡希恕医学的重要著作。”

中医师承学堂
胡希恕医学全集

跟师胡希恕辨析五十证

陈雁黎◎著

中国中医药出版社
·北京·

图书在版编目（**CIP**）数据

跟师胡希恕辨析五十证/陈雁黎著.--北京：中国中医药出版社，2019.8

（中医师承学堂）

ISBN 978-7-5132-5632-2

Ⅰ.①跟…　Ⅱ.①陈…　Ⅲ.①《伤寒论》—研究　Ⅳ.①R222.29

中国版本图书馆CIP数据核字（2019）第136440号

中国中医药出版社出版

北京经济技术开发区科创十三街31号院二区8号楼

邮政编码　100176

传真　010-64405750

印刷

各地新华书店经销

开本710×1000　1/16　印张11　字数121千字

2019年8月第1版　2019年8月第1次印刷

书号　ISBN 978-7-5132-5632-2

定价　45.00元

网址　www.cptcm.com

社长热线　**010-64405720**

购书热线　**010-89535836**

维权打假　**010-64405753**

微信服务号　**zgzyycbs**

微商城网址　**https：//kdt.im/LldUGr**

官方微博　**http：//e.weibo.com/cptcm**

天猫旗舰店网址　**https：//zgzyycbs.tmall.com**
如有印装质量问题请与本社出版部联系（010-64405510）
版权专有　侵权必究

本书的编写得到昌吉州中医医院及众多同仁的大力支持与帮助，谨在此诚挚致谢！

协助整理　陈　豫　梁尔福　聂文凯　高琮杰
马立云　董　瑞　梁佑民　李跃海
宋　阳　卞保平　戴海安　戴伯华
席　君　李　叶　王　燕　马齐飞
葛　梦　李尽峰　王振兴　余洪刚
王　鹏　曹军会

整理单位　新疆昌吉州中医医院

作者简介

陈雁黎，主任医师。1958年高中毕业，在河南省第一人民医院药局中药房工作。1960年考入北京中医学院（现北京中医药大学）中医系（本科六年制），跟随胡希恕先生临床见习（1961年）与实习（1963年），并聆听老师在家中讲课（持续到1966年）。1966年毕业后参加北京医疗队1年。1967年底，响应国家号召，被分配到新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县工作。退休后于2004年受聘为昌吉州中医医院外聘专家，从事临床工作至今已五十余年。主编《胡希恕伤寒论方证辨证》，为纪念胡希恕先生诞辰120周年，曾填词《满江红》并制作成视频。

黄煌序

在陈雁黎先生的新作《跟师胡希恕辨析五十证》和《胡希恕经方二百首辨析》出版之际，我要写几句推荐的话。

陈雁黎先生是著名经方家胡希恕先生的高足，长期在临床一线工作。五十年的实践，让先生的临床经验非常丰富，对经方的认识不断深化，对胡希恕先生的感情也更加深厚。他虽年迈，但壮心不已，笔耕不辍。前几年，他编写了《胡希恕伤寒论方证辨证》一书，以胡希恕先生20世纪60年代临证亲自书写的80个原始医案为主体，介绍胡希恕先生用经方的经验。而本次这两本书不仅有胡希恕先生对二百余首类方辨析的原始讲稿，还有陈雁黎先生遵胡希恕先生“以论释论”的原则，不涉及经络脏腑，对《伤寒论》的40个证候和10个证治进行了归纳、分析和鉴别。陈雁黎先生的三本书都秉承胡希恕先生求真务实的学术精神，立足经典，贴近临床，不空谈，不随俗，内容实在，是学习和研究胡希恕医学的重要著作。

陈雁黎先生待人真诚，重视友情。他为纪念胡希恕先生诞辰120周年而填词《满江红》，情真意切，听来让人热泪盈眶。我和先生都是经方的推广者，这几年来，他全力支持我的工作，多次应邀来南京讲学，传授胡希恕先生的学术思想及经验，同时也把他的经方应用体会和盘托出。这次，先生又乐聘于我院的客座教授，让我们非常感动。先生是一位令人敬佩的中医学者，先生与我是经方道路上的忘年交。有先生这样一批老前辈的支持，我坚信经方的明天一定会更美好！

莫道桑榆晚，为霞尚满天。先生长期在边疆的基层从事临床工作，默默无闻五十多年，这几年来先生的大名才被大家所熟悉。现在先生忙碌着，但也幸福着。我真诚地祝愿陈雁黎先生健康长寿，祝愿先生的经方推广事业如绚丽的晚霞，红遍天际！

南京中医药大学国际经方学院院长　黄煌

2018年11月2日

自序

医生治病首先要明确诊断，而要诊断正确必须进行鉴别诊断，才不会或者减少误诊。为达到此目的，西医有临床检查、检体检查、化验检查、细菌和病毒学检查、影像学检查及病理学检查等。这些检查对于严重疾病、专科疾病的诊断及治疗或中西医结合治病，是很有必要的。总之要尽最大可能找到“敌人”，而“歼灭”之。

如此先进的诊断方法，用于中医治疗常见病、多发病，却深感“英雄难有用武之地”。其一，如西医认为感冒是一种病，由病毒或细菌引起，中医则认为感冒可不是一种病。有发热的，也有恶寒的；有不出汗身疼的，也有出汗怕风的；有头痛恶心不欲食的，也有腹胀数日不大便的；有学生、战士的感冒，也有患各种慢性病病人的感冒；还有经期感冒、产后感冒、手术后感冒等。其二，现在的科学技术，可以化验出一味草药的有效成分，可是，几味或十几味草药放在一起煎煮，再加上各味药用量不同，是否可以治病就不得而知。只有通过大范围人群试用，才能找到其适应证，这是个既费力又耗时的工程。两千多年的“经方”，是拿无数人的生命换来的，千锤百炼，可靠有效，拿来就可用。其三，西药是药厂加工制造的，有效成分精确，直达病所，但没有药性药味。中草药所含成分复杂，我们只能根据其药性药味针对证候进行治疗。

而仲景的《伤寒杂病论》就为我们提供了一个独特的诊疗方法，并且是诊断和鉴别诊断及治疗同时进行，患者不需去进行各种检查、化验，西医的检查结果只能作参考，胡希恕先生称其为“辨证施治”。

中医明确诊断靠“辨证”。《伤寒论》十卷用“辨某病脉证并治”10次；《金匮要略》三卷22篇用“某病脉证并治”11次、“某病脉证治”7次、“某病证治”2次、“某病脉证”2次。即两部经典所有篇题，离不开“证”。王叔和《伤寒例》讲：“今搜采仲景旧论，录其证候，诊脉声色，对病真方，有神验者，拟防世急也……此以前是伤寒热病证候也。”

从以上可以看出，证即症状，证候包括证、脉、声、色，即病邪侵入人体的异常反应。若证前有名，证属名义，如：寒证、热证、虚证、

实证、表证、里证、少阳证、阳明证、方证、桂枝证、柴胡证、四逆证等。

我曾在就读北京中医学院（现北京中医药大学）期间，有机会跟随胡希恕先生临床见习（1961年）与实习（1963年），胡老在家中讲课（持续到1966年），我也坚持现场听课。前后我跟师胡希恕先生学习经方五年多。

遵胡老“读《伤寒论》要上下联系、前后对照，要以论释论，用仲景的话解释仲景的论”的指导原则，我在几十年的临床中不断按照胡老的教导进行总结，对《伤寒论》的40个证候和10个证治，进行了归纳、分析和鉴别，以冀初学者对《伤寒论》所述的“证”有所了解，有利于认识疾病和明确诊断，从而达到辨证准确之目的。纵观近年来的中医临床著作，绝大部分与仲景学说有关，可见其重要性和实用性。近五六年，全国各地“经方培训班”如雨后春笋，“你方结束我登场”，10月6日“伦敦世界经方大会”也刚圆满落幕。沧海横流，方显经方本色。为此，笔者编写这本关于证与方的书，供初学经方时参考。愚已耄耋，失之东隅，收之桑榆，若对大家学习《伤寒论》有所裨益，笔者甚慰。

本书引证条文甚多，统计、打印、校对，费时费力，幸有规培学生加班加点，确保在较短时间内完成。另外，笔者年迈，不会使用电脑，能制作成纪念胡希恕先生诞辰120周年的《满江红》视频，全凭学生努力，方可仰慕成颂。在此，一并致谢！

医道无边，方寸之间，一孔之见，是为序。

南京中医药大学国际经方学院客座教授　陈雁黎（时年八十）

2018年10月28日于昌吉市家中

编写说明

1.本书所引用的《伤寒论》原文，以新辑宋本《伤寒论》（重庆市中医学会编注，重庆人民出版社　　1955年10月第1版第4次印刷）为蓝本，改宋本中文条文号为阿拉伯字条文号。参照上海中医学院伤寒温病学教研组校注《伤寒论》（上海科技出版社1983年4月第1版），将繁体字改为简体字。本书中《伤寒》即《伤寒论》之简称。

2.本书所引用的《金匮要略》原文，为人民卫生出版社2012年3月出版的“梅花本”《金匮要略方论》。本书中《金匮》即《金匮要略》之简称。

目　录

作者简介

黄煌序

自序

编写说明

第一章　胡希恕八纲释六经解

第一节　辨证施治与辨证论治

一、《内经》的沿革及成书年代

二、《伤寒杂病论》的由来

小　结

第二节　以八纲释伤寒

一、阴、阳

二、表、里

三、寒、热

四、虚、实

五、八纲在《伤寒论》中出现次数的统计表

六、《伤寒论》中有关脏腑的论述

第三节　“八纲释六经”解

第四节　胡希恕先生1965年讲课手稿

一、辨证施治的基本概念

二、有关八纲的概念

三、有关六经的概念

第五节　汗与溺的相互关系——胡希恕先生1963年讲课手稿

一、小便不利则汗不出

二、小便数则汗自出

三、汗不出则肺气伤

四、肺气虚则小便不禁

五、表气畅则小便行

第六节　“但见一证便是，不必悉具”之我见

第七节　半夏泻心汤的临床应用

一、《伤寒》《金匮》中半夏泻心汤的论述

二、胡希恕半夏泻心汤的临床应用

三、医案举例

第二章　伤寒论证候辨析

证（即症）解

一、恶风寒

（一）表证的恶风

（二）虚证的恶风

（三）表证的恶寒

（四）虚证的恶寒

二、不恶寒

三、振栗、振寒

（一）阳虚

（二）表解的病机

（三）治例

（四）里证的恶寒

四、厥

（一）释义

（二）厥和热的病变

（三）死证

（四）治例

五、发热

（一）表证的发热

（二）里证的发热

（三）虚证的发热

（四）阳气未泯的发热（泯，读mǐn，作尽讲）

六、往来寒热

七、身疼痛

八、自汗、无汗

（一）表证自汗

（二）里热证自汗

（三）亡阳的自汗

（四）无汗

九、头痛

十、头眩

十一、口苦、口干、口燥

十二、咽痛

十三、衄血

（一）阳盛

（二）强迫发汗的险证

（三）自愈证

（四）治则

十四、口渴

（一）热盛

（二）蓄水

（三）伤阴

十五、咳

十六、喘

十七、悸

（一）病因

（二）治则

十八、结胸

（一）病因

（二）结胸与脏结的鉴别

十九、胸胁满

二十、心下痞

（一）病因

（二）证候

（三）治例

二十一、心下满

二十二、心中懊憹

二十三、腹满

（一）虚证

（二）实证

二十四、腹中痛

二十五、少腹满、少腹硬

二十六、哕

（一）病因

（二）治疗
二十七、呕吐
（一）半表半里证
（二）热证
（三）寒证
（四）水气
（五）误治变证
（六）治疗原则
二十八、不能食、能食
（一）吐、下后的不能食
（二）胃寒的不能食
（三）热扰于胃的不能食
（四）有燥屎的不能食
（五）能食与否辨寒热
（六）病欲解的能食
（七）死证的能食
二十九、发黄
（一）病机
（二）热证
（三）寒湿证

三十、谵语

（一）病因

（二）辨生死

（三）治例

三十一、烦躁

（一）病因

（二）表热

（三）里热

（四）里实

（五）半表半里

（六）表里俱实证

（七）寒饮证

（八）阳虚证

（九）伤津

（十）辨死证

三十二、奔豚

三十三、狂

三十四、小便不利、小便利

（一）亡津液的小便不利

（二）蓄水的小便不利

（三）亡津液的小便利

（四）蓄血证的小便利

（五）小便利或不利与发黄的关系

（六）小便色白

三十五、不大便

（一）实证

（二）虚证

（三）伤津

三十六、下利

（一）病因

（二）虚寒证

（三）表证

（四）半表半里证

（五）伤阴证

（六）气郁证

（七）水饮食滞证

（八）脾胃虚弱证

（九）里热证

（十）里实证

（十一）治疗原则

（十二）下利病机的好转
（十三）下利病机的恶化
（十四）下利病机的顺逆
三十七、便脓血
（一）便血的病因
（二）治例
三十八、瘀血
三十九、差后劳复
四十、潮热
（一）阳明腑实潮热
（二）少阳里实潮热
第三章　伤寒论证治辨析
一、汗
二、不可汗
三、误汗
四、下
五、不可下
六、误下
七、辨汗、下先后
八、和

九、死

十、愈

第一章　胡希恕八纲释六经解

第一节　辨证施治与辨证论治

1963年，我跟随胡希恕先生完成为期半年的期中实习。期间胡老无授课任务，每周上班六个整天，故收获颇丰。抄胡老手稿时，发现有“辨证施治”，也有“辨证论治”。于是问胡老，哪个说法对？答曰：“都对，在我这里应该是辨证施治，你们跟着讲义说，应该是辨证论治。”又说：“辨证施治是进行式，辨证论治是讨论式。你们还在那里讨论呢，我这里已经施治完了。你们就随讲义吧。”时光流转，已过去五十多年。中医基层工作者要培训，毕业生要实习，又遇到了同样的问题。翻开新书《胡希恕讲伤寒杂病论》，书内用的仍是“辨证施治”，提醒我有必要再认识这个问题。

教材讲“辨证论治”是辨证求因，审因论治，立法选方，据方议药。《辞海》谓：“论者，有讨论、论证、选择之意。”“论治”的核心是，运用《内经》的脏腑理论、五行学说、病因病机及治疗法则，进行辨证治疗。其结果是医生自己造一张处方，想怎么说就怎么说，处方想怎么开就怎么开，要工作很多年，才能取得自己的经验，难怪有“看病要找老中医”之说。师承传授有其局限性，有些经验很难重复。胡老称其为医经理论体系，当然要用“辨证论治”，教材就是如此教的。

胡老讲辨证施治是于罹病人体一般的规律性的反应基础上，而更适应整体的、讲求通治常见疾病的大法。它的程序是：罹病人体的证候反应→八纲辨证→六经辨证→再辨方证→抓主证，进行“方证”治疗。这是有别于医经理论体系的经方理论体系。辨方证是辨证的尖端，有是证就必用是方，不管它是西医的什么病，就可以“一方治多病”，达到“异病同治”的目的。

《辞海》谓：“施者，有给予、实行、用之之意。”“施治”时，既然辨方证准确，随即处方治疗，不必再进行讨论。故张仲景在《伤寒论》中用“主之”，有123次之多，“宜”有40次，“可与”有24次，“不可与”有16

次，“不得与”有2次，“当服”有1次。仲景有云“随证治之”（16）、“以法治之”（267）、“以法救之”（244）。六经病的标题是“辨某病脉证并治”。“并”者，有合并、一齐、兼并之意，如“二阳并病”（220）、“太阳与少阳并病”（142、150、171）。“并联”“并列”“并发症”及“合并症”等，都是并列关系，有“并驾齐驱”之意。仲景没有考虑、化裁、以冀、斟酌、讨论之言。以上就是辨脉象及证候之后，直接用方证进行治疗之明证，如桂枝证、柴胡证、白虎证、四逆证等，胡老称之为“辨证施治”。

胡希恕先生断然指出：“仲景书本与《内经》无关，《伤寒论》的六经来自八纲。”“经方理论体系与医经理论体系，都是源远流长，但二者不能混为一谈。用《内经》的理论作依据，解释《伤寒论》的经方，是不合适的。”“经方理论用辨证施治，医经理论用辨证论治，我看是适合的。”对此，作者有如下的讨论，与同道商榷。

一、《内经》的沿革及成书年代

《素问》的前期作品基本可以肯定是战国至东汉这一段时间的，它亦非成于某一人之手。凡七十余篇，主要是用竹简、帛书或刻在木板上等方式，传抄流传，原貌已不可睹。任应秋老师在《中国医籍提要》中谓：“《黄帝内经太素》是第一部对《内经》全文进行分类的典籍。同时，它又是我国现存最早的《内经》注本。为隋唐杨上善在公元605～616年任太医侍御时所著。”任老在《内经十讲》中谓：“杨上善的《太素》，实为《素问》《灵枢》的混合改编本。”杨氏将《素问》《灵枢》各篇全部拆散，按其不同内容的性质共分作十九大类。”

王冰，号启玄子（公元710—804年），唐代宝应年间曾任太仆令，先后用了十二年的时间整理和注释《素问》。任老在《中国医籍提要》中谓：“《黄帝内经素问》为王冰重新编次并注释《素问》之作，书凡二十四卷，计八十一篇。”

任应秋老师在《内经十讲》中谓：“《内经》这书，单从《素问》来说在唐代就已经是错乱不堪了。”

王冰自序中说：“世本纰缪，篇目重叠，前后不伦，文义悬隔，施行不易，披会亦难，岁月既淹，袭以成弊。或一篇重出，而别立二名；或两论并吞，而都为一目。或问答未已，别树篇题；或脱简不书，而云

世缺。重《经合》而冠《针服》，并《方宜》而为《咳篇》，隔《虚实》而为《逆从》，合《经络》而为《论要》。节《皮部》为《经络》，退《至教》以《先针》，诸如此流，不可胜数。”

王冰是怎样下校勘功夫的呢？其在自序中云：“其中简脱文断，义不相接者，搜其经论所有，迁移以补其处。篇目坠缺，指事不明者，量其意趣，加字以昭其义。篇论吞并，义不相涉，缺漏名目者，区分事类，别目以冠篇首。君臣请问，礼仪乖失者，考核尊卑，增益以光其意。错简碎文，前后重叠者，详其指趣，削去繁杂，以存其要。”

《素问》的第二部分，主要指《天元纪大论》《五运行大论》《六微旨大论》《气交变大论》《五常政大论》《六元正纪大论》《至真要大论》七篇，还有《六节藏象论》前面一段。全是王冰所增补，通称“七大论”。

钱超尘教授在《伤寒论文献通考》（学苑出版社，北京，1993）一书中指出：“王冰《素问》注本，以南朝齐梁间人全元起的《注黄帝素问》八卷（约70余篇已亡佚）为底本，而加以校注和重新编次。王冰本之“七大论”不是《素问》原书所有，而是王冰不明言该篇的来源与流传，硬指派它就是久已失亡的《素问》第七卷，失之孟浪。林亿对此卷详加考证，证明此卷是汉代古医经《阴阳大论》，但绝非是《素问》第七卷之原文。林亿所考，坚不可摧，已成定论，有功医林。”

《内经》的主要内容是脏腑经络、病机、诊法、治则四大学说。又论伏羲知天，黄帝知人，神农知地，并讲草木、果实、虫畜、鬼邪，可谓“中国古代医学论文之大全”。洋洋162篇，约15万字，唯独缺少治病的方剂。所载13个方剂：四乌贼骨一藘茹丸和泽泻术散为验方；小金丹方为炼丹防疫之药（辰砂、雄黄、雌黄均有大毒），并非《外科全生集》治骨疽、瘰疬的小金丹，鸡矢醴方在《金匮》叫鸡屎白散；泽泻术散在《金匮》叫泽泻汤，但二者的主治有明显不同。其余9张方剂，只能说它是食疗偏方。

中医治病没有草药不行。《素问》理论庞大，下笔千言，离药万里，所载药物乌贼骨、茜草、泽泻、白术、紫苏、生铁落、雄黄、雌黄、辰砂、鸡屎、醴等10味，只有泽泻和白术来自《神农本草经》。成书年代比《内经》要早的《五十二病方》，虽看不到阴阳五行的痕迹，却载药方近300个，使用药物247味。《五十二病方》讲“不见于《神农

本草经》和《名医别录》两书的草药，接近一半”。说明写作此书的人见到了《神农本草经》。同样是在唐代，《备急千金要方》（简称《千金要方》）和《千金翼方》的著者孙思邈（公元581—682年），《外台秘要》（简称《外台》）的作者王焘（公元670—755年），均见到了《神农本草经》和《伤寒杂病论》的部分内容，并加注说明。唯独上千年形成的《素问》改来改去，算上王冰，却没有见到“开天辟地”的两大中医经典古籍，这不能不使人感到疑惑。

《素问》的第一部分，从文字结构来看，说明出于先秦，是一部医学论文集，从未有人见到过。张仲景也未曾见到，因《伤寒杂病论》书中无《素问》的实质内容。《张仲景原序》谈到《素问》，为王叔和所加入，已成定论。一直到了南朝齐梁年间才有了全元起所注的《黄帝素问》八卷，又叫《素问训解》，约七十余篇，只有王冰和林亿见到了此书，全氏本亡佚于南宋。《素问》的第二部分，为王冰所加入的“七大论”和《六节藏象论》的前面一段，经考证实属汉代古医经《阴阳大论》。此“七大论”，主要讲“五运六气”，为王冰的侈言图钤之玄奥，给成无己以五运六气释《伤寒论》开足了先河。

《素问》的成书时间，从战国晚期，一直到唐代中期王冰校勘整理，重新编次，已逾千年。基本上是“论医不言方药”，可谓“不讲六经与八纲，绞尽脑汁做文章。写天写地说灵气，哪里还知仲景方？”

二、《伤寒杂病论》的由来

刘渡舟老师谓：“《伤寒论》是中医之魂。倘若没有《伤寒论》，中医将黯然失色。而没有王叔和，也没有《伤寒论》，所以说王叔和是仲景学说的功臣，是中医的功臣。”钱超尘教授谓：“《伤寒论》在中医学上的价值，无论给它怎样高的评价，也不过分。”

皇甫谧（公元215—282年）45岁时写《针灸甲乙经·序》谓：“伊尹以元圣之才，撰用神农本草，以为《汤液》。汉张仲景论广伊尹汤液为数十卷，用之多验。近代太医令王叔和撰次仲景遗论甚精，指事施用。”北宋高保衡、孙奇、林亿校订《伤寒论序》谓：“是仲景本伊尹之法，伊尹本神农之经。”

我们现在看到的《伤寒论》是398条，113方　　（缺禹余粮丸），

《金匮要略》是608条，44个病证，226方，另有附方28首。两书减去重复方和缺失方，实有方剂253首。两书减去重复药物，实有共用药物166种，其中近90%皆载于《神农本草经》，非《神农本草经》所记载的药物只有17种。

钱超尘教授对《伤寒杂病论》的由来在《伤寒论文献通考》有如下的考证：

“印刷术”肇始于隋，稍行于唐，扩大于五代，精卓于宋。汉代著作，除少数写于绢帛者外，其他大多写于竹简或木简。仲景《伤寒杂病论》，必用竹简。仲景著作撰于任长沙太守时，即建安七八年至建安二十二三年之间（公元202～218年），这16～17年间，《伤寒杂病论十六卷》是完整的。

仲景卒于建安之末（公元219年），仲景著作散乱于他逝世后3～5年，原貌已不能复睹，但没有丢失。实因魏太医令王叔和（公元210—280年），加以整理撰次。仲景未逝，叔和已生，二人未曾见面，亦必相知无疑。叔和年龄较皇甫谧为长。叔和见到了自己的山西同乡，仲景的学生卫汛，而卫汛则直呼王氏之名“熙”，故知二人乡谊颇深，这对整理仲景遗著大有帮助。

《张仲景原序》中的《伤寒杂病论十六卷》，是最原始整理之本，为王叔和在仲景逝后的3～5年开始，到公元235间完成整理的，书名为《张仲景方十五卷》，它保留着《伤寒杂病论》的全部内容或主要内容。因此书实用性极强和雕版印刷术的广泛使用，故一直流传至唐末犹存，曾录于《隋志》《旧唐志》《新唐志》，这一时期的书名为《张仲景药方》或《伤寒卒病论十卷》等。《仲景十六卷》较《叔和十五卷》并非遗失一卷，实因传抄时分并方法不同所致。传至北宋，《张仲景方十五卷》分为两大部分：第一部分即《伤寒论十卷》，《金匮玉函经》是《伤寒论》的“同体而别名”之作；第二部分即《伤寒杂病论》中之“杂病”，又称《金匮玉函要略方论》（今称《金匮要略方论三卷》）。二书为何均称“玉函”？因为六朝之人极为珍爱仲景书，而有“见宝爱之”意。以上足以证明，《伤寒论》《金匮要略方论》，原为《张仲景药方》的组成部分，为叔和亲撰次者，最接近张仲景《伤寒杂病论》的原貌，此乃生民之大幸也。

唐初孙思邈（公元581—682年）耗费几十年精力，终于把这个

《伤寒论》传本寻觅出来，加以标注，编进《千金翼方》卷九、卷十中（成书于公元682年），称唐本《伤寒论》，到现在已经一千三百多年了，是个极为重要的《伤寒论》传本。从条文顺序来看，与现在通行的《伤寒论》编排次序大不相同；但从内容来看，却与王叔和《伤寒论》无多大出入。对于校勘宋本《伤寒论》，补充宋本《伤寒论》的阙文，具有极为重大的意义。

北宋国力昌盛，印刷术发达，人才济济，整理校订了多种重要医学典籍。治平二年（公元1065年），孙奇、林亿校订的“张仲景《伤寒论》十卷”（称白文本），即《新唐书艺文志》著录的《伤寒杂病论》十卷。据传统说法，张仲景《伤寒论》中的十卷属于伤寒，六卷论述为杂病，有史可证。北宋元祐三年（公元1088年），《伤寒论》小字本问世，称宋本《伤寒论》，印数不多。明代万历年间（公元1599年），在宋本一发垂绝之际，藏书家、刻书家赵开美（江苏常熟人也），从名医沈南昉处得到了宋小字本《伤寒论》。遂复刻之，功莫大焉。传至今日只有五本，为尊重赵氏之功，大家均称其为“宋本《伤寒论》”，良可叹也。

以上节选于钱超尘教授的《伤寒论文献通考》。

金代成无己（公元1144年）见到《内经》《难经》，又见到王叔和的《伤寒论》，好像发现了“新大陆”，凭空臆想，把两个毫无关联的“经方”“医经”理论体系合二为一，引据《内》《难》来解释东汉张仲景的《伤寒论》，撰为《注解伤寒论》（简称《注本》）。到了明代晚期，赵开美将成氏本与宋本《伤寒论》小字本（又称“白文本”）同时刻印，成氏《注本》发行量比“白文本”要大得多，影响中医界四百多年，后世医家称其为“以经释论”的典范。成氏在《注本》卷首，大论“南北政脉应，运气加临汗差、棺墓、补泻病证诸图”“五运六气加临转移图”，并强调说“五运六气主病，阴阳虚实，无越此图”。对调胃承气汤、四逆汤的注释，引用《素问·至真要大论》中的经文进行方解。细标空谈，使人摸不着头脑，无法指导临床诊病处方。实际上，五运六气与古代历法、气候、气象有关。

南朝梁人陶弘景（公元456—536年），抄写于帛书上的《汤液经法》360首方剂中的60首，书名为《辅行诀脏腑用药法要》，1988年在河北威县被发现，中医界2000年来的最大疑惑，终大白于天下。冯世

纶教授考证："从《辅行诀》可以看到，张仲景从《汤液经法》的60首方剂中，选出36首方证，收入《伤寒论》，约占三分之二。证明'汉张仲景论广汤液为十数卷'确为事实。"

从叔和至治平二年，八百年间，《伤寒论》十卷之流传，历历可数，脉络清晰，基本完整。

小　结

《汉书·艺文志·方技略》记载有"医经七家，经方十一家"。我们今日目睹了伊尹《汤液经法》的60首方剂。据《甲乙经·序》记载，皇甫谧（公元215—282年）曾亲见《伊尹汤液》并阅读之，皇甫氏又亲见王叔和（公元210—280年）撰次《仲景遗论》。王叔和撰《张仲景药方》十五卷传至今日，仍现存有宋小字本《伤寒论》五本，最为接近东汉张仲景在公元219年完成的《伤寒杂病论十六卷》。一脉相承，眉目清晰。

《素问》第一部分，从文字讲为先秦的医学论文集，无作者，无人曾目睹过。王叔和见到的《素问》内容很少，仅有"辨脉法""平脉法""伤寒例"等，只能说"可以称是《素问》的"。南朝齐梁间人全元起（公元6世纪）见到了《素问》，对其重新编次并注，书名《素问训解》约70篇，此书亡佚于南宋。至此，《素问》有了第一撰次者。200年后，只有王冰见到此书，已是"错乱不堪"。王氏又重新编次并加入了《素问》的第二部分"七大论"，基本上是无方无药。同样在唐代，孙思邈、王焘见到了《神农本草经》和《伤寒杂病论》，而医学大家王冰对此却全然不知。

北宋雕刻印刷发达。景祐二年（公元1035年）七月，命丁度等校正《素问》，林亿以十余年之精力，撰成"重广补注"《素问》注本。北宋治平二年（公元1065年）刊刻颁行大字本《伤寒论》，纸墨价高。元祐三年（公元1088年）另行刊刻小字本《伤寒论》。从此结束了以手工传抄流行的历史。《素问》和《伤寒论》，在叔和逝世800年后相见恨晚。100年以后，成无己发现了"新大陆"，撰《注解伤寒论》（公元1144年成书）创"以经释论"，抓住王氏"七大论""以五运六气释伤寒"，并绘制了"运气图"。明万历二十七年（公元1599年），赵开美同

时复印了《注解伤寒论》和小字宋本《伤寒论》，前者印量比后者大得多，误人四百多年。不知今日是否还有医生以“五运六气图”为患者诊病。

张仲景3世纪初据《伊尹汤液》完成《伤寒杂病论》巨著。史上首次目睹《素问》的医家为南朝齐梁间人全元起，其整理撰次《素问训解》的时间，已是公元6世纪。两部经典面世，上下相差300年。钱超尘教授考证：“《张仲景原序》中，撰用《素问》至‘平脉辨证’计23字，为后人所增入，已成定论。”孙思邈《备急千金要方·序》标明引用仲景《伤寒论·序》，无此23字。日本古本《康平本伤寒论·序》将此23字改为小字嵌注于“勤求古训，博采众方”八字之下。我们得到的答案是：仲景未见过《素问》，叔和《素问》非王冰《素问》，用王冰《素问》来解仲景《伤寒论》，二者相差500年，好像是“关公战秦琼”。

《高等中医院校教材参考丛书》（李培生主编，人民卫生出版社1987年出版）讲：“张仲景继承了《内经》等理论，结合自己的临床实践，写成了《伤寒杂病论》，从而奠定了辨证论治的基础。”此说法有失严谨，张冠李戴。胡希恕先生拨云见日，在20世纪60年代即已指出：“仲景书本与《内经》无关，《伤寒论》的六经来自八纲。”“经方理论是有别于医经理论的经方理论体系。”“经方理论用辨证施治，医经理论用辨证论治。”是也！

第二节　以八纲释伤寒

1963年上半年跟胡希恕先生实习时，老师经常讲：“万病不离八纲，万病不离六经。汉以前的经方，只用八纲辨证，《伤寒论》的六经来自八纲。”时过境迁，今就《伤寒论》中的阴、阳、表、里、寒、热、虚、实，做了一个详细统计，足以证明胡老的这一论断正确无误。

宋本白文《伤寒论》398条，113方（缺禹余粮丸），计13404个字。八纲，即阴、阳、表、里、寒、热、虚、实，分别单独出现867次左右。兹具体介绍如下：

一、阴、阳

《伤寒论》中阴、阳共出现311次（阴：99次；阳：212次），占八纲总数的35.9%。

“阴”：三阴病病名用65次，证候用34次。

“阳”：三阳病病名用161次，证候用51次。

“阴、阳”的脉象：“脉阴阳俱紧者，名为伤寒”（3）；“风温为病，脉阴阳俱浮”（6）；“太阳中风，阳浮而阴弱，阳浮者，热自发，阴弱者，汗自出”（12）；“脉微而恶寒者，此阴阳俱虚”（23）；“太阳病未解，脉阴阳俱停”（94）；“伤寒，阳脉涩，阴脉弦，法当腹中急痛”（100）；“太阴中风，四肢烦疼，阳微阴涩而长者，为欲愈”（274）；“脉浮而芤，浮为阳，芤为阴，浮芤相搏，胃气生热，其阳则绝”（246）。

“阴、阳”证候的论述：“病有发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也”（7）；“病发于阳，而反下之，热入因作结胸；病发于阴，而反下之，因作痞也”（131）；“凡厥者，阴阳气不相顺接，便为厥。厥者，手足逆冷者是也”（337）；“病在阳，应以汗解之”（141）；“阳气怫郁在表，当解之、熏之”（48）；“脉微弱者，此无阳也，不可发汗”（27）；“若复服，汗多亡阳”（38）；“若重发汗，亡其阳，谵语”（211）；“医以火迫劫之，亡阳，必惊狂，卧起不安者”（112）；“发热而利，其人汗出不止，死，有阴无阳故也”（346）；“脉阴阳俱紧，反汗出者，亡阳也”（283）；“两阳相熏灼，其身发黄。阳盛则欲衄，阴虚小便难，阴阳俱虚竭，身体则枯燥”（111）；“但阳脉微者，先汗出而解；但阴脉微者，下之而解”（94）；“阳绝于里，亡津液，大便因硬也”（245）；“脏结无阳证，不往来寒热”（130）；“表里俱虚，阴阳气并竭，无阳则阴独”（153）；“伤寒，阳脉涩，阴脉弦，法当腹中急痛”（100）；“凡病，若发汗，若吐，若下，若亡血，亡津液，阴阳自和者，必自愈”（58）。

二、表、里

《伤寒论》中表、里共出现101次（表：58次；里：43次），占八纲总数的11.6%。

“表”（包括“外”）的脉象：“脉浮者，病在表”（51）；“浮为在外”（45）。脉浮有22次；脉浮的复合脉有33次，即为脉浮大、脉浮而大、脉浮紧、脉浮而紧、脉浮缓、脉浮而缓、脉浮数、脉浮而数、脉浮滑、脉浮虚、脉浮虚而涩、脉浮而涩、脉浮而芤、脉浮而动数、脉浮而迟、脉浮细、脉浮弱。

“表”证的论述：“表证仍在，此当发其汗”（46）；“脉浮者，以汗解之”（394）；“头痛，发热，微盗汗出，而反恶寒者，表未解也”（134）；“太阳病，下之微喘者，表未解故也”（43）；“伤寒大下后，复发汗，心下痞，恶寒者，表未解也”（164）；“阳明病，脉迟，汗出多，微恶寒者，表未解也，可发汗”（234）；“脉促者，表未解也”（34）；“伤寒表不解，心下有水气”（40）；“太阳病，外证未解，脉浮弱者，当以汗解也”（42）；“仍在表也，当须发汗”（56）；“太阳病，外证未解，不可下也，下之为逆”（44）；“伤寒脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急，反与桂枝，欲攻其表，此误也”（29）；“干呕，短气，汗出不恶寒者，此表解里未和也”（152）。

“里”的脉象：“沉为在里”（218）；“脉沉，亦在里也”（148）；“脉细沉数，病为在里”（285）。脉沉有6次，脉沉的复合脉有13次：脉沉迟、脉沉而迟、脉沉弦、脉沉微、脉沉结、脉沉滑、脉沉紧、脉虽沉紧、脉沉而紧、脉沉实。

“里”证候的论述：“脉沉而喘满，沉为在里”（218）；“脉沉实者，以下解之”（394）；“病为在里，不可发汗”（285）；“少阴病，脉沉者，急温之，宜四逆汤”（323）；“明日又不大便，脉反微涩者，里虚也”（214）；“尺中脉微，此里虚”（49）；“伤寒脉浮滑，此以表有热，里有寒”（176）；“小便少者，必苦里急也”（127）；“阳明病，脉迟，虽汗出不恶寒者，其身必重，短气，腹满而喘，有潮热者，此外欲解，可攻里也”（208）；“伤寒发汗已，身目为黄，所以然者，以寒湿在里不解故也”（259）；“病发热，头痛，脉反沉，若不差，身体疼痛，当救其里，四逆汤方”（92）；“须表里实，津液自和，便自汗出愈”（49）。

三、寒、热

《伤寒论》中寒、热共出现403次（寒：192次；热：211次），占八纲总数的46.4%。

“寒”的脉象：“脉迟为寒”（333）；“脉沉微”（61）；“脉沉迟”（62）；“脉迟浮弱，恶风寒”（98）；“脉浮而迟”（225）；“脉浮”（1）；“脉浮紧”（16、38）；“脉阴阳俱紧 ”（3）；“脉沉”（305、323）；“脉细欲绝”（351）。

“寒”证候的论述：“病人身大热，反欲得衣者，热在皮肤，寒在骨髓也；身大寒，反不欲近衣者，寒在皮肤，热在骨髓也”（11）；“太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒、体痛、呕逆、脉阴阳俱紧者，名为伤寒”（3）；“脉微而恶寒者，此阴阳俱虚，不可更发汗、更下、更吐也”（23）；“少阴病，得之一二日，口中和，其背恶寒者，当灸之，附子汤主之”（304）；“寸脉微浮，胸中痞硬，气上冲喉咽不得息者，此为胸有寒也”（166）。

《伤寒论》一书，对“寒”的描述，是多么详尽：伤寒97次、恶寒29次、不恶寒13次、发热恶寒9次、有寒7次、往来寒热6次、无热无寒1次、热多寒少2次、里寒外热2次、久寒1次、脏寒1次、振寒1次、中寒2次、手足寒2次、手足厥寒1次、胃中寒冷1次、寒下1次、寒分1次、寒格1次、寒饮1次、寒栗1次、寒湿2次等。

“热”的脉象：“数则为热”（134）；“病人脉数，数为热”（122）；“脉浮，发热”（227）。

“热”证候的论述：“太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病。若发汗已，身灼热者，名风温”（6）；阳明病“身热，汗自出，不恶寒反恶热也”（182）；“日晡所发热者，属阳明也”（240）；“阳明病，谵语，发潮热，脉滑而疾者，小承气汤主之”（214）；“伤寒十余日，热结在里，复往来寒热者，与大柴胡汤”（136）；“发热七八日，虽脉浮数者，可下之”（257）；“若脉数不解，而下不止，必协热便脓血也”（258）；“脉数，其热不罢者，此为热气有余，必发痈脓也”（332）；“下利脉数，有微热汗出，今自愈”（361）。

《伤寒论》对热的描述，在“八纲”中为首位：发热51次、发热汗出9次、发热恶寒9次、发热无汗3次、无大热6次、微热8次、身热5次、潮热7次、往来寒热6次、里寒外热2次、表里俱热1次、日晡所发潮热3次、日晡所小有潮热1次、面色缘缘正赤1次、面色反有热色1次、瘀热

在里3次、胸中有热1次等。

四、虚、实

《伤寒论》中虚、实共出现52次（虚：32次；实：20次），占八纲总数的6%。

“虚”的脉象：“脉虚”（347）；“寸口脉浮而大，浮为风，大为虚”（30）；“尺中脉微，此里虚”（49）；“脉反微涩者，里虚也”（214）；“尺脉弱涩”（286）；“脉弦者生，涩者死”（212）；还有细脉、浮虚、浮涩、浮虚涩、脉迟、脉浮弱、微细、微细沉、微弱细数、弱脉等。

“虚”证候的论述：“发汗吐下后，虚烦不得眠”（76）；“虚则郑声”（210）；“下利后更烦，按之心下濡者，为虚烦也”（375）；“诸四逆厥者，不可下之，虚家亦然”（330）；“发汗后，恶寒者，虚故也”（70）；“诸亡血、虚家，亦不可与”（168）；“脉微而恶寒者，此阴阳俱虚，不可更发汗、更下、更吐也”（23）；“阴虚小便难”（111）；“小便白者，以下焦虚有寒”（282）；“其面戴阳下虚故也”（366）；“胃中虚冷故也，其人本虚，攻其热必哕”（194）；“虚故饮水自救”（282）。

“实”的脉象：“脉实者，宜下之”（240）；“脉沉实者，以下解之”（394）；“伤寒，下利日十余行，脉反实者，死”（369）。

“实”证候的论述：“阳明之为病，胃家实是也”（180）；“正阳阳明者，胃家实是也”（179）；“少阳阳明者，发汗、利小便已，胃中燥，烦、实，大便难是也”（179）；“不更衣，内实大便难者，此名阳明也”（181）；“不恶寒，但热者，实也”（70）；“潮热者，实也”（104）；“夫实则谵语”（210）；“伤寒六七日，目中不了了，睛不和，无表里证，大便难，身微热者，此为实也。急下之，宜大承气汤”（252）；“伤寒六七日，结胸热实，脉沉而紧，心下痛，按之石硬者，大陷胸汤主之”（135）；“寒实结胸，无热证者，与三物小陷胸汤”（141）；“大实痛者，桂枝加大黄汤主之”（279）；“若自下利者，脉当微厥，令反和者，此为内实也”（105）；“手足寒，脉弦迟者，此胸中实”（324）；“阳脉实，因发其汗，出多者，亦为太过。太过者，

为阳绝于里，亡津液，大便因硬也”（245）；“脉实，热甚，而反灸之，此为实。实以虚治，因火而动，必咽燥，吐血”（115）；“下之过早，语言必乱，以表虚里实故也”（217）；“伤寒四五日，脉沉而喘满，沉为在里，而反发其汗，津液越出，大便为难，表虚里实，久则谵语”（218）；“须表里实，津液自和，便自汗出而愈”（49）。

五、八纲在《伤寒论》中出现次数的统计表

八纲	阴	阳	表	里	寒	热	虚	实	总计
次数	99	212	58	43	192	211	32	20	867
合计	311		101		403		52		
所占比例	35.9%		11.6%		46.5%		6.0%		

注：“阴”中病名用65次；“阳”中病名用161次。

统计显示：①八纲中辨“寒热”为第一要义，占46.5%。其一，寒与热，是192 ： 211，《神农本草经》的草药的药性，有寒、热、温、凉，必须以草药的“寒”治疾病的“热”，草药的“热”治疾病的“寒”。其二，“伤寒”用97次强调病之始，多被“寒”邪所伤，病人来到医院看病时，已经发“热”了，故“热”用了211次，符合实际情况。其三，“寒”“热”的病情，必须反映于病位（表、里、半表半里）。如“热结在里”（136）；“表里俱热”（168）；“里有寒”（176）；“寒在皮肤”（11）；“胃中寒冷”（380）等。②八纲中辨“阴、阳”为第二位，占35.9%，若减去六经病名所用的阴与阳外，实际上寒与热是31 ： 54，说明《伤寒论》中阳比阴重要，故用参、草、姜、枣保胃气，存津液；用附子、干姜回阳温阳。③八纲中辨“表、里”，表与里是58 ： 43，说明表证比里证多。④八纲中辨“虚、实”，占6.0%，虚与实是32 ： 20，说明虚证比实证多。

六、《伤寒论》中有关脏腑的论述

《伤寒论》中有关脏腑的论述少之又少，细读398条，有关脏腑的论述是既零乱又不具体，并且缺少一个肾脏。“肝乘脾”1次（108）；“肝乘肺”1次（109）；“脾约”1次（179）；“脾为约”1次（247）；“脾家实”1次（278）；“心动悸”1次（177）；“心下悸”5次（64、82、96、127、356）。而“心下痞”“心下痛”“心下必痛”“心下急”“心下满”“心下硬”共用十九次，均指胃脘。“脾胃气”“胃气”“胃中干”“胃中冷”“胃中燥”“胃中虚”“胃家实”“胃中不和”“胃中干燥”“胃中水竭”“胃中寒冷”“胃中有邪气”“胃中有燥屎”“胃中必有燥屎五六枚”“燥屎在胃中”，均指消化道。

仅凭上述对脏腑的全部描述，来解释《伤寒论》的400个证候和相似症状（有效证和症状二百余个）及58种脉象（脉暴出、脉不还、脉不负等除外），无论怎样讲，都是讲不通的。

金代成无己编著《注解伤寒论》（成书1144年），为全注《伤寒论》的第一家，被誉为“以经释论”典范。其依据《伤寒论·张仲景自序》中，“勤求古训，博采众方，撰用《素问》《九卷》《八十一难》《阴阳大论》《胎胪药录》，并平脉辨证，为《伤寒杂病论》合十六卷”。硬将《内经》《难经》的理论，塞进了《伤寒论》的临床诊治中，对后世的影响很大。

1948年，经学大师杨绍伊先生论述：“‘勤求古训，博采众方’这8个字是浑说，后面的23个字是详举。在文法中，凡浑说者不详举，详举者不浑说，不当浑说后又详举。上述23字为西晋太医令王叔和加入。”胡希恕先生十分赞同杨氏的观点并讲：“《汤液经》见于《汉书·艺文志》，晋代皇甫谧于《甲乙经·序》中谓：‘仲景论广《伊尹汤液》为十数卷，用之多验。’可见仲景著作大都取材于《汤液经》。”

20世纪70年代，《伊尹汤液》的部分内容出现了。（《汤液经》360首，《辅行诀》60首就是“《伊尹汤液》的部分内容”。）河北张大昌先生有家藏敦煌传抄本《辅行诀》，其中记载：“商有圣相伊尹，撰《汤液经法》，为方亦三百六十首……今检录常情需用者，六十首，备山中预防灾疾之用耳。”大师兄冯世纶教授研究《辅行诀》多年，发现张仲景从《辅行诀》的60首方剂中，选用了36首。也就是说，张仲景撰用的《汤液经》方证的三分之二为《伤寒论》。

中医古籍文献专家钱超尘教授通过文献研究发现，孙思邈《备急千

金要方·序》无上述23字。日本古本《康平本伤寒论·序》，将上述23字改为小字嵌注于“勤求古训，博采众方”八字之下。足以证明杨绍伊先生的论述，确无疑义。

至此，成无己据《内经》《难经》注解《伤寒论》之谬种流传，终大白于天下，“以经释论”者，可以休矣。

第三节　“八纲释六经”解

孔孟之道易明，仲景六经难解。注释伤寒六经的学说，有近30种之多。说者争奇斗艳，学者眼花缭乱，使人看不见，摸不着，越读越糊涂，深奥费解，不知如何是好！遂介绍如下：

1.前人关于六经的认识：经络说、脏腑经络说、六气说、经界说、形层说、八纲分证说、治法分经说、正邪相争说、标本中见说、五运六气说。

2.近世医家的见解：脏腑经络气化（经络、脏腑、脏腑经络气化结合、脏腑气机升降）；病证分类（六病、症候群、综合体说、病理层次、阴阳消长、邪正斗争、病证结合说）。

3.引用新说：巴甫洛夫学说、应激学说、时空概念、模糊聚类、数学集合论、神经病理单位、逻辑学推理、非特异性的时相过程。

前人注释《伤寒论》六经，多以经络说、经络脏腑说、经络脏腑气化说，详解三阴、三阳的实质，认为伤寒六经主要是经络病变。其代表医家始于宋朝的朱肱，他在其撰《伤寒类证活人书》（成书于1108年）第一卷指出：“治伤寒先须识经络，不识经络，触途冥行，不知邪气之所在……《伤寒论》中所说的六经，即为足三阴三阳六条经络。”他往往从经络的循行部位，来解释伤寒六经的证候，并且直呼仲景的“太阳病”“阳明病”“少阳病”为“太阳经”“阳明经”“少阳经”等，影响较大。后世进一步“把六经联系上心、肝、脾、肺、肾、胃、胆、膀胱等脏器的生理机能和病理现象”；还说“六经气化离开了脏腑经络，就失去了物质基础”；“脏腑经络离开了气化，就反映不出其功能活动”；“《伤寒论》标本中见的气化学说，来源于《内经》的运气学说”；“伤寒六经传足不传手”。越扯越远，使人大有多歧之惑。

惜大多注家执意抓住经络不放，只要见到“经”字，就非说成经络不行。无可奈何，我们只有细读《伤寒论》有关经络的论述，“太阳病，头痛至七日以上自愈者，以行其经尽故也。若欲作再经者，针足阳明，

使经不传则愈”（8）；“到经不解”（114）；“发汗则动经”（67）；“太阳随经”（124）；“经脉动惕”（160）；“附子温经”（30）；“过经”（103、105、123、217）。以上10条论述，支离破碎，有经无络，互不联系，怎么看也看不出是经络。“先刺风池、风府”（24）；“当刺大椎第一间、肺俞、肝俞”（142、171）；“刺期门”（108、109、142、143、216）；“刺之小差”（231）；“可刺”（308）；“关元”（340）。以上11条所列穴位，既无取穴分寸，又无实际刺法。

依据上述仲景对经络的全部论述，分析如下：

1.《伤寒论》出现这21条的“经”和“刺穴”，只占“阴、阳、表、里、寒、热、虚、实”（单个出现867次）的2.4%，既是凤毛麟角，也微不足道。

2.《伤寒论》谓六经，并非《内经》所述十二经中的“足六经”。此六经在人体无病时，没有证候（《伤寒论·伤寒例第三》）发生，则无八纲和六经可辨。也就是说，人体无病时，《伤寒论》的六经是不存在的。而彼六经在人体无病时，经气仍在运行。《素问·举痛论》谓：“经脉流行不止，环周不休。”经气运行“起于中焦，出云门……至期门，（再）上注肺”，周而复始，如环无端，此二者无法相提并论。

3.仲景《伤寒论》的大标题，明明是“辨太阳病脉证并治”，而朱肱偏把“病”说为“经”。132万字的《高等中医院校教学参考·针灸学》硬是讲：“东汉张仲景所著《伤寒杂病论》，显然是在《内经》经络学说的实际运用上编著而成的，是经络学理论与实践相结合的产物。”但是，伤寒的六经病和八纲都是有脉象、证候、主治方证，“寒”“热”占八纲的46.5%。而《内经》的十二经或者足六经，都没有脉象和“寒”“热”。所述的是动病和所生病为痛、痹、肿、麻，并且无主治方证。具有代表性的足太阳膀胱经的病证是《灵枢·经脉》：“是动则病，冲头疼，目似脱，项如拔，脊痛腰以折，髀不可以曲，腘如结，踹如裂，是为踝厥。是主筋所生病者，痔疟狂癫疾，头囟项痛，目黄泪出鼽衄，项背腰尻腘腨脚皆痛，小指不用。”此二者有如天壤之别。

4.钱超尘教授考证：《伤寒论·序》中的“撰用《素问》《九卷》《八十一难》《阴阳大论》《胎胪药录》，并平脉辨证”计23字，以及“夫天布五行”至“夫欲视死别生，实为难矣”一段，非张仲景自撰，而为人所增入。证明中医文献学家杨绍伊对此“两段增文”的论证，确无疑

义。（《江西中医学院学报》2003年第19卷第二期、第三期）

5. 1989年，河北发现陶弘景（公元494年）手抄本《辅行诀》的传抄本，证明皇甫谧《甲乙经·序》“仲景论广《伊尹汤液》为十数卷，用之多验”。王应麟、姚振宗所考“皇甫谧所云，《伊尹汤液》即《汉书艺文志》之《汤液经法》”的记载真实可靠。

基于以上的讨论，可以看出，朱氏上千年的“经络释六经”无理论根据，纯属主观臆断，造成了以讹传讹，误至今日。经络的实质至今未能探明，临床处方无法联系实际。《辅行诀》的出现，证明了胡希恕先生的“《伤寒论》六经本与《内经》无关，六经来自八纲”“《伤寒论》属于不同于《内经》的独特的经方理论体系”，正确无疑。

胡希恕先生经过多年的潜心钻研，结合临证实际，独具慧眼，依据“八纲”，对“伤寒六经”有了明确而具体的诠释，看得见，摸得着，在中医临床工作中具有指导意义，兹介绍如下。

大凡疾病的发生，源于正气和邪气两个方面，“血弱气尽，腠理开，邪气因入，与正气相搏”（97），说明人体气血不足，邪气侵入，正气奋起抵抗，阴阳失和，导致疾病发生。疾病的发生，必有证候（《伤寒论》·伤寒例第三）。证候的病情在《伤寒论》里，约有200个症状（“症”者，病人患病时所发生的异常感觉，又称症状。“证”者，指患病时出现的互有联系的一组症状，或指一个主要症状。方证者，又称汤证，指方剂的适应证）。总的来讲，病情不外有阴、阳、寒、热、虚、实六个不同类型。病情必反映于病位，病位就是表和里。有病情必有病位，有病位必有病情，二者缺一不可。也就是说，无病位则无病情，无病情则无病位。

我们说的病情，“阴”和“阳”指病变的性质，有阴性证，有阳性证，不为阴，便为阳，但绝无不阴不阳者；“寒”和“热”指症状的表现，有寒证，有热证，也有不寒不热证；“虚”和“实”，虚指人虚、正气虚，实指病实、邪气实。这六者在疾病的发生、发展、好转、痊愈或死亡的过程中，是不断消长变化的，还可以相互结合出现，如阴虚、阴寒、阳盛（实）、阳虚、虚寒、实热等。

我们说的病位，是指“表”和“里”，在张仲景之前已有之，如发汗解表、清里热、温里寒。这个“表”和“里”是固定不变的，是绝对的，是病情反映的病位，但不是疾病发生的部位。如病变在里，但病邪集中地反

映于表位，《伤寒论》称之为表证。“病在表”（51）“表未解”（134），治疗“当须发汗”（56），“外（表）证未解，不可下也”（44）。反之，虽病变在表，但病邪集中地反映于里位，《伤寒论》称之为里证。“病为在里，不可发汗”（285），“以下解之”（394），“此外欲解，可攻里也”（208）。在《伤寒论》里，张仲景又发明了一个病位，叫半表半里。“必有表，复有里也……此为半在里半在外也”（148）。现在很多常见病、多发病，如高血糖、高血脂、高血压等慢性病，或老年慢性病，都集中地反映于半表半里这个病位。“口苦，咽干，目眩也”（263），“胸胁苦满，心烦喜呕”（96），“呕不止，心下急，郁郁微烦”（103）。此证源于多食少动及一部分服西药有反应者。

我们可以这样讲，无论什么病，也就是所有发生的疾病，在出现或发生、发展的时候，绝不出表、里、半表半里三个病位，称为表证、里证、半表半里证。若表、里、半表半里同时发病，称为“三阳合病”（219、268）。若表、里同时发病，称为“太阳与阳明合病”（32、33、36）。还有称表里证者，如“有表里证”（74），“无表里证”（252、257）。若表、半表半里同时发病，称为“太阳与少阳合病”（172）。若里、半表半里同时发病，称为“阳明、少阳合病”（256）。若前经病未罢，后经之证又起，则称为并病，如“二阳并病”（220）“太阳与少阳并病”（142、150、171），“本太阳病不解，转入少阳者”（266）。

胡老讲，病情有六纲，病位有三纲，加在一起，按数来讲，应该是九纲，习惯上以表里包含了半表半里，故简称八纲。八纲辨证实即六经辨证。万病不离八纲，不离六经。中医辨证施治的主要精神，是在罹病人体一般规律性反应的基础上，讲求更加适应整体的一般疾病的原则性通治大法。它的程序是：罹病人体的证候反应→八纲→六经→方证，辨方证是辨证的尖端。

胡老又讲，《伤寒论》的表、里、半表半里三个病位，为伤寒六经奠定了基础。张仲景并没有讲经络脏腑，而是发明了一个关键的半表半里。如果没有148条，有诸多脏器的广大胸腹腔的少阳病，是不好解释的，那“食即吐蛔，乌梅丸主之”的厥阴病，就更加费解了。也可以这样讲：“没有半表半里，就不能称其为伤寒六经。”

胡老关于“八纲释六经”的详解如下：

若正邪交争于人体广大体表的腠理、皮肤、肌肉、筋骨、肺泡之间，即为表证。其症状表现在“八纲”中为阳、实、热者，如脉浮、脉浮而数、脉浮紧、头项强痛而恶寒、汗出恶风、恶寒发热、头痛、身体疼痛、咳、喘、咽痛等，即称之为“发作着的太阳病”（胡老用语）；其症状表现在“八纲”中为阴、虚、寒者，如脉微细、但欲寐、恶寒、蜷卧、心烦、口中和、咽痛等，即称之为“发作着的少阴病”。肺之吸入空气部分，其喉、呼吸道及肺泡与外界相通，寒邪、温邪同样犯肺，应属于表证之病位，同样有太阳病和少阴病之分。肺之不能与空气接触的部分，应属半表半里之病位。

若正邪交争于人体的消化道，从咽、食道、胃、肠至后阴之中，即为里证。其症状表现在“八纲”中为阳、实、热者，如脉沉、脉沉实、胃家实、腹满、烦躁、大便硬、有燥屎、身热、汗多、口渴、潮热、不恶寒但恶热、便脓血等，即称之为“发作着的阳明病”。其症状表现在“八纲”中为阴、虚、寒者，如脉弱、腹满而吐、食不下、自利益甚、时腹自痛、脏有寒等，即称之为“发作着的太阴病”。

若正邪交争于表之内，里之外，广大的胸、腹腔之间，即为半表半里证。《伤寒论》第97条曰：“血弱气尽，腠理开，邪气因入，与正气相搏，结于胁下。”第148条称“此为半在里半在外也”。其症状表现在“八纲”中为阳、实、热、者，如脉弦、脉弦细、口苦、咽干、目眩、两耳无闻、往来寒热、胸胁苦满、不欲饮食、心烦喜呕等，即称之为“发作着的少阳病”。其症状表现在“八纲”中为阴、虚、寒者，如脉微而厥、脉细欲绝、消渴、气上撞心，心中疼热、饥而不欲食、吐蛔、四肢厥逆、手足逆冷、厥而呕等，即称之为“发作着的厥阴病”。

1965年，胡老讲课中提到，临床事实证明，尽管疾病的种类繁多，致病的因素复杂。但是，大凡疾病的发生和发展，均不外八纲和六经为证的范围，可于此给出原则性的施治大法。中医恒以一法而治多病，和治一病而用多法，即是这一精神的有力证明。从整体上讲，对常见病、多发病、慢性病，我们只认证候的表现，不管它是西医的什么病。在辨证处方时，只要在八纲和六经辨证的尺度准绳上，不出大的偏差，就有一定的疗效。反之，就很难讲了。

第四节　胡希恕先生1965年讲课手稿

一、辨证施治的基本概念

“辨证施治”这一名词，乃抽象地说明中医是以证为据的一种治病方法。不过此之所谓“证”，与众所熟知的“症状”大有不同。“症状”是指罹病人体有异于健康时的一切反应而言，如头痛、腹痛、发热、恶寒、脉浮、脉数等，均居其例。至于“为证”，乃是通过一系列的固定症状，对于疾病的一种认识，即包括表、里、阴、阳、寒、热、虚、实的八纲，和包括太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴的六经，都属于表达疾病不同内容为证的称呼。所谓“辨证”，就是依据患者当时所反映的症状，以辨其为病，是发作着八纲和六经里面的某个或某些证。所谓“施治”，亦即依此所辨明的证而给予合理有效的治疗方策。基于事实的证明，尽管疾病的种类繁多，致病的因素复杂，但凡病的发生和发展，总是不出于八纲和六经的为证范围。故以八纲和六经为尺度准绳的辨证施治，在人体无病时，是不可能进行辨证和施治的。其理之所在，暂置不谈。然即此事实，足以说明八纲和六经，均不外是罹病人体对于一般疾病的规律性反应。据此可知，中医辨证施治的主要精神即是于此罹病人体规律性的反应基础上，讲求一般疾病的通治大法。

例如，《伤寒论》曰：“太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒。 ”这即是说，患者若出现有脉浮、头项强痛而恶寒等一系列的症状时，即可辨它是发作着的太阳病。这是以六经名证，若按八纲而论，则可称之为表阳证。唯此所称的太阳病，并不是某一个别病变的专称，乃是具有同样证候的一般疾病的通称。当然亦可说，它是罹病人体对于疾病规律性反应上的一个共同环节，它经常以“脉浮，头项强痛而恶寒”等一系列的固定证候而表现出来。故无论什么样的病，只要出现这样的特征，便可以依据太阳病的发汗原则，而进行适方的治疗，是可以治愈的。中医恒以一法而治多病，及治一病而须多法，即是这一精神的有力证明。

以上所述，虽是辨证施治的主要精神，但还不能说是对于它的足够识认。八纲与六经固属辨证施治的尺度准绳，并可于此给出原则性的施治大法。于前讲过，凡病若确辨它是发作着的太阳病，便可依法施以发汗之法的治疗，是不会错的，不过可资发汗的方剂为数很多，是用桂枝汤、麻黄汤，还是葛根汤呢？难道任取一种发汗剂，即能治愈所有的表证吗？可以肯定地说，这是绝对行不通的。其实，前面已有进行适方治疗一语。所谓“适方”，即是适应整体治疗的一种方剂。也就是说，无论

任何一种治病的方法，必须选用适应整体情况的方剂而行之。如果以脉浮、头项强痛而恶寒为特征的太阳病，固然依法当行发汗，若同时伴有发热、汗出、恶风、脉缓等症状时，则宜治以桂枝汤；若同时伴有身疼、腰痛、骨节疼痛、恶风、无汗而喘、脉紧等症状时，则宜治以麻黄汤。此外，如葛根汤、大青龙汤、小青龙汤、越婢汤……虽同属于发汗的方剂，然有其不同的适应症状和选用的标准，若用得其反，不但无益，且足以为窘。某方剂的适应症状，即称之为某方的适应证，或简称之为某方证，如桂枝汤证、麻黄汤证、大青龙汤证……因此，中医的辨证施治，既须依据某些固定的特征，以辨八纲和六经而定施治的准则，还要基于整体的症状反应，详究所属方证，以行适方治疗。它的程序是：罹病人体的症状反应→八纲→六经→方证。若透视其治疗精神，可作这样的定义：辨证施治是于罹病人体规律性反应的基础上，而更适应整体地讲求一般疾病的通治方法。

二、有关八纲的概念

八纲即指表、里、阴、阳、寒、热、虚、实而言。不过表里的中间还须有一个半表半里。按数来讲，应该是九纲，习惯以表里含有半表半里，故简称为八纲。为了解说方便，兹分组条述如下。

1.表里和半表半里证：表是指人体外层的皮肤、骨肉所组成的广大身体表面而言。里是指最里面的胃肠所组成的消化道而言。半表半里是指表之内、里之外，即诸脏器所在的广大胸腹腔之间而言。未尝深究中医辨证的人，每易以在表的症状即认为是表证。同样，亦易误以在里或在半表半里的症状而分别认为是里证或半表半里证。这种看法实属大错，其实所谓表证、里证和半表半里证，均指该体部有了明显的病势所趋，或病邪集中的证候而言，虽然这种证候取决于症状的反映，但反映这种证候的症状，并非局限于该人体部位的。例如，在里的阴阳病，每以发潮热、濈然汗出等外在的症状而加以确认。中医常称表证为病在表或邪在表，亦常称里证或半表半里证，为病在里和病在半表半里，或邪在里和邪在半表半里，均是这个道理。至于它们为证的证候，说来确实复杂，尤其下面所述的阴阳、寒热、虚实是分不开的。由于表、里和半表半里为疾病的一般病位反应，而阴阳、寒热、虚实为一般的病情反应。也就是说，凡病的发生和发展，罹病人体的病情反应，在病位上，

则不出表、里和半表半里；在病情上，则不出阴阳、寒热、虚实。病情势必见之于病位，病位即因病情而始显。故表证、里证和半表半里证，均可有阴阳、寒热、虚实的不同证候反应，详见以下各条。

2.阴证和阳证：阴、阳是互相对应的两个抽象名词，古人常用来说明普遍存在于万事万物中的矛盾现象。例如，水为阴，火为阳；静为阴，动为阳；沉伏为阴，发扬为阳；后退为阴，前进为阳。总的来讲，大都以阴表示不足或消沉的一面，以阳表示有余或升发的一面。中医辨证则取其为“法”之义，用以鉴别常相对立的两种病证，而此病证可经常见于各种症状之上。如以气色而言，颜面苍白为阴，颜面红赤为阳；如以声音而言，语言低微为阴，语言高亢为阳；如以饮食而言，不饮不食为阴，嗜饮嗜食为阳；如以便溺而言，便溏溺白为阴，便难溺赤为阳；如以寒热而言，身寒恶寒为阴，身热恶热为阳；如以脉象而言，沉、迟、虚、涩等不及的脉象为阴，浮、实、大、滑等太过的脉象为阳；诸如此类，甚易理解，无须更多举例。

3.寒证和热证：寒即寒性，热即热性之义。基于以上的说明，寒自属于阴，热自属于阳。故所谓寒、热，即为阴、阳更细微的区分。如上述的身寒、恶寒固属阴，但就个别的属性而言，则为身热、恶热固属阳，但就个别的属性而言则又为热。余可类推，此不赘述。

4.虚证和实证：虚指人体的精力虚，故所谓虚证，即病犹未解，体力已见不支，而显示精力虚衰的一种象征。实证指为病的气象实，故所谓实证，即病势虽盛，体力亦在加强抗拒，而显示病气充实的一种象征。此亦与寒热一样，以其个别的属性，是从阴阳中划出的一类。如上述的语言低微固属阴，若就个别的属性而论，则为虚；语言高亢固属阳，若就个别的属性而论，则为实。

三、有关六经的概念

六经即指《伤寒论》所述的太阳、阳明、少阳三个阳病，和太阴、少阴、厥阴三个阴病而言，由于这些病名与十二经络的称呼相同，历代多数医家认为是足六经的病，并谓“伤寒传足不传手”。然仲景著书时的取名用义，固难深知，但通过他全书的论述精神和长期临床的实践证明，可以肯定它们是罹病人体反应一般疾病的六种类型。而且与上述的

八纲，是不可分割的统一体。如前所述，表、里和半表半里，均可有阴、阳、寒、热、虚、实不同病情的为证反应。由于热与实皆属于阳，寒于虚皆属于阴，以是表证、里证和半表半里证，又可归纳为各有阴阳的两大类型。六经里面的三阳病，即表、里、半表半里的三阳证。六经里面的三阴病，即表、里、半表半里的三阴证。可见，八纲是对疾病的明细分析，六经是对疾病的概要分类。既无病不可绳之以八纲，当然亦无病不属于六经之分类。（编者注：没有不属于八纲的病，也没有不属于六经分类的病。或所有的病都有八纲，所有的病都在六经分类之内。胡老讲课常说：万病不离八纲，万病不离六经）以下再就《伤寒论》的原文，逐一明释之。

太阳病：《伤寒论》曰："太阳之为病，脉浮，头项强病而恶寒。"太阳病的大意在辨证论治的基本概念中，已有较详的说明，读者可互参，不再重释。今就它与八纲的关系讨论一下。太阳病即是表阳证，故此提出的"脉浮，头项强痛而恶寒"等一系列的固定症状，亦即表阳证最基本的特征。也就是说凡属表阳证，无论它是否兼有热或实，这是它必具的起码反应。当然，若在兼有热或实的情况下，还需另见热性或实性的证候，而且需同时反映出来。故于实际临床时，既需辨明六经，还更需辨八纲，就是这个道理（以下各经同理，不另加说明）。

阳明病：《伤寒论》曰："阳明之为病，胃家实是也。"胃家实谓病实于胃肠的里面，即指腹满，大便难的里实证而言。阳极于里终必至于实，以此标示阳明病，自属最确切不过。但182条又曰："阳明病外证云何？答曰：身热、汗自出，不恶寒反恶热也。"此阳明病的外证，即对照以上胃家实说的。阳热在里，还未成实的病，当然无胃家实在里的特征，而只能以其反映于外的证候辨之。此身热、汗自出、不恶寒、反恶热等一系列的固定症状，即为里阳证最基本的外在反映。凡病若是呈现胃家实，故可谓是发作着的阳明病，若有此外证，虽无胃家实，亦得谓是发作着的阳明病。

少阳病：此即半表半里的阳证。《伤寒论》曰："少阳之为病，口苦，咽干、目眩也。"阳热郁积于半表半里，外不得以出表，内不得以入里，势必循孔道而上迫头脑，口苦、咽干目眩是其定则的常有反应，少阳病的证候以此为最基本的特征。凡病由此特征者当以少阳病视之，便不会错误的。

太阴病：此即所谓里阴证。《伤寒论》曰："太阴之为病，腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛，若下之，必胸下结硬。"即是说：太阴病是以腹泻而吐、食不下、自利益甚、时腹自痛等一系列的证候为特征。若罹病人体有了上述的特征反应，即可确认为它是发作着的太阴病。

少阴病：本手稿缺。（作者在中国中医药出版社2015年出版的《胡希恕伤寒论方证辨证》一书中，收有胡老的《少阴病解》一文）

厥阴病：本手稿缺。（请参考人民军医出版社2015年7月出版的第二版《胡希恕讲伤寒杂病论》第23页）

第五节　汗与溺的相互关系——胡希恕先生1963年讲课手稿

汗、溺与气（呼出的一部分水气）都是人体排出的液体废物，合泣与唾，古人称为"五液"。《灵枢》谓："邪气内逆则气为之闭塞而不行，不行则为水胀。"事实亦确是这样。由于这种废物的排泄障碍，而引起的疾病很多，水胀只是更为显著的一例而已。众所周知，人身的体液是有基本恒量的废物，应该排出。若过量外泄可致津液虚损，甚者为虚脱之变，故天寒则溺多而汗必少，天热则汗出多而溺亦必少。相互制约以成永恒，此亦生理的妙机，乃健康人的一般情况。若在发病过程中则不然，不但每致这种正常规律发生紊乱，而且在其相互影响的关系下，常使病理的发展趋于复杂化。这一事实对于临床来讲，颇为重要，谨择要概述如下。

一、小便不利则汗不出

水停不下则气化不行，内失宣畅则外不通达。故小便不利者，每致汗不得出。病在表时，依法当行汗解，但在小便不利的情况下，虽施发汗之剂而汗常不出，则病亦不解，甚或激发剧变。此时，唯有依证选用利尿方药，利其小便则水行气畅，汗自透达，不求治表而表自治。

二、小便数则汗自出

北窗大张则南风自入，小便频数则汗常不禁。此与上述正成对比，病见此情，已有津液内竭之渐，故在表之证不可汗，而在里之证亦不可下。不慎妄用攻破，祸复立至，不可不知也。

三、汗不出则肺气伤

如前所述，汗与气，皆人体必须排出的废物。若表气闭塞而汗不得出，肺常代替之而排出，既加重肺机能上的负担，又遭受过量废物的有毒刺激，肺又焉得无伤，于是咳大作矣。故治肺疾最忌固表，尤其是风寒外闭，因而诱致咳喘发作者，宜发汗解表。

四、肺气虚则小便不禁

此即上虚不能制下之证，法宜和之以温，最忌温补。

五、表气畅则小便行

于上一节曾言，小便不利者，虽发汗而汗常不出，但那是指在表之证而言。若肾机能有了障碍，在小便不利时，发汗透表可以减轻其一些负担，肾脏机能得以恢复，反而能通利小便。此与发汗以治肺同一道理。故同一小便不利，在表证者不宜于汗，在里证者反而宜于汗。经所谓："病在外者求诸内，病在内者求诸外。"此即其义，屡以越婢加术汤治慢性肾炎收速效，请同道尝试之。

第六节　"但见一证便是，不必悉具"之我见

小柴胡汤的适应证相当广泛。①有少阳病提纲三症："口苦，咽

干，目眩也。”（263）四个主症：“往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕。”七个或症：“或胸中烦不呕，或渴，或腹中痛，或胁下痞硬，或心下悸、小便不利，或不渴、身有微热，或咳者，小柴胡证主之。”（96）还有欲眠睡（268），嗜卧（37、231），一共16个症和或症。方后还有七个随证加减法。②又可治：太阳与少阳并病（171）、合病（172）。③还可治坏病：“太阳病，过经十余日……柴胡证仍在者，先与小柴胡汤” （103），“伤寒十三日不解……此本柴胡证……先宜服小柴胡汤以解外”（104），“阳明中风”（231），“妇人中风”（143、144），“新产妇大便坚，呕不能食”（《金匮要略·妇人产后病脉证治第二十一》），“妇人在草蓐自发露得风，四肢苦烦热，头痛者”（同上）。④《伤寒论》小柴胡汤有18条经文，《金匮》有3条经文。太阳病、少阳病、厥阴病、差后劳复病、产后病都有小柴胡汤的身影。

基于以上的统计，说明小柴胡汤方证的适应证非常广泛。“桂枝汤为天下第一方”，应该让位于小柴胡汤。因为临床上能见到的原发病很少，我们所见的病基本上是“坏病”，麻黄证、桂枝证发病，病程很短，来我院就诊时已经“过经”了。《伤寒论》曰：“太阳病三日，已发汗，若吐，若下，若温针（现在是吊针），仍不解者，此为坏病，桂枝不中与之也。”（16）“伤寒二三日，阳明，少阳证不见者，为不传也。”（5）“太阳病至七日以上自愈者，以行其经尽故也。”（8）“风家，表解而不了了者，十二日愈。”（10）然而仲景又讲：“过经十余日，柴胡证仍在。”（103）“太阳病，十日已去，脉浮细而嗜卧者，外已解。设胸满胁痛者，与小柴胡汤。”（37）“伤寒十三日不解，此本柴胡证。”（104）在这种情况下，仲景把“但见一证便是”给了柴胡证，柴胡证有八张方剂，这里显然是指小柴胡汤。因其治疗范围甚广，故很有必要强调“但见一证便是”。因适应证众多，故又强调“不必悉具”，其他七张方剂都没有这个“资格”。

《伤寒论》101条：“伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具。”

“伤寒中风”，即病来自伤寒或中风，还有“坏病”。“有柴胡证”，指小柴胡汤证。

单独讲“证”即症，表示病人患病时所反应的异常感觉，如发热，头

痛，呕等。“证”，《伤寒论》称证候，现在又称症状。若证前有名，证属名义。表示患病时出现的互有联系的一组症状，或指一个主要症状，如表证、里证、虚证、实证、无表里证、无少阳证、中风证、瘀热在里证、寒湿在里证等。“方证”，又称汤证，是方剂的适应证，如柴胡证、桂枝证、小柴胡汤证、白虎汤证、真武汤证等，都有各自的适应证。

“但”：即只、仅仅、特，为突出重点之意。《伤寒论》中，仲景一共用了三十七个“但”字，94条和136条，每条都用了两个“但”字，可知“但”字在文中的重要性。在101条中，“但见”之前应有“不见”，即在不见表证也不见里证的前提之下，“但见一证便是”。如果即使有表里证，也应该是“或证”，或者是轻微的不重要的兼证。

“一证”：“一”不是“二”，“一证”不是“二证”，此“证”即是“症”。此处“一证”，应该是：“口苦，咽干，目眩，往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕”七个主证之一。本条的七个“或证”，为可有可无，若有也是兼症。

“便是”：便即顺利、便捷，有“顺理成章”，“简便迅速”，“不可怀疑”，“不可否定”之意。“是”即正确、不错，“是”与“非”相对，为加强肯定之词。本条中的“一证便是”，即为辨方证要抓主证，立刻治疗，不会有错，肯定有效。

“不必”：即“不一定”“没有必要”“不需要”。“悉具”：即“全部”“齐备”“无缺”。“不必悉具”：即不需要也没有必要等待诸证全部齐全无缺之后，才可以使用小柴胡汤。

通过以上的字斟句酌，对101条可以做如下解释。

病不论来自伤寒、中风还是坏病，若有半表半里少阳病的小柴胡汤证，在没有明显表证或里证的情况下，只要见到七个主证之一的“一证”，就可以明确诊断，处方治疗，是不会出错的。因其适应证较多，没有必要等诸证齐全之后再使用。如此，可以扩大小柴胡汤的应用范围，肯定会取得很好的疗效。有是证，必用是方就是辨证施治。也无须再加注其他的理论，多加说明。诸如其他各大方证，都可照此进行，“但见一证便是”“抓主证而施治”。仲景原序曰：“见病（证）知源，请事斯语。”

230条讲小柴胡的作用机理是“上焦得通，津液得下，胃气因和，身

濈然汗出而解”。胡希恕先生讲小柴胡的功效是“保胃气，存津液，扶正祛邪”，用药要“无犯胃气及上二焦”。我从事临床多年，有一张经常遭遇的小柴胡汤应用方——小柴胡加银牛荆豆方，即小柴胡原方加金银花、牛蒡子、荆芥或荆芥穗、淡豆豉，如下：

柴胡12～15g，黄芩10～15g，半夏10～12g，党参10g，炙甘草6g，鲜生姜3大片，大枣4～6枚，金银花12～15g，牛蒡子12～15g，荆芥或荆芥穗4～6g，淡豆豉10～12g。若有热或渴或苔腻者，酌加生石膏30～40g。

水煎18分钟左右，温服。遵桂枝汤服药法，服第一次药时，盖被出小汗，微微似汗出，服第二次药时不必取小汗。

本方的治疗范围，除上述少阳病提纲三证及四个主证以外，还有“伤寒十三日不解”（104），“欲眠睡”（268），“嗜卧”（37），“伤寒差以后，更发热”（394）。临床症见：身体素弱，脾胃虚弱，气血不足，或有慢性病，经常感冒，来诊时已错过“发表”的机会，或汗后表不解，或急性感冒后又重感，或用过抗生素后仍表不解……这些患者无典型的“四大主证”，而是背部微冷，继而喷嚏，流清涕，全身酸楚，困乏无力，欲眠睡，嗜卧，胃口差不欲食，苔薄白，脉细数无力。还有感冒自己服药多日不愈，手术后感冒、月经期前后感冒、产后感冒、小儿脾胃虚弱感冒等，但无明显的咳嗽，二便正常。

下面列举几例临床验案兹以证明。

1. 陈慎吾**89**岁母亲感冒发烧案：1963年7月，陈慎吾老师在江西开全国中医会议，其89岁母亲突发感冒，孙志洁老师约我前诊。症见头晕且痛，胸胁逆满，心烦喜呕，但发热不寒，口干燥，脉数苔白，纯属温热证象，以柴胡汤证具，与小柴胡汤原方加生石膏一两半，服之，一剂病愈。过十余日，因连进肉面食物，病复发，尤胜于初，大汗出，心烦躁，颇似虚脱景象，舌燥苔黄，脉弦细而数，再与小柴胡加生石膏汤，连进二剂，又复痊愈。（详见《胡希恕伤寒论方证辨证》116页）

2. 小儿感冒发烧案：2016年腊月二十九日，住同一小区的雒家，其姐住阜康市，离我们80公里。姐姐的小孙女一岁半，已发冷发热二天，已经输过抗生素无效。老雒急来我家求治，通电话得知，孙女有往来寒热，发烧时39.8℃，汗出后仍38℃，时有恶心，纳食很少，不咳嗽，二便调，与小柴胡汤二剂，一剂烧退，二剂而愈。处方：柴胡6g，

黄芩6g，法半夏3g，党参4.5g，炙甘草3g，荆芥穗3g，淡豆豉5g，鲜生姜2片，红枣3枚（擘）。水煎15分钟，取汁200mL，一日内分三次口服，药汁置至室温，若药汁热易吐。

3. 感冒发烧抽搐案：2018年5月30日上午门诊，阿拉法，男，4岁11个月，维吾尔族。其母含泪而诉：孩子自年初至今，反复发烧抽风，5个月内已住院4次。每次发烧39.5℃或40℃时，手足四肢发凉，随即面色灰青，咬牙很紧，两眼发直，抽搐数秒或十多秒钟，真吓死我了，住院打针，汗出烧退。第4次住院小儿科，说是咽峡炎，但化验检查均属正常。昨晚深夜，先发冷后发烧至39℃，因害怕抽风，夜里3点来本院急诊科观察，血常规正常，肌注柴胡注射液一次出汗后烧退至38℃。早上我刚上班，即来求诊：患儿人瘦面黄，精神很差，有轻微恶心不想吃，不咳嗽，脉浮细数，素有便秘史，已二日未大便，尿少。我建议收住院治疗，其母说才出院几天。于是给小柴胡加银牛荆豆方加生石膏，以及王氏保赤丸。

柴胡6g，党参6g，法半夏3g，黄芩6g，炙甘草3g，金银花8g，牛蒡子6g，荆芥穗3g，淡豆豉6g，鲜生姜3片，红枣4枚（擘）。三剂，水煎服。

嘱：楼下有水，先服王氏保赤丸30丸，便通即停药。回家再服汤剂，每剂煎2次，每次水煎18分钟，混合，分3次口服，服第一次时，遵桂枝汤法，盖被，大人看着等待有小汗出。

6月2日复诊，患儿当日便通，服中药后有小汗出，至今已三日，未再发烧，进食尚可。又给上方五剂，嘱连服三剂，留下二剂，等有感冒时服之。

注：时过已3个月，学生打电话回访。答曰孩子很好，再没有感冒发烧，全家甚喜。

4. 经期感冒案：杨小佳，女，27岁，汉，阿拉山口市工作。三年来每到月经期必有感冒。症见全身酸困，往来寒热，胸胁苦满，心烦恶心，困乏嗜卧，微热口渴，有轻微咳嗽无痰。月经量少色淡、并有痛经，经前双乳房胀痛。曾去多家医院诊治，服中西药及抗生素输液治疗，均无效果，花钱受罪，影响上班，深感苦恼，经朋友介绍，乘车600公里，于2017年2月18日，来我院门诊就诊，症状如上所述，苔白脉弦，饮食二便正常，与小柴胡加银牛荆豆方，再加生石膏：

柴胡12g，党参10g，半夏12g，黄芩12g，炙甘草6g，金银花15g，牛蒡子15g，荆芥穗6g，淡豆豉10g，生石膏40g，贝母6g，鲜生姜3大片（自备），红枣6枚（自备，擘）。十剂，水煎服。

桂枝茯苓丸每次9丸，每日2次，每次月经前10天开始服药，经来停药。

2018年9月12日，患者托人来门诊取药。得知，患者上次看病后，回去坚持按时服药，经期感冒及痛经没有复发。近日因工作劳累，加班熬夜，天气骤凉，经期感冒又复发，诸证如前，还说喷嚏鼻塞比较明显，仍予上方加薄荷6克，十剂，水煎服。

5. 哮喘案：陈永柱，男，59岁，昌吉市人。患哮喘病十多年，服中西药无效，病情不能缓解。2015年秋，经昌吉州医院、乌鲁木齐市新疆医学院附院等做各项检查后，诊断为支气管扩张，左下肺肺大泡肺不张，建议做左下肺部分切除手术。患者不同意做手术，前来就诊。症见喘重咳轻，气急气短，面紫唇绀，汗多，手汗特别多，口干口渴能饮，必须随身带上水杯，饮食二便正常。初诊时，他在诊室门外，我在屋内能听见他的喘息，似喉中水鸡声，他坐下后仍可看到他张口抬肩的呼吸，有泡沫痰量不多，气短汗出，晚上有时不能平卧。予射干麻黄汤加金银花、贝母。连服十多剂后，咳喘减轻，但头痛汗多，口干口渴，口苦苔腻均加重，改服半夏泻心汤加生石膏、杏仁、银花、贝母等，又服十多剂，口干口苦，口渴苔腻减轻，但咳喘加重。仔细询问病情后得知，每次犯病时缘于汗多，汗多就有感冒，后背发冷，全身酸困无力，紧接着哮喘发作，于是给小柴胡银牛荆豆汤方加生石膏、贝母七剂，并嘱设法在家中小剂量吸氧，每次1～1.5小时，每日早晚各吸一次。

近一年来，患者经常来门诊，要求索取上方14剂，还不叫我修改处方，稍觉要有感冒时，即服此方三剂，感冒即愈，哮喘发作的次数明显减少，发作时的症状明显减轻。

第七节　半夏泻心汤的临床应用

胡希恕先生讲："方"者，经方也。"证"者，证候也。"方证者"即经方的适应证。辨方证是六经辨证的继续，是辨证的尖端，有是证用是方。

《伤寒论》有五泻心汤：半夏泻心汤、生姜泻心汤、甘草泻心汤、大黄黄连泻心汤、附子泻心汤，为《伤寒杂病论》的麻、桂、柴、附、半夏五大支柱类方之一，最具经典方证之特征。用泻心汤治疗消化系统的常见病、多发病是张仲景的一大发明，应用极为广泛。姜、夏、芩、连的配伍，即胃肠疾患用药的经典组合，为叶天士创立苦降辛开治疗大法，开辟了先河。今人食多喝多，无所锻炼的生活方式，造成多种胃肠疾病的发生。有人统计，现在因饮食不当所造成、引发的疾病占常见病的70%，所以掌握泻心汤法的临床应用规律，至关重要。胡希恕先生对此有深入的研究和丰富的临床应用经验，值得借鉴。

一、《伤寒》《金匮》中半夏泻心汤的论述

半夏半升，洗，黄芩、干姜、人参、甘草（炙）各三两，黄连一两，大枣十二枚，擘

上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。

注：公认习惯用量：1两=3克，1升=200mL。

《伤寒论》中有七方采用再煎，大小柴胡汤、柴胡桂姜汤、三泻心汤、旋覆代赭汤。

《伤寒论》第149条："但满而不痛者，此为痞，柴胡不中与之，宜半夏泻心汤。"

《金匮要略·呕吐哕下利病脉证治第十七》："呕而肠鸣，心下痞者，半夏泻心汤主之。"

1. 仲景对**"**痞**"**症的论述

131条："病发于阳，而反下之，热入因作结胸；病发于阴，而反下之，因作痞也。"

149条："但满而不痛者，此为痞。"

151条："脉浮而紧，而复下之，紧反入里，则作痞。按之自濡，但气痞耳。"

156条："本以下之，故心下痞。"

158条："医见心下痞，谓病不尽，复下之，其痞益甚。此非结热，但以胃中虚，客气上逆。"

164条："伤寒大下后，复发汗，心下痞……表解乃可攻痞。"

167条："病胁下素有痞，连在脐傍，痛引少腹，入阴筋者，此名脏结，死。"

注：《玉篇》（字书，南朝顾野王撰，凡三十卷）："痞，腹内结气。"《康熙字典》："痞病结也，气隔不通。""痞，有因下而结者，从虚及阳气下陷治之，有不因下而痞者，从上虚及痰饮食郁湿热治之。"《汉语大字典》："痞结伏积，不食自饱。"

2. 仲景五泻心汤均治**"痞"**

半夏泻心汤（149条）："但满而不痛者，此为痞。"《金匮》："呕而肠鸣，心下痞。"

生姜泻心汤（157条）："伤寒汗出解之后，胃中不和，心下痞硬，干噫食臭，胁下有水气，腹中雷鸣，下利。"

甘草泻心汤（158条）："伤寒中风，医反下之，其人下利，日数十行，谷不化，腹中雷鸣，心下痞硬而满，干呕，心烦不得安。"《金匮》："狐惑之为病……卧起不安，不欲饮食，恶闻食臭。"

大黄黄连泻心汤（154条）："心下痞，按之濡，其脉关上浮者。"

附子泻心汤（155条）："心下痞，而复恶寒，汗出者。"

仲景一口气出示了五个泻心汤证，说明此方证多用于常见病、多发病的重要性，胡希恕先生称其为常遭遇的方证。五泻心汤虽然都主治痞证，但每一方证都有自己的侧重点：半夏泻心汤降逆和胃，主治寒热互结或湿热互结之痞，痞满较重，用药苦、辛、平；生姜泻心汤清滞散水，主治水与热互结之痞，呕吐明显，重用生姜以散水气；甘草泻心汤补中止利，主治胃气虚弱之痞，下利、水谷不化较重，加重甘草用量，以补中气而痞自除；大黄黄连泻心汤泻热消痞，主治胃气壅滞之热痞；附子泻心汤扶阳泻热，主治胃热气滞兼卫阳不固表虚之痞。

3. 半夏泻心汤药少力宏应用范围广

半夏泻心汤用药仅七味，却包括了《伤寒》《金匮》十六个方剂的功效主治，证明其为经典组合，临床应用范围广大，不可小觑。

①小柴胡汤（《伤寒》用17次，《金匮》用1次）：去柴胡加黄连即半夏泻心汤，应用极为广泛。近人魏菊仙等编《中国名方进展》（中国医药科技出版社1991年版），收集小柴胡汤加减应用，能治疗80多种病症。

②小半夏汤（《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证并治第十二》）：半夏、生姜治心下有支饮。

③大半夏汤（《金匮要略·呕吐哕下利病脉证治第十七》）：半夏、人参治胃反呕吐。

④生姜半夏汤（《金匮》同上）：半夏、生姜汁治病人胸中似喘不喘，似呕不呕，似哕不哕，彻心中愦愦然无奈者。

⑤半夏干姜散（《金匮》同上）：半夏、干姜治干呕吐逆，吐涎沫。

⑥黄芩加半夏生姜汤（《伤寒》172条，《金匮》同上）：半夏、黄芩、芍药、甘草、生姜、大枣，治太阳与少阳合病，自下利，呕者（172），治干呕而利者（《金匮》同上）。

⑦黄连汤（《伤寒》173条）：黄连、半夏、干姜、人参、甘草、大枣、桂枝治伤寒胸中有热，胃中有邪气，腹中痛，欲呕吐者。

⑧干姜人参半夏丸（《金匮要略·妇人妊娠病脉证并治第二十》）：干姜、人参、半夏治妊娠呕吐不止。

⑨小陷胸汤（《伤寒》138条，141条）：黄连、半夏、栝楼实治小结胸病正在心下，按之则痛，脉浮滑者（138条），寒实结胸，无热证者（141条）。

⑩生姜甘草汤（《金匮要略·肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治第七》）：生姜、人参、甘草、大枣治肺痿咳嗽唾多，涎沫不止，咽燥而渴。

⑪甘草干姜汤（《伤寒》29条，30条）：甘草、干姜治厥，咽中干，烦躁吐逆者。

⑫甘草汤（《伤寒》311条）：甘草治少阴病咽痛。

⑬干姜黄芩黄连人参汤（《伤寒》359条）：治寒格，食入口即吐。

⑭半夏泻心汤：同前。

⑮生姜泻心汤：同前。

⑯甘草泻心汤：同前。

另：董继鹏、刘伟编著的《难病奇方系列丛书》（第二辑）一书，列出临床半夏泻心汤主治的疾病多达115种。

二、胡希恕半夏泻心汤的临床应用

胡老讲过，“泻”者有疏导向下之意，并非下法之“泻”，因痞证由误下而来，不能复用下法。“心”者为心口，指胃脘部位，西医称上腹部，并非指心脏器官。“心下”是指病情反应的病位，居半表半里，而并非病变发生的部位。

《伤寒论》149条论述本方的成因是：伤寒表不解，已五、六日，邪传少阳，因误下产生三种不同的变证。其一，柴胡证仍在，复与小柴胡汤；其二，成为结胸证，治以大陷胸汤；其三，此为痞证，当用半夏泻心汤。三证为何相提并论？意在辨其病位。柴胡证，邪犯少阳，病位主要在胸胁，可涉及心下，以胸胁苦满为主；结胸证，痰水实结，病位主要在心下，可波及胸胁，以满而硬痛为主；本证为痞，寒热阻结，病位主要在胃肠，心下痞满而不痛，并有呕、利，不能再用柴胡剂，应选用本方。

本方证因误下或误治而来，损伤中阳胃气，外邪乘虚而入，脾胃不和，湿热壅遏，气机升降失常，寒热互结，发为痞证，影响消化吸收之功能。主证为：恶心，呕吐，上腹部满闷不适，但按之无抵抗，肠鸣，腹泻或大便稀。兼证常伴有口干，口苦，口中异味，胃胀满或轻度胀痛，胃中气多打嗝，大便黏马桶水冲不净，或完谷不化，尿黄沫大气味大，人倦疲乏，面黄无华，消瘦或虚浮，双目干涩，眠差梦多，腰酸腿软，性功能减退，舌胖厚或有齿痕，质淡，苔白腻厚或兼黄，脉或虚或实。

临床观察泻心汤证的来源，除由误治而来以外，还有四种情况：其一，脾胃虚弱，食、湿、肉停滞，消化吸收功能障碍所致；其二，脾胃尚健，但饮食酒肉无度，终日饱食而不运动，久而久之发为本证；其三，大剂量或长期使用抗生素，造成消化道功能减退，以致产生本证；其四，老年病或慢性病，如高血糖、高血压、高血脂、冠心病、肾病、癌症病人手术化疗后，常常出现本方证的各种症候。

老师带教，独具匠心，炉火纯青，专用经方，善用合方，但不加减，目的示人以规矩。辨方证时要抓主证，仔细分析兼证，并谓：只要在寒、热、虚、实的辨证上，不出大的偏差，就有一定的疗效，从而达到一方治多病，异病同治之目的。今将胡老半夏泻心汤的临证经验，整理如下：

1.半夏泻心汤用药剂量

半夏泻心汤方：半夏12～18g，黄连3g，黄芩10g，党参10g或红参10g，干姜10g，炙甘草6g，大枣四枚（擘）。

水煎400～500mL，日一剂，分2～3次口服。

生姜泻心汤即半夏泻心汤，减干姜为3g，另加鲜生姜12g；甘草泻心汤即半夏泻心汤，增炙甘草为12～15g。

2.临床常遭遇的方证

在辨此方证的过程中，和小柴胡汤一样，同样也要遵循“但见一证便是，不必悉具”的指导原则。

①半夏泻心汤合吴茱萸汤：即上方加吴茱萸5～9g，治体质虚寒，舌淡苔薄白，肠鸣腹泻，五更泻，或便溏，或完谷不化，或伴有头痛者。

②半夏泻心汤合吴茱萸橘皮汤：即上方加吴茱萸6g，陈皮6～10g，治中虚寒多停饮之证，常见慢性胃脘痛，烧心泛酸，口干恶心，舌润滑苔薄白者。

③半夏泻心汤合小陷胸汤：即上方加全瓜蒌30g，治半夏泻心汤证兼有胁痛者。

④半夏泻心汤合白头翁汤：即上方加白头翁15g，黄柏6g，秦皮10g，治身体状况较好，腹痛，腹泻，大便有黏液或脓血便，腹痛明显

再加炒白芍12g。

⑤半夏泻心汤合茵陈蒿汤：即上方加茵陈10g，栀子6g，大黄6g，治身体较胖，口干，口苦，恶心，右胁痛，尿黄便干，面色青或垢，苔腻者。苔黄厚腻者，再加生石膏45～60g。

⑥半夏泻心汤合半夏厚朴汤：即上方加茯苓18g，厚朴10g，紫苏叶6g，治口干口苦，口中异味，咽干咽痛，面垢汗黏，尿黄便黏，苔厚腻或黄腻，体胖，证情较重者再加生石膏40～60g，薏苡仁30g。

⑦半夏泻心汤合四逆散：即上方加柴胡12g，枳实12g，白芍12g，治半夏泻心汤证兼有情绪抑郁，烦恼疲乏，腰酸乏力，手足偏凉，性功能减退者。

⑧半夏泻心汤合炒四仙汤：即上方加炒鸡内金10g，炒山楂15g，炒麦芽15g，炒神曲15g，醋莪术12g，治食欲不振，不食即饱的消化不良。

⑨甘草泻心汤加生石膏：即上方炙甘草增至12～15g，另加生石膏45～60g，治口腔溃疡、舌溃疡及口腔扁平苔藓，无论急性或慢性发作，均有良效。

⑩生姜泻心汤合橘皮竹茹汤：即生姜泻心汤加陈皮6g，竹茹6g，治妊娠反应，哕逆，呕吐者。煎好药以后，药汁要凉到室温，服药时，要喝一口稍停一会儿再喝，不可一饮而尽。

三、医案举例

1.慢性结肠炎案

1962年秋的一天，下午见习，胡希恕先生讲到，昨天星期日，给一位将军出诊看病。患者，男，50多岁，身体虚胖，饮食尚可，时有肠鸣，大便稀，日3～4次，早上起床必上厕所，完谷不化，有时能见到菜叶，舌质淡，苔白，脉细无力。证为寒湿在里，给半夏泻心汤合吴茱萸汤加陈皮，人参改用高丽参。方用：半夏12g，高丽参10g，干姜10g，黄芩10g，炙甘草6g，川黄连4.5g，红大枣6枚（擘），吴茱萸6g，橘皮10g。三剂，水煎服。今日复诊，病情明显好转，又给原方五剂。并说：高丽参，他们有。

2.急性痢疾案

1972年夏，患者，公社干部，男，30多岁，发冷发烧已两天，开始有恶寒，呕吐，继而腹痛，腹泻，日四至五次，口服四环素片及黄连素片后，烧退，但腹痛腹泻不减，日达十余次，每次拉一点黏液样粪便，时有脓血便，里急后重明显，有时必须翻窗子到外面解大便，舌红苔黄腻。诊为湿热在里之急性痢疾，予半夏泻心汤合白头翁汤加白芍。方用：黄连9g，黄芩12g，党参10g，半夏12g，炙甘草6g，红枣4枚（擘），白头翁15g，秦皮10g，黄柏6g，炒白芍12g。三剂，水煎服，服药一剂后，腹痛大减，排便次数明显减少，三剂服完，病愈。

3.急性肠炎案

1992年，本院院长，男，50岁，体胖，平时体健，血压偏高。因受凉发烧，肠鸣腹泻，水样便，日七八次，已静点抗生素，时过两天，病不缓解，里急时来不及入厕，拉在床单上，要求服中药治疗，诊为湿热在里之急性肠炎，予半夏泻心汤加味。方用：法半夏12g，党参10g，黄芩12g，川黄连5g，生姜12g，　　红枣4枚，茯苓15g，炒白术15g，薏苡仁18g，陈皮6g。二剂，水煎服。服一剂，诸证明显减轻，服二剂而愈。

4.性功能减退案

男，40岁，体胖，头昏汗多，面垢色青灰，疲乏无力，易烦眠差，口干，口苦，口中异味，腰膝酸软，性功能明显减退，大便黏稠，黏在马桶上冲不净，苔腻厚而黄，舌胖。诊为高血压、高血脂、脂肪肝，每天必服降压药。湿热内瘀，予四逆散合半夏泻心汤加生石膏。方用：柴胡15g，炒白芍12g，炒枳壳12g，法半夏12g，黄芩12g，川黄连5g，炙甘草6g，党参10g，生石膏30g，生姜6g，红枣4枚（擘）。五剂，水煎服。药后，人即轻松，口干苦异味消除，患者信心大增，又服上方十剂，大便正常，性功能恢复，以鹿胎颗粒善后。

5.舌炎案

1962年，胡希恕先生带实习时讲一病例，男，40岁，身体尚好，唯整个舌头鲜红无苔，唇干，汤水不进，疼痛难忍，难以入睡，尿黄，大便不畅。去大医院，服诸药无效，已半月，予甘草泻心汤加生石膏45g，生地20g。服二剂有效，再三剂而愈。结果口腔医院要请我去上

班。

6.口腔溃疡案

2011年12月22日，冬至来诊，某集团公司助理。主诉：其对象患口腔溃疡病，反复发作，数年不愈，疼痛不已，不敢食辛辣。曾去伊宁市、昌吉市、乌鲁木齐市各大医院求治，时好时坏，别无他病。夏天曾来诊室看病，服中药5剂后，病情大为好转。带7剂回伊宁市服药，至今病无复发。今日接电话，对象的妹妹，患口腔溃疡严重，服西药无效。明天要去伊宁市过春节，想带上次姐姐服的中药。随即调出电脑上姐姐的中药方七剂，小伙高兴地走出诊室。方用：炙甘草15g，法半夏10g，黄芩10g，黄连6g，党参10g，藿香6g，佩兰10g，薏苡仁24g，生石膏40g，鲜生姜3大片（自备），红枣4枚（自备）。

本方主治因湿热壅塞中焦所致的胃炎、牙痛、口腔糜烂、牙周炎、舌炎、味觉障碍、口腔扁平苔藓等，还可用于失眠及梦游症。

胡希恕先生用本方加生石膏，治疗复发性口腔溃疡及舌炎，用维生素B_2无效者，多有显效。笔者多年来用本方治疗口腔黏膜溃疡，均取得满意效果。炙甘草用12～15g，干姜改用鲜生姜，必加生石膏30～40g。《神农本草经》谓石膏味辛微寒。辛可以胜湿，微寒而不是多数医家所虑的大寒。只要舌苔腻，即可放心用之。

口腔溃疡若口干、口苦、苔腻、体壮者，用本方加生大黄6～10g，金银花15g；若苔白腻、口臭、大便稀、体弱者，本方加藿香6g、佩兰10g、生薏苡仁24g。

7.湿疹两例

2017年4月3日初诊：马某，女，52岁，干部，回族，近日汗多怕冷，心烦失眠，口干口苦，饮食乏味，舌胖，苔白腻厚，右手背大面积湿疹，皮肤发黑，害怕和别人握手，大便黏，日2～3次，予半夏泻心汤加茯苓、陈皮、薏苡仁、紫苏叶，七剂。复诊时，患者自诉手背不黑了，特别高兴，余症均好转，又给原方七剂，诸症痊愈。

2017年6月14日初诊：赵某，女，48岁，糖厂工人，胃脘胀闷，口干苦，纳差，大便稀，日2～3次，双手指疼、痒，皮肤干燥，有时裂口出血，洗衣洗手时水冷水热都疼，不能洗碗，皮肤科住院治疗无效，7年不愈。予半夏泻心汤原方加薏苡仁、紫苏叶、炒枳壳、茯苓、陈皮，

七剂。复诊时，患者先说我的手不疼了，举双手给学生们看，我好欢喜啊！又予原方七剂，诸症痊愈。

第二章　伤寒论证候辨析

“证候”一词最早见于《伤寒论·伤寒例第三》，其谓：“今搜采仲景旧论，录其证候，诊脉声色，对病真方，有神验者，拟防世急也。”“此以前是伤寒热病证候也。”前段之“证候”与“脉声色”分开，后段为此篇大论之总结语，则“证候”包括了“脉声色”。

“证候”即为症状，如“但见一证便是”的“证”，即是小柴胡汤四个主要症状之一。证候是患病时出现的反应，是疾病的临床表现。如果人体没有出现患病时的证候反应，就没有“八纲辨证”。“伤寒六经病”也就不存在了。

《伤寒论》的绝大部分内容，除了方剂都是证候。398条有证候和相似的证候约500个，以及可以摸得着的脉象58个。本章选出常见的证候40个，遵胡希恕先生“以论释论”的原则，不涉及经络脏腑，进行了归纳、分析和鉴别。学生曰：“读完398条，有‘一屋散钱’之感。”冀查对此文，会有所裨益。

证（即症）解

一、恶风寒

《伤寒论》中，“恶风”出现13次，“恶寒”出现30次。

（一）表证的恶风

1.太阳病，头痛，发热，汗出，恶风，桂枝汤主之。（**13**）

2.太阳病，项背强几几，反汗出恶风者，桂枝加葛根汤主之。（**14**）

3.太阳病，项背强几几，无汗，恶风，葛根汤主之。（**31**）

4.太阳病，头痛，发热，身疼，腰痛，骨节疼痛，恶风，无汗而喘者，麻黄汤主之。（**35**）

5.伤寒四五日，身热，恶风，颈项强，胁下满，手足温而渴者，小柴胡汤主之。（**99**）

【按】恶风、恶寒是指患者怕冷恶风的感觉，病位在表，为外感病

及内伤杂病中的常见证候。恶风是有风才恶，汗出多时必恶风，是表虚证。无汗恶风是表实证。表虚证只能用轻剂解表，治以解肌（16）祛风，调和营卫（53、54、95），用桂枝汤、桂枝加葛根汤之类。表实证须用重剂发汗，治以辛散解表，宣肺平喘，用葛根汤、麻黄汤之类。小柴胡汤的适应证也有恶风，是半表半里证的恶风（99），法当和解，不能攻里，也不能解表。

（二）虚证的恶风

1.太阳病，发汗，遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸者，桂枝加附子汤主之。（**20**）

2.风湿相搏，骨节疼烦，掣痛不得屈伸，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿者，甘草附子汤主之。（**175**）

3.太阳中风，脉浮紧，发热，恶寒，身疼痛，不汗出而烦躁者，大青龙汤主之。若脉微弱，汗出恶风者，不可服之。服之则厥逆，筋惕肉瞤，此为逆也。（**38**）

【按】此三条均为表阳虚的恶风，病位在表。20条是因发汗太过或误治所致汗漏不止的恶风。175条是因风湿侵入肌肉关节而致的恶风，病人不欲去衣。38条是脉微弱的汗出恶风，属阴、虚、寒的少阴病表证，不可再服大青龙汤。紧接此条后的39条加注“无少阴证者，大青龙汤发之”即为明证。

（三）表证的恶寒

1.太阳病**……**头痛，发热，微盗汗出，而反恶寒者，表未解也。（**134**）

2.伤寒大下后，复发汗，心下痞，恶寒者，表未解也。不可攻痞，当先解表，表解乃可攻痞。解表宜桂枝汤，攻痞宜大黄黄连泻心汤。（**164**）

3.阳明病**……**若汗多，微发热恶寒者，外未解也。（**208**）

4.阳明病，脉迟，汗出多，微恶寒者，表未解也。可发汗，宜桂

枝汤。（**234**）

【按】恶寒是虽无风亦感自寒，即“身大热，而不欲去衣者”是也。临床所见，恶风、恶寒常同时兼而有之，二者比较，“恶风”为怕冷较轻，受风时则怕冷；“恶寒”是怕冷较重，不受风时亦怕冷。

134条和164条都是表证正面的恶寒，134条未经误下，164条误下后表证仍在。阳明病应该是“不恶寒，反恶热”（182），但208条和234条强调阳明病也有恶寒者。既然是恶寒，也应该是或多或少有表证存留的微恶寒，治疗当先解表，有一分表证解一分表，这是辨别表里证的关键之一。

（四）虚证的恶寒

1.脉微而恶寒者，此阴阳俱虚，不可更发汗、更下、更吐也。（**23**）

2.发汗病不解，反恶寒者，虚故也。（**68**）

3.少阴病，得之一二日，口中和，其背恶寒者，当灸之，附子汤主之。（**304**）

4.少阴病，恶寒，身踡而利，手足逆冷者，不治。（**295**）

5.少阴病，四逆，恶寒而身踡，脉不至，不烦而躁者，死。（**298**）

【按】前三条的恶寒，不仅不是表证，而且还是里虚证，阳气不足导致。

二、不恶寒

《伤寒论》中出现“不恶寒”13次。

1.太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病。（**6**）

2.二阳并病，太阳初得病时，发其汗，汗先出不彻，因转属阳明，续自微汗出，不恶寒。（**48**）

3.发汗后，恶寒者，虚故也；不恶寒，但热者，实也，当和胃

气，与调胃承气汤。（**70**）

4.其人**漐漐**汗出，发作有时，头痛，心下痞硬满，引胁下痛，干呕，短气，汗出不恶寒者，此表解里未和也，十枣汤主之。（**152**）

5.问曰：阳明病外证云何？答曰：身热，汗自出，不恶寒反恶热也。（**182**）

6.阳明病，脉迟，虽汗出不恶寒者，其身必重，短气，腹满而喘，有潮热者，此外欲解，可攻里也。（**208**）

7.如其不下者，病人不恶寒而渴者，此转属阳明也。（**244**）

8.少阴病，下利清谷，里寒外热，手足厥逆，脉微欲绝，身反不恶寒，其人面色赤，或腹痛，或干呕，或咽痛，或利止脉不出者，通脉四逆汤主之。（**317**）

【按】不恶寒是指在外感病发生、发展的过程中，因病邪入里化热，病人多表现有不恶寒而反发热的症状，属阳明病。

发热而渴，不恶寒者，为温病。表证不解，汗出而不恶寒，为邪热转入阳明，可见怕热，不欲穿衣盖被，口苦咽痛，心烦，不恶寒反恶热，为阳、热、实证。轻证，当和胃气，与调胃承气汤。重证，五六日至十余日不大便，腹满而喘，或独语，发潮热不恶寒，治以大承气汤，攻下实热。

若头痛，心下痞硬满，引胁下痛，干呕，气短，汗出不恶寒，治以十枣汤，攻逐水饮。少阴病，下利清谷，脉微欲绝，身反不恶寒，实属内真寒而外假热，急投通脉四逆汤，回阳救逆。

三、振栗、振寒

《伤寒论》中出现“振栗”2次，“振寒”1次。

（一）阳虚

1.下之后，复发汗，必振寒，脉微细。所以然者，以内外俱虚故也。（**60**）

2.亡血家，不可发汗，发汗则寒栗而振。（**87**）

（二）表解的病机

1.太阳病未解，脉阴阳俱停，必先振栗汗出而解。但阳脉微者，先汗出而解；但阴脉微者，下之而解。若欲下之，宜调胃承气汤。（**94**）

2.伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具。凡柴胡汤病证而下之，若柴胡证不罢者，复与柴胡汤，必蒸蒸而振，却复发热汗出而解。（**101**）

3.太阳病二日，反躁。凡熨其背，而大汗出，大热入胃，胃中水竭，躁烦，必发谵语。十余日，振栗，自下利者，此为欲解也。故其汗从腰以下不得汗。（**110**）

4.伤寒五六日，呕而发热者，柴胡汤证具，而以他药下之，柴胡证仍在者，复与柴胡汤。此虽已下之，不为逆，必蒸蒸而振，却发热汗出而解。（**149**）

（三）治例

1.伤寒，若吐，若下后，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧，发汗则动经，身为振振摇者，茯苓桂枝白术甘草汤主之。（**67**）

2.太阳病，发汗，汗出不解，其人仍发热，心下悸，头眩，身动，振振欲擗地者，真武汤主之。（**82**）

【按】凡振栗都有体温不正常的恶寒表现。“振”即振战或振动，突然发生，表现在外，其证较轻。“栗”是振寒或寒战，发生较缓，表现在内，心里怯寒，其证较重。若振战而不栗，即“振振摇”（67）、“振振欲擗地”（82），是卫阳衰于外，而心阳还能守于中。若振战而栗，即“振栗”（94、110）、“寒栗而振”（87），说明卫阳衰于表，同时心阳竭于里，以内外俱虚，其证危重。

振栗是人体的正气既弱，仍能奋起抵抗，与邪气相争，最后战胜邪气。当正胜邪时，则振栗随汗而解（94），或下利（解大便），邪从下去为欲解（110）。如正不胜邪时，则病情恶化（87）。

67条为误下后脾阳虚弱，水湿停留，气上冲胸，振而不栗治以苓桂术甘汤健脾利水而回阳。82条为汗解不当，损伤肾阳，水湿阴寒俱盛，以致心下悸，身瞤动振振摇，治以真武汤温阳利水。

背恶寒，治以温经回阳的附子汤及加用灸法。表证的恶寒常常是发热的先兆。里证的恶寒，很难有发热的情况。“病有发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也”（7），就是明证。既然是里虚证，就不可更发汗、更下、更吐了。

（四）里证的恶寒

1.问曰：病有得之一日，不发热而恶寒者，何也？答曰：虽得之一日，恶寒将自罢，即自汗出而恶热也。（**183**）

2.问曰：恶寒何故自罢？答曰：始虽恶寒，二日自止，此为阳明病也。（**184**）

【按】恶寒是表证，不恶寒而恶热是里证，表里之证本分明。然也有阳明病初起而恶寒者，但为时极为短暂，仅在初起一日间，发热的同时随自汗出，恶寒即会消失。

恶寒时病位在表，发热时病位在里，或汗或下，临床难以掌握。本着有一分恶寒未去，就有一分表证存在的原则，治疗当先以解表为治，不可贸然用清下之法，恐有外邪内陷而生他变。怎么办？抓主证是关键。

四、厥

《伤寒论》中出现“厥”27次，“厥逆”5次，“厥冷”7次，“逆冷”5次。

（一）释义

1.凡厥者，阴阳气不相顺接，便为厥。厥者，手足逆冷者是也。（**337**）

2.伤寒脉微而厥，至七八日肤冷，其人躁无暂安时者，此为脏厥，非蛔厥也。（**338**）

（二）厥和热的病变

1.伤寒，先厥，后发热而利者，必自止，见厥复利。（**331**）

2.伤寒，一二日至四五日，厥者，必发热。前热者，后必厥，厥深者热亦深，厥微者热亦微。厥应下之，而反发汗者，必口伤烂赤。（**335**）

3.伤寒病，厥五日，热亦五日，设六日当复厥，不厥者自愈。厥终不过五日，以热五日，故知自愈。（**336**）

4.伤寒热少微厥，指头寒，默默不欲食，烦躁。数日，小便利，色白者，此热除也。欲得食，其病为愈，若厥而呕，胸胁烦满者，其后必便血。（**339**）

5.伤寒发热四日，厥反三日，复热四日，厥少热多者，其病当愈。四日至七日热不除者，必便脓血。（**341**）

6.伤寒厥四日，热反三日，复厥五日，其病为进。寒多热少，阳气退，故为进也。（**342**）

（三）死证

1.少阴病，但厥，无汗，而强发之，必动其血。未知从何道出，或从口鼻，或从目出者，是名下厥上竭，为难治。（**294**）

2.伤寒六七日，脉微，手足厥冷，烦躁，灸厥阴。厥不还者，死。（**343**）

3.伤寒发热，下利，厥逆，躁不得卧者，死。（**344**）

4.伤寒发热，下利至甚，厥不止者，死。（**345**）

5.发热而厥，七日，下利者，为难治。（**348**）

（四）治例

1.诸四逆厥者，不可下之，虚家亦然。（**330**）

2.伤寒脉促，手足厥逆。可灸之。（**349**）

3.伤寒脉滑而厥者，里有热，白虎汤主之。（**350**）

4.手足厥寒，脉细欲绝者，当归四逆汤主之。（**351**）

5.大汗，若大下利而厥冷者，四逆汤主之。（**354**）

6.伤寒，厥而心下悸，宜先治水，当服茯苓甘草汤，却治其厥。不尔，水渍于胃，必作利也。（**356**）

7.下利清谷，里寒外热，汗出而厥者，通脉四逆汤主之。（**370**）

8.呕而脉弱，小便复利，身有微热，见厥者难治，四逆汤主之。（**377**）

9.吐已下断，汗出而厥，四肢拘急不解，脉微欲绝者，通脉四逆加猪胆汁汤主之。（**390**）

【按】厥即手足表面皮肤温度低于正常并伴有手足寒冷的感觉。一般冷至腕、踝者名厥冷；冷过肘、膝者名厥逆。《伤寒论》中有“厥”“厥逆”“厥冷”“逆冷”“逆寒”“四逆”“手足寒”“手足冷”等描述，其义基本相同，而程度略有所异。本证病因虽有因寒、因热或因虚、因实的不同，而其基本病机是“阴阳气不相顺接”，阴阳气即表、里、寒、热、虚、实六者之气。

若正气不虚，里热或内热炽盛，表里之气不相顺接（不通），造成表寒或外寒之重证，则发生手足或肘膝逆冷而厥。里越热则表越寒，热向上可见烦躁、呕而胸胁烦满，口鼻出血。热向下可见便脓血。若正气已虚，里外俱寒而厥者，不可下之。

治疗：脉滑有力而厥，里热盛者，白虎汤主之。脉实热盛，大便不通而厥者，应下之，随证选方。脉细欲绝，手足厥寒者，当归四逆汤主之。大汗，下利而厥冷者，四逆汤主之。厥而心下悸，宜先治水，当服茯苓甘草汤，厥亦随水而去。

预后：若表证有发热，里证又有下利，烦躁，脉微而厥者，预后不良。若热少微厥，小便利而色白，欲得食者，其病为愈。无论什么病，我们都可以手足厥冷或手足温热，来判断病之轻重及预后。若手足温热三天，后又厥冷五天，为病情加重。若厥五天后，手足又温热五至六天，为阳气恢复，能愈。但病情加重时，手足厥冷最多不能超过五天，超过五天为正气虚极，预后不好。

临床常见1～6岁的小儿，外感加重时，可见厥深热亦深之重证，证见面色晦黄精神差，怕冷，没精神，不喜玩耍，手足肘、膝以下明显发凉，体温可升至39～40℃不退。此时应先解表，汗出则烧退。若发现患儿2日以上未大便，应先下之，便通后体温亦可下降。

五、发热

《伤寒论》中，“发热”出现72次。

（一）表证的发热

1.太阳中风，阳浮而阴弱，阳浮者，热自发，阴弱者，汗自出。啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕者，桂枝汤主之。（**12**）

2.太阳病，头痛，发热，汗出，恶风，桂枝汤主之。（**13**）

3.太阳病，发热，汗出者，此为荣弱卫强，故使汗出。欲救邪风者，宜桂枝汤。（**95**）

4.太阳病，脉浮紧，无汗，发热，身疼痛，八九日不解，表证仍在，此当发其汗**……**麻黄汤主之。（**46**）

5.少阴病，始得之，反发热，脉沉者，麻黄细辛附子汤主之。（**301**）

6.太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病。（**6**）

【按】发热是指患者体温超出正常范围，为临床最常见症状之一。表证的发热，多数为“翕翕发热”，其热在外，病位在表。故伤寒表证必有发热，有“不发热，不是太阳病”之说。发热常伴有恶寒、汗出、头痛、骨节疼痛、恶风、无汗而喘等。12条、13条、95条为太阳病表虚证，桂枝汤主之。46条为太阳病表实证，麻黄汤主之。301条为阴、虚、寒的少阴病表证，发热而不扬，脉沉而细，但欲寐，必无汗，故用麻黄细辛附子汤，温阳解表。6条为温病的发热，治当辛凉解表，可用银翘散，热盛者加生石膏。

（二）里证的发热

1.问曰：阳明病外证云何？答曰：身热，汗自出，不恶寒反恶热也。（**182**）

2.阳明病，脉浮而紧，咽燥，口苦，腹满而喘，发热汗出，不恶寒反恶热，身重。（**221**）

3.日晡所发热者，属阳明也。脉实者，宜下之。（**240**）

4.伤寒转系阳明者，其人濈然微汗出也。（**188**）

5.阳明病，发热，汗出者，此为热越，不能发黄也。（**236**）

6.太阳病三日，发汗不解，蒸蒸发热者，属胃也。调胃承气汤主之。（**248**）

【按】阳明病的外证为“身热，汗自出，不恶寒反恶热”。主要是热从内而出外，其特征叫“蒸蒸发热”，与太阳“中风翕翕”发热不同，热从内蒸出，且汗出甚多，甚则手足濈然汗出。

治里热不外用清、泻二法。热不实者用白虎汤，大烦渴再加人参；热实者，当用承气汤法。临床有患者说“我真想吃冰棍而不敢吃”，可视为里证之热。

（三）虚证的发热

1.病发热，头痛，脉反沉，若不差，身体疼痛，当救其里，四逆汤方。（**92**）

2.太阳病，发汗，汗出不解，其人仍发热，心下悸，头眩，身动，振振欲擗地者，真武汤主之。（**82**）

3.吐利，汗出，发热，恶寒，四肢拘急，手足厥冷者，四逆汤主之。（**388**）

【按】上述三条的发热，都是少阴阳虚，阴寒邪盛，里寒外热的假象，应该叫虚热，临床多见于危重病人。本病虽有发热，但脉反沉，手足厥冷，恶寒等仍为主证，治疗应急用四逆辈温经回阳。

四逆汤即甘草干姜汤与干姜附子汤的合方，既可温脾散寒，又能温肾回阳。临床用药证明，三味药同煎，炙甘草和干姜可加强附子的回阳作用，又能降低附子发热毒性。千年配伍，可谓经典。

（四）阳气未泯的发热（泯，读mǐn，作尽讲）

1.少阴病，吐，利，手足不逆冷，反发热者，不死。脉不至者，灸少阴七壮。（**292**）

2.伤寒，先厥，后发热而利者，必自止，见厥复利。（**331**）

【按】先病厥或吐、利，因胃气不衰，阳气恢复，积少成多而发热，是体力好转之征象，利将止，并非死候，可治。灸少阴七壮，加快正气恢复。

六、往来寒热

《伤寒论》中出现6次。

1.伤寒五六日中风，往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕**……**小柴胡汤主之。（**96**）

2.血弱气尽，腠理开，邪气因入，与正气相搏，结于胁下。正邪分争，往来寒热，休作有时。默默不欲饮食。脏腑相连，其痛必下，邪高痛下，故使呕也。小柴胡汤主之。（**97**）

3.伤寒十余日，热结在里，复往来寒热者，与大柴胡汤。（**136**）

4.伤寒五六日，已发汗而复下之，胸胁满微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出，往来寒热，心烦者，此为未解也。柴胡桂枝干姜汤主之。（**147**）

【按】病在表多恶寒，病在里多发热。正气较弱，邪入半表半里，正邪交争，不相上下，则一阵寒一阵热，先寒后热，交替出现，称“往来寒热”，是少阳病的独有热型。既异于太阳表证之寒热并见，亦别于阳明里证之但热不寒。

邪入半表半里，往来寒热，治疗忌汗、吐、下，只能和解，用小柴胡汤。偏于实者，心下急，呕不止，与大柴胡汤。偏于里寒停饮者，胸胁满微结，小便不利者，与柴胡桂枝干姜汤。

七、身疼痛

《伤寒论》中出现“身疼痛”7次，“身体疼痛”2次，“身疼”“身痛”“身体疼”“身体痛”各1次。

1.太阳中风，脉浮紧，发热，恶寒，身疼痛，不汗出而烦躁者，大青龙汤主之。若脉微弱，汗出恶风者，不可服之。（**38**）

2.太阳病，脉浮紧，无汗，发热，身疼痛，八九日不解，表证仍在，此当发其汗**……**麻黄汤主之。（**46**）

3.脉浮紧者，法当身疼痛，宜以汗解之。假令尺中迟者，不可发汗。何以知然？以荣气不足，血少故也。（**50**）

4.发汗后，身疼痛，脉沉迟者，桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤主之。（**62**）

5.伤寒，医下之，续得下利清谷不止，身疼痛者，急当救里；后身疼痛，清便自调者，急当救表。救里宜四逆汤；救表宜桂枝汤。（**91**）

6.伤寒八九日，风湿相搏，身体疼烦，不能自转侧，不呕，不渴，脉浮虚而涩者，桂枝附子汤主之**……**（**174**）

7.病发热，头痛，脉反沉，若不差，身体疼痛，当救其里，四逆汤方。（**92**）

8.少阴病，身体痛，手足寒，骨节痛，脉沉者，附子汤主之。（**305**）

【按】身疼痛是指全身疼痛而言，《伤寒论》中有“身疼痛”“身体疼痛”“身疼”“身痛”“身体疼”的描写，属于太阳、少阴之表证。太阳的身疼痛为风寒束表，脉浮紧，发作快，消失亦快，病程较短，治疗当发其汗。若疮家脉中迟，虽有身疼痛，也不可发汗。

太阳表实证身疼痛，若发热恶寒，无汗而喘，脉浮紧，治以麻黄汤，发汗解表；若兼内有郁热而烦躁，治以大青龙汤，外散风寒，内清郁热；若太阳表虚证身疼痛，因发汗太过，脉已沉迟，为营气亏损，治宜桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤，调和营卫，益气养营。

少阴病的身疼痛，脉沉或脉浮虚而涩，属于气血不足之阴、虚、寒的表证，治疗当救其里，温补散寒。

少阴病手足寒，脉沉，不仅身体痛，骨节亦痛，为阳气已衰，寒湿外浸，治以附子汤（炮附子用2枚），温经散寒，除湿镇痛；若全身疼痛剧烈，即身体疼烦，不能转侧，无少阳、阳明证者，为气血不足之表虚恶风，治以桂枝附子汤（炮附子用3枚），温经散寒，祛风除湿。

不论误治与否，若表里同病，表不解而身体疼痛，又见里虚寒而大便清稀，完谷不化者，应先温里扶正，治以四逆汤。待里气恢复，大便虽稀已正常，仍表邪未除，身体疼痛者，则可用桂枝汤解表。

八、自汗、无汗

《伤寒论》中出现“自汗”9次，“无汗”13次。

（一）表证自汗

1.病人脏无他病，时发热，自汗出而不愈者，此卫气不和也……（**54**）

2.病常自汗出者，此为荣气和，荣气和者，外不谐，以卫气不共荣气谐和故尔。（**53**）

3.太阳病，发热，汗出者，此为荣弱卫强，故使汗出。（**95**）

【按】自汗是人体不因劳累、天热或服发散药物等因素，而自然汗出。为外感热病及内伤杂病中之常见证候。

表证的自汗，是由于营气、卫气不和，治疗用桂枝汤。若有兼证，应辨证治之。

（二）里热证自汗

1.问曰：阳明病外证云何？答曰：身热，汗自出，不恶寒反恶热也。（**182**）

2.阳明病，本自汗出，医更重发汗，病已差，尚微烦不了了者，此必大便硬故也。（**203**）

3.阳明病，其人多汗，以津液外出，胃中燥，大便必硬，硬则谵

语，小承气汤主之。（**213**）

4.阳明病，发热，汗多者，急下之，宜大承气汤。（**253**）

5.阳明病，初欲食，小便反不利，大便自调，其人骨节疼，翕翕如有热状，奄然发狂，濈然汗出而解者，此水不胜谷气，与汗共并，脉紧则愈。（**192**）

6.三阳合病，脉浮大，上关上，但欲眠睡，目合则汗。（**268**）

【按】汗自出是阳明病里实热盛的典型证候，“身热，汗自出，不恶寒，反恶热”。但有热证、实证之分。

阳明热证者，大汗出并见身大热，口大渴，脉洪大等，治宜辛寒清热，用白虎汤，有大烦渴不解者，再加人参益气生津；阳明实证，里热结实，大汗出后，津液外出，大便硬结，腑气不通，宜用大承气汤，急下通里。

（三）亡阳的自汗

1.心下痞，而复恶寒、汗出者，附子泻心汤主之。（**155**）

2.伤寒六七日不利，便发热而利，其人汗出不止者，死。有阴无阳故也。（**346**）

3.大汗出，热不去，内拘急，四肢疼，又下利厥逆而恶寒者，四逆汤主之。（**353**）

4.病人脉阴阳俱紧，反汗出者，亡阳也。（**283**）

5.既吐且利，小便复利而大汗出，下利清谷，内寒外热，脉微欲绝者，四逆汤主之。（**389**）

6.少阴病，脉微，不可发汗，亡阳故也。阳已虚，尺脉弱涩者，复不可下之。（**286**）

【按】阳气衰微，阴寒极盛，则大汗出，四肢厥冷，又下利清谷、恶寒，脉微欲绝。大汗则阳亡于外，大下利则津脱于内，体温到了不能维持人体生理活动的时候，叫亡阳。亡阳，不可发汗，复不可下之，宜回阳救逆，用四逆汤。若其人汗出不止者，为有阴无阳也，必死。

（四）无汗

1.太阳病，项背强几几，无汗，恶风，葛根汤主之。（**31**）

2.太阳病，头痛，发热，身疼，腰痛，骨节疼痛，恶风，无汗而喘者，麻黄汤主之。（**35**）

3.阳明病，法多汗，反无汗，其身如虫行皮中状者，此以久虚故也。（**196**）

4.阳明病，反无汗而小便利，二三日呕而咳，手足厥者，必苦头痛。若不咳、不呕、手足不厥者，头不痛。（**197**）

5.少阴病，但厥，无汗，而强发之，必动其血。未知从何道出，或从口鼻，或从目出者，是名下厥上竭，为难治。（**294**）

6.服桂枝汤，或下之，仍头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满微痛，小便不利者，桂枝去桂加茯苓白术汤主之。（**28**）

【按】无汗是指本应汗出而不汗出之症状，一般由风寒束表，腠理密固所致。31条、35条是寒邪束表的无汗，应“表证仍在，此当发其汗”（46）。196条、197条是阳明证也有阳气不足的无汗。294条是强发汗动其血，造成阴伤津竭的无汗，为难治。28条是水饮内蓄的无汗，应在适方中加茯苓、白术，治其小便不利。

九、头痛

《伤寒论》中出现13次。

1.太阳病，头痛，发热，汗出，恶风，桂枝汤主之。（**13**）

2.太阳病，头痛，发热，身疼，腰痛，骨节疼痛，恶风，无汗而喘者，麻黄汤主之。（**35**）

3.伤寒不大便六七日，头痛有热者，与承气汤。其小便清者，知不在里，仍在表也，当须发汗。若头痛者必衄，宜桂枝汤。（**56**）

4.病发热，头痛，脉反沉，若不差，身体疼痛，当救其里，宜四逆汤方。（**92**）

5.干呕，吐涎沫，头痛者，吴茱萸汤主之。（**378**）

【按】头痛是指病人自觉以头痛为主，临床最为常见。三阳病头痛多属表属热，三阴病头痛属里属寒。13条是太阳中风头痛，兼有发热，汗出恶风。35条是太阳伤寒头痛，兼有发热，身疼痛，无汗。56条前半段为阳明里热头痛，兼有不大便六七日。92条为阳虚头痛，脉反沉，当救其里。378条是阴寒盛头痛，兼有干呕，吐涎沫。

以上5条，皆有头痛，而兼证各异。

十、头眩

《伤寒论》中出现6次。

1.阳明病，但头眩，不恶寒，故能食而咳，其人咽必痛。若不咳者，咽不痛。（**198**）

2.伤寒，若吐，若下后，心下逆满，气上冲胸，起则头眩**……**茯苓桂枝白术甘草汤主之。（**67**）

3.太阳病，发汗，汗出不解，其人仍发热，心下悸，头眩，身动，振振欲擗地者，真武汤主之。（**82**）

4.少阴病，下利止而头眩，时时自冒者，死。（**297**）

【按】“头眩”是头眩晕，包括有目眩，为自觉症状。轻者，眼前昏黑，头晕旋转。重者，头重脚轻，出现昏倒。头眩有虚实，虚证多为头贫血，实证多为脑充血。198条之头眩是阳明热、实。67条之头眩为饮证，是寒、实，治以苓桂术甘汤，温阳健脾，利水降冲。82条之头眩是汗多亡阳，虚阳外脱，治以真武汤，温阳利水。297条之头眩是少阴病虚阳已脱，为死证。

十一、口苦、口干、口燥

《伤寒论》中出现“口苦”3次，“口干”4次，“口燥”4次。

1.少阳之为病，口苦，咽干，目眩也。（**263**）

2.阳明中风，口苦，咽干，腹满，微喘，发热，恶寒，脉浮而紧。若下之，则腹满小便难也。（**189**）

3.阳明病，脉浮而紧，咽燥，口苦，腹满而喘，发热汗出，不恶寒反恶热，身重。若发汗则躁，心愦愦，反谵语。若加温针，必怵惕，烦躁不得眠。若下之，则胃中空虚，客气动膈，心中懊**侬**，舌上苔者，栀子豉汤主之。（**221**）

4.若渴欲饮水，口干舌燥者，白虎加人参汤主之。（**222**）

5.脉浮，发热，口干，鼻燥，能食者则衄。（**227**）

6.少阴病，自利清水，色纯清，心下必痛，口干燥者，可下之，宜大承气汤。（**321**）

7.痞不解，其人渴而口燥烦，小便不利者，五苓散主之。（**156**）

8.伤寒无大热，口燥渴，心烦，背微恶寒者，白虎加人参汤主之。（**169**）

9.少阴病，得之二三日，口燥，咽干者，急下之，宜大承气汤。（**320**）

【按】口苦是指患者自觉口中时时有苦味的感觉，为少阳病的主证之一。病情拖延或加重时，往往口苦和口干同时出现。口燥为口干之甚，二者均为口中津液缺乏之证候。

若病入少阳，邪热在半表半里，口苦兼见咽干，口干，或往来寒热，或胸胁苦满，或心烦喜呕者，治以小柴胡汤，和解少阳，扶正祛邪；若表邪传入阳明，口苦，口干兼口渴，腹胀满，大便不通者，宜用大承气汤，攻下实热；若口苦，口干，苔厚腻，口中异味，兼心下痞，大便溏黏马桶，水冲不净者，宜用苦降辛开的泻心汤法；若口苦，口干，兼见口燥，苔黄腻，发热汗出，心中懊侬，不恶寒反恶热，心烦睡眠差者，可在适方中加入栀子豉汤，清宣郁热，和胃除烦。

口干加重时为口燥，二者均为口中津液缺失。若口干鼻燥，脉浮，能食，为表里俱热，胃气不伤，则易发生鼻孔出血；若口干舌燥，兼心烦，口渴能饮水，并不见表证，为阳明热甚，治以白虎加人参汤，清热益气生津；若口干而燥，咽亦干痛，脘腹痛满，热结旁流，虽下利清水，仍为有燥屎之里实证，应与大承气汤，急下之；若口燥，心烦，渴

而能饮，又兼小便不利者，为气化不利，水湿停留于下焦，治以五苓散，通阳化气利水。

胡老临床治病，若见口苦、口干、口燥，只要见到舌苔厚腻，舌质不淡红，为湿热内蕴，就可以在适方中加入石膏45～60g（不用先煎）。胡老讲过，《神农本草经》明确记载，石膏味辛微寒，并非教材中所说的“大寒”。寒可清热，辛可胜湿，临床常在葛根汤、柴胡桂枝汤、大柴胡汤、小柴胡汤、茵陈蒿汤、甘草泻心汤、小青龙汤中，加入生石膏45～60g（打碎）疗效突出。

十二、咽痛

《伤寒论》中出现“咽痛”5次，“咽中痛”2次，“咽必痛”1次，“咽烂”1次，“咽中伤”1次，“咽干”3次，“咽中干”2次，“咽燥”2次，“咽喉干燥”1次。

1.太阳病，下之**……**脉紧者，必咽痛。（**140**）

2.少阳之为病，口苦，咽干，目眩也。（**263**）

3.阳明病，但头眩，不恶寒，故能食而咳，其人咽必痛。若不咳者，咽不痛。（**198**）

4.伤寒，先厥后发热，下利必自止。而反汗出，咽中痛者，其喉为痹（咽喉红肿疼痛，妨碍饮食）。（**334**）

5.此属少阴，法当咽痛而复吐利。（**283**）

6.少阴病二三日，咽痛者，可与甘草汤。不差，与桔梗汤。（**311**）

7.少阴病，咽中伤，生疮，不能语言，声不出者，苦酒汤主之。（**312**）

8.少阴病，咽中痛，半夏散及汤主之。（**313**）

9.少阴病，下利，咽痛，胸满，心烦，猪肤汤主之。（**310**）

【按】咽痛，或称咽喉痛、喉咙痛，是指咽喉部位疼痛而言。伤寒六经中，唯太阴病无咽喉疼痛诸症，因其口不渴，属太阴，脏有寒故也

（277）。咽痛诸证虽表里俱有，然多见于阳而甚少于阴，今咽痛又出少阴篇，是因少阴病为阴、虚、寒的表证。所示诸方大都属于和法，可知少阴之邪，已由表入里内传少阳。甘草、桔梗为咽痛经典用药，药少力专，确实有效。若证见不恶寒，口燥咽干，口渴，则知邪传阳明。甚者可传厥阴，咽中痛，其喉为痹。

十三、衄血

《伤寒论》中出现8次。

（一）阳盛

1.太阳病，脉浮紧，无汗，发热，身疼痛，八九日不解，表证仍在，此当发其汗。服药已微除，其人发烦目瞑，剧者必衄，衄乃解。所以然者，阳气重故也。麻黄汤主之。（**46**）

2.太阳病中风，以火劫发汗。邪风被火热，血气流溢，失其常度。两阳相熏灼，其身发黄。阳盛则欲衄。（**111**）

3.脉浮，发热，口干，鼻燥，能食者则衄。（**227**）

4.阳明病，口燥但欲漱水，不欲咽者，此必衄。（**202**）

（二）强迫发汗的险证

少阴病，但厥，无汗，而强发之，必动其血。未知从何道出，或从口鼻，或从目出者，是名下厥上竭，为难治。（**294**）

（三）自愈证

太阳病，脉浮紧，发热，身无汗，自衄者愈。（**47**）

（四）治则

衄家，不可发汗，汗出必额上陷脉急紧，直视不能眴，不得眠。（**86**）

【按】衄是指鼻孔出血的症状，俗称“鼻出血”，并非指鼻外伤出血。此证多见于太阳病和阳明病。邪热与内热相灼，证见发热，鼻干，鼻燥，心烦，头昏，脉浮。邪热过盛，迫血妄行，则发生鼻出血。（111）

若鼻衄之后，邪热有所去，全身症状均减轻，为病之将愈（46）；若平时身体健康，患流感后，脉浮，发热无汗，没有服药治疗，鼻孔自己出少量的血，为邪热已去，也可以自愈（47）。

若津液已亏，阴虚阳亢，发热无汗，复强发其汗，以致口鼻或目出血，额上内陷，双目直视难以转动，不得入眠，为难治（249）；若患者平时经常有鼻孔出血，又有外感表证，切忌用发汗解表之法（86）。

十四、口渴

《伤寒论》中出现“渴”23次，“口干”4次，“口燥”4次，“不渴”7次。

（一）热盛

1.服桂枝汤，大汗出后，大烦渴不解，脉洪大者，白虎加人参汤主之。（**26**）

2.伤寒若吐，若下后，七八日不解，热结在里，表里俱热，时时恶风，大渴，舌上干燥而烦，欲饮水数升者，白虎加人参汤主之。（**168**）

3.伤寒脉浮，发热，无汗，其表不解，不可与白虎汤。渴欲饮水，无表证者，白虎加人参汤主之。（**170**）

4.伤寒无大热，口燥渴，心烦，背微恶寒者，白虎加人参汤主之。（**169**）

5.若渴欲饮水，口干舌燥者，白虎加人参汤主之。（**222**）

6.下利欲饮水者，以有热故也。白头翁汤主之。（**373**）

（二）蓄水

1.若脉浮，小便不利，微热，消渴者，五苓散主之。（**71**）

2.中风，发热六七日，不解而烦，有表里证，渴欲饮水，水入则吐者，名曰水逆。五苓散主之。（**74**）

3.发汗已，脉浮数，烦渴者，五苓散主之。（**72**）

4.太阳病**……**渴欲饮水，少少与之，但以法救之。渴者，宜五苓散。（**244**）

（三）伤阴

1.少阴病，欲吐不吐，心烦但欲寐，五六日自利而渴者，属少阴也。虚故饮水自救。（**282**）

2.厥阴病，渴欲饮水者，少少与之愈。（**329**）

3.厥阴之为病，消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食，食则吐蛔，下之利不止。（**326**）

【按】渴是指自感口中干、口中燥而欲饮水的症状。《伤寒论》中有“口干”“口燥”“渴”“渴欲饮水”“烦渴”“燥渴”“消渴”之描述。口渴与不渴，反映体内津液的盛衰和输布的情况。实者，因火盛有余或水饮停蓄过多；虚者，因津液不足。

白虎汤证为一派通体皆热之证；身大热，自汗出，皮肤灼热，恶热，烦热，脉滑有力，治疗禁发汗、禁下，三条经文皆不言口渴。而白虎加人参汤之五条经文皆主口燥渴，渴欲饮水，大烦渴不解，燥渴欲饮水数升，治疗应以本方清热生津止渴。

若脉浮表不解，口渴饮水过多，水蓄内停，小便不利，治以五苓散，和表温阳利水（71、72、74）；若口渴饮水过多，湿热下利而伤津液，治以白头翁汤，清热解毒、凉血止痢（373）。

虚证之口渴，多因邪热入里，虚火内生，耗损津液，遂成心中疼热，口渴，饮水自救，应少少与之（244、329）。如有变证，随证治之（244）。

十五、咳

《伤寒论》中出现10次。

1.伤寒表不解，心下有水气，干呕，发热而咳，或渴，或利，或噎，或小便不利、少腹满，或喘者，小青龙汤主之。（**40**）

2.伤寒，心下有水气，咳而微喘，发热不渴。服汤已，渴者，此寒去欲解也，小青龙汤主之。（**41**）

3.伤寒五六日中风，往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕**……**或咳者，小柴胡汤主之。（**96**）

4.阳明病，但头眩，不恶寒，故能食而咳，其人咽必痛。若不咳者，咽不痛。（**198**）

5.少阴病，二三日不已，至四五日，腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者，此为有水气。其人或咳，或小便利，或下利，或呕者，真武汤主之。（**316**）

6.少阴病，下利六七日，咳而呕，渴，心烦不得眠者，猪苓汤主之。（**319**）

【按】咳多起于上气或气上冲，有声无痰谓之咳，有痰无声谓之嗽，有痰有声谓之咳嗽。从临床看，咳与嗽互见，故通称咳嗽。《伤寒论》中的咳，多为兼证，或证，治咳之方较少。《金匮要略》中的咳，为上气、咳唾、咳逆、时咳、咳喘等，与肺系有关，治咳之方较为全面。

若表不解，心下有水气，干呕，发热而咳，咳而微喘，为表有寒内有饮，治以小青龙汤（40、41），解表化饮，治咳平喘。口干苔腻，烦躁而喘者加生石膏为佳；若少阴病，脉微细，神疲，其人咳，并有四肢沉重，小便不利者，因阳气虚弱，寒水之邪为患，治以真武汤（316），温阳利水止咳。

胡老讲治咳嗽辨痰要点：

（1）稀水样痰，或痰中有水，易咳出，同时兼有气喘，病程长，即为痰饮，为小青龙汤证。

（2）黏稠痰，或黄或白，不易咳出，为麻杏石甘汤证。外感咳嗽，通过治疗咳出黄稠痰，量不多，若无表、里证，全身明显感到轻松，为即将病愈；若咳出黄稠痰，量多，有表证或里证，全身症状明

显，则为病情加重。

（3）混合痰，包括稠痰、泡痰，喉中有水鸡声，同时有气喘，以证选用射干麻黄汤或厚朴麻黄汤。

（4）黄稠痰，变换体位时量多，或间隔咳出血痰，胸满而烦，胸部皮肤甲错，病程较长，为《千金》苇茎汤证。

十六、喘

《伤寒论》中出现“喘”19次，“喘家”1次。

1.太阳病，头痛，发热，身疼，腰痛，骨节疼痛，恶风，无汗而喘者，麻黄汤主之。（**35**）

2.太阳与阳明合病，喘而胸满者，不可下，宜麻黄汤。（**36**）

3.伤寒，心下有水气，咳而微喘，发热不渴**……**小青龙汤主之。（**41**）

4.发汗后，不可更行桂枝汤。汗出而喘，无大热者，可与麻黄杏仁甘草石膏汤。（**63**）

5.太阳病，下之微喘者，表未解故也。桂枝加厚朴杏子汤主之。（**43**）

6.喘家，作桂枝汤，加厚朴、杏子佳。（**18**）

7.太阳病，桂枝证，医反下之，利遂不止。脉促者，表未解也。喘而汗出者，葛根黄芩黄连汤主之。（**34**）

8.阳明病，脉迟，虽汗出不恶寒者，其身必重，短气，腹满而喘，有潮热者，此外欲解，可攻里也。手足濈然汗出者，此大便已硬也。大承气汤主之。（**208**）

9.病人小便不利，大便乍难乍易，时有微热，喘冒不能卧者，有燥屎也。宜大承气汤。（**242**）

10.直视，谵语，喘满者死，下利者亦死。（**210**）

11.下利，手足厥冷，无脉者，灸之。不温，若脉不还，反微喘

者，死。（**362**）

【按】喘是指呼吸短促急迫的临床症状，常伴有呼吸困难，咳嗽吐痰，胸闷气短，不能平卧。《伤寒论》的喘证，病因多为外感风寒，病位在太阳，属于表实证。

若无汗而喘，头痛，发热，身体疼痛，或喘而胸满，治以麻黄汤辛温解表平喘，不可用下法攻里；若风寒束表，内有水气，干呕，咳喘，痰多稀白，或痰中有水饮，或痰中有白泡沫，治以小青龙汤解表化饮，治咳平喘；若表证未解，虽无明显的表热证，但里实有热，汗出而喘，咳嗽有痰，治以麻黄杏仁甘草石膏汤，解表清里，止咳平喘；若素有喘咳之人（喘家），复患太阳中风的桂枝汤证，应标本兼顾，宜选用桂枝汤加厚朴杏仁，解表降逆，宣肺治喘；若邪热随误下入里，利遂不止，表里俱热，喘而汗出，治以葛根芩连汤，解肌清肠止利；若有燥屎，腹满而喘，不能平卧，不恶寒，为阳明里实证，宜大承气汤，攻下燥屎，其喘可不治而愈。

阳明里实证，不论腹满或下利，若见微喘直视，脉不至者为死证。

十七、悸

《伤寒论》中出现11次。

（一）病因

1.脉浮数者，法当汗出而愈，若下之，身重，心悸者，不可发汗，当自汗出乃解。（**49**）

2.发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸欲得按者，桂枝甘草汤主之。（**64**）

3.太阳病，小便利者，以饮水多，必心下悸。小便少者，必苦里急也。（**127**）

4.少阳中风，两耳无所闻，目赤，胸中满而烦者，不可吐下，吐下则悸而惊。（**264**）

【按】心悸在中医内科称“怔忡”，同为心脏有病，但互有区别：“心

悸”是心脏跳动怵惕不能自安；而“怔忡”是形容心脏搏动力强，怔忡大动，而且很没有规律。心悸的病因主要是心阳不足，血液虚少，血压有降低的趋势，如64条、49条、264条。心下悸是由于胃里停有水饮，如127条。胸中阳气不足，故喜按，如64条。

（二）治则

1.伤寒二三日，心中悸而烦者，小建中汤主之。（**102**）

2.伤寒脉结代，心动悸，炙甘草汤主之。（**177**）

3.少阴病，四逆，其人或咳，或悸**……**（**318**）

4.伤寒，厥而心下悸，宜先治水，当服茯苓甘草汤，却治其厥。不尔，水渍入胃，必作利也。（**356**）

5.发汗后，其人脐下悸者，欲作奔豚，茯苓桂枝甧草大枣汤主之。（**65**）

6.太阳病，发汗，汗出不解，其人仍发热，心下悸，头眩，身动，振振欲擗地者，真武汤主之。（**82**）

【按】心悸是心阳不足，心下悸是脾阳或肾阳不足。心悸主要是心阳气虚，兼有水湿停留之证，治疗应使用桂枝类诸方证，如102条、177条、318条。若水湿停留过盛，应在适用方证中，重用茯苓温化水湿，如356、65条。若肾阳衰微，阳虚水泛，振振欲擗地（自立不稳貌），应使用真武汤温阳利水，如82条。

十八、结胸

《伤寒论》中出现16次。

（一）病因

1.病发于阳，而反下之，热入因作结胸；病发于阴，而反下之，因作痞也。所以成结胸者，以下之太早故也。（**131**）

2.阳气内陷，心下因硬，则为结胸。大陷胸汤主之。（**134**）

3.太阳病，二三日，不能卧，但欲起，心下必结，脉微弱者，此本有寒分也。反下之，若利止，必作结胸。（**139**）

4.太阳、少阳并病，而反下之，成结胸，心下硬，下利不止，水浆不下，其人心烦。（**150**）

5.若心下满而硬痛者，此为结胸也。大陷胸汤主之。（**149**）

（二）结胸与脏结的鉴别

1.问曰：病有结胸，有脏结，其状何如？答曰：按之痛，寸脉浮，关脉沉，名曰结胸也。（**128**）

2.何谓脏结？答曰：如结胸状，饮食如故，时时下利，寸脉浮，关脉小细沉紧，名曰脏结。舌上白苔滑者，难治。（**129**）

3.脏结无阳证，不往来寒热，其人反静，舌上苔滑者，不可攻也。（**130**）

4.病胁下素有痞，连在脐傍，痛引少腹，入阴筋者，此名脏结，死。（**167**）

【按】结胸证是指患者自感胃脘胀满而痛，医生按患者胃脘部有肌肉紧张抵抗之腹征。此证缘于误下，邪热内陷，与食、水互结，证见心下硬或心下满而硬痛，汤水不能下，心烦，不能平卧，为实证，可用大陷胸汤攻下。而脏结，如结胸状，但其人安静不烦，饮食如故，时有下利，舌苔白滑而湿，为虚证，不可用下法。如心下痛牵引少腹也痛，为死证（现代称急腹症）。

至于结胸与痞证的区别，见痞证条下。

十九、胸胁满

《伤寒论》中出现“胸满”5次，“胸中满而烦”1次，“胸胁满”3次，“胸胁下满”1次，“胸胁苦满”1次，“胸胁烦满”1次，“胁下满”1次，“胁下硬满”2次，“胁下满痛”1次。

1.太阳病，十日已去，脉浮细而嗜卧者，外已解也。设胸满胁痛

者，与小柴胡汤。（**37**）

2.阳明病，发潮热，大便溏，小便自可，胸胁满不去者，与小柴胡汤。（**229**）

3.阳明病，胁下硬满，不大便而呕，舌上白苔者，可与小柴胡汤。（**230**）

4.伤寒四五日，身热，恶风，颈项强，胁下满，手足温而渴者，小柴胡汤主之。（**99**）

5.本太阳病不解，转入少阳者，胁下硬满，干呕不能食，往来寒热，尚未吐下，脉沉紧者，与小柴胡汤。（**266**）

6.太阳与阳明合病，喘而胸满者，不可下，宜麻黄汤。（**36**）

7.伤寒五六日中风，往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，或胸中烦而不呕，或渴，或腹中痛，或胁下痞硬，或心下悸、小便不利，或不渴、身有微热，或咳者，小柴胡汤主之。（**96**）

8.伤寒十三日不解，胸胁满而呕，日晡所发潮热，已而微利。此本柴胡证**……**先宜服小柴胡汤以解外。（**104**）

9.太阳病，下之后，脉促，胸满者，桂枝去芍药汤主之。（**21**）

【按】胸满是指胸部满闷不舒。胸胁满是指胸部满闷连及胁肋部位。胸中满而烦、胸胁下满、胸胁苦满、胸胁烦满、胁下满、胁下硬满、胁下满痛，均为胸胁满之甚者。胸满者多兼有表证，如36条、21条。胸胁满是少阳病，属半表半里，如37条、229条、230条、99条、266条、96条、104条，多种疾病的证候都可以反应于此，治疗多与小柴胡汤扶正祛邪，应用非常广泛。

二十、心下痞

《伤寒论》中出现“心下痞”7次，“痞”7次，“心下痞硬”8次，“心中痞硬”1次。

（一）病因

病发于阴，而反下之，因作痞也……（**131**）

（二）证候

脉浮而紧，而复下之，紧反入里，则作痞，按之自濡，但气痞耳。（**151**）

（三）治例

1.太阳与少阳并病，头项强痛，或眩冒，时如结胸，心下痞硬者，当刺大椎第一间、肺俞、肝俞，慎不可发汗。（**142**）

2.心下痞，按之濡，其脉关上浮者，大黄黄连泻心汤主之。（**154**）

3.心下痞，而复恶寒、汗出者，附子泻心汤主之。（**155**）

4.但满而不痛者，此为痞，柴胡不中与之，宜半夏泻心汤。（**149**）

5.本以下之，故心下痞，与泻心汤，痞不解，其人渴而口燥烦，小便不利者，五苓散主之。（**156**）

6.伤寒汗出解之后，胃中不和，心下痞硬，干噫食臭，胁下有水气，腹中雷鸣，下利者，生姜泻心汤主之。（**157**）

7.伤寒中风，医反下之，其人下利，日数十行，谷不化，腹中雷鸣，心下痞硬而满，干呕，心烦不得安。医见心下痞，谓病不尽，复下之，其痞益甚。此非结热，但以胃中虚，客气上逆，故使硬也。甘草泻心汤主之。（**158**）

8.太阳病，外证未除而数下之，遂协热而利，利下不止，心下痞硬，表里不解者，桂枝人参汤主之。（**163**）

9.伤寒大下后，复发汗，心下痞，恶寒者，表未解也。不可攻痞，当先解表，表解乃可攻痞。解表宜桂枝汤，攻痞宜大黄黄连泻心汤。（**164**）

【按】心下痞是指心下胃脘堵闷不舒的症状。胃脘部位按之濡软，无胀痛感，打嗝后则舒服些。多因误下，邪热内陷，与食、湿、痰或水

互结，造成气机阻塞不畅所致。

“病发于阴，而反下之，因作痞也”（131），此痞是虚证。157条有“心下痞硬”一证，是指病证略重时，胃脘按之濡软之下，又微有抵抗感，但绝无胀、痛之证。结胸证是“病发于阳，而反下之，热入因作结胸”（131）。“心下痛，按之石硬”（135）即按胃脘时，不但痛感明显，而且硬有抵抗感。“心下痞”“心下痛”，二者同为心下之证，一虚一实，有明显区别。

若误下致使胃中空虚，脾虚失健则肠鸣、下利，客气上逆则打嗝，与甘草泻心汤和胃补中；若胃中停食停湿，致心下痞满而不痛者，与半夏泻心汤苦降辛开，降逆和胃；若心下痞，其脉关上浮，为胃中有热，与大黄黄连泻心汤泻热消痞；若误下后，心下痞，复汗出恶寒者，与附子泻心汤扶阳固表，泻热消痞；若心下痞，水湿内停，恶心加重，与生姜泻心汤散水止呕而消痞；若服泻心汤，痞仍不解者，证见口渴，燥烦，小便不利者，与五苓散利水消痞。

二十一、心下满

《伤寒论》中出现“心下满”4次，“心下逆满”1次，“心下硬满”1次。

1.服桂枝汤，或下之，仍头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满微痛，小便不利者，桂枝去桂加茯苓白术汤主之。（**28**）

2.伤寒五六日，头汗出，微恶寒，手足冷，心下满，口不欲食，大便硬，脉细者，此为阳微结。（**148**）

3.若心下满而硬痛者，此为结胸也**……**（**149**）

4.病人手足厥冷，脉乍紧者，邪结在胸中，心下满而烦，饥不能食者，病在胸中，当须吐之，宜瓜蒂散。（**355**）

5.伤寒，若吐，若下后，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧，发汗则动经，身为振振摇者，茯苓桂枝白术甘草汤主之。（**67**）

6.阳明病，心下硬满者，不可攻之。攻之，利遂不止者死，利止者愈。（**205**）

【按】心下指胃脘部位，心下满指自感胃脘满闷不适，满比胀轻。

28条去桂应改为去芍药，是心下满兼水停小便不利之表证。148条是心下满兼半表半里证。149条是心下满并且有硬痛感，为结胸证。67条心下满是胃虚，水气逆而向上冲胸，当加茯苓白术利水以降气。355条心下满是实证，气上冲胸所致的不能食而烦，当用吐法。205条是心下硬满在上，虽有阳明证，不可用攻下之法。

二十二、心中懊憹

《伤寒论》中出现6次。

1.发汗吐下后，虚烦不得眠，若剧者，必反复颠倒，心中懊憹，栀子豉汤主之。（**76**）

2.太阳病**……**医反下之，动数变迟，膈内拒痛，胃中空虚，客气动膈，短气躁烦，心中懊憹，阳气内陷，心下因硬，则为结胸，大陷胸汤主之。（**134**）

3.阳明病，无汗，小便不利，心中懊憹者，身必发黄。（**199**）

4.阳明病，脉浮而紧，咽燥，口苦，腹满而喘，发热汗出，不恶寒反恶热，身重。若发汗则躁，心愦愦，反谵语。若加温针，必怵惕，烦躁不得眠。若下之，则胃中空虚，客气动膈，心中懊憹，舌上苔者，栀子豉汤主之。（**221**）

5.阳明病，下之，其外有热，手足温，不结胸，心中懊憹，饥不能食，但头汗出者，栀子豉汤主之。（**228**）

6.阳明病，下之，心中懊憹而烦，胃中有燥屎者，可攻。腹微满，初头硬，后必溏，不可攻之。（**238**）

【按】心中懊憹是指心中烦郁特甚。有莫可名状、无可奈何之感，比烦躁要重，多为阳明热证。此证多因发汗、吐、下或误用温针，致使邪热内陷心胸部位，客气动膈，化热扰胸，心神不安，引发四种变证。76条、221条、228条是心中懊憹兼不得眠，反复颠倒（辗转反侧），饥不能食，但头汗出，舌上有苔，治以栀子豉汤清热除烦。134条是心中懊憹兼心下因硬，则为结胸证，治以大陷胸汤攻逐水热。199条是心中懊憹兼无汗，小便不利，湿热互结，身必发黄。238条是心中懊憹又有大便干结，可用攻下之法。

二十三、腹满

《伤寒论》中出现“腹满”16次，“腹胀满”3次。

（一）虚证

1.发汗后，腹胀满者，厚朴生姜半夏甘草人参汤主之。（**66**）

2.太阴之为病，腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛。（**273**）

3.本太阳病，医反下之，因尔腹满时痛者，属太阴也。桂枝加芍药汤主之。（**279**）

（二）实证

1.伤寒下后，心烦，腹满，卧起不安者，栀子厚朴汤主之。（**79**）

2.阳明病，脉迟，虽汗出不恶寒者，其身必重，短气，腹满而喘**……**若腹大满不通者，可与小承气汤，微和胃气，勿令大泄下。（**208**）

3.大下后，六七日不大便，烦不解，腹满痛者，此有燥屎也。所以然者，本有宿食故也，宜大承气汤。（**241**）

4.伤寒吐后，腹胀满者，与调胃承气汤。（**249**）

5.发汗不解，腹满痛者，急下之，宜大承气汤。（**254**）

6.腹满不减，减不足言，当下之，宜大承气汤。（**255**）

7.少阴病，六七日，腹胀，不大便者，急下之，宜大承气汤。（**322**）

【按】腹胀是指腹中胀满不适，属里证，有虚实之分。虚证者，腹满时减，食不下，欲吐，自利益甚，属太阴证。实证者，腹满不减，减不足言，卧起不安，腹满而喘，腹满时痛，腹大满不通，有燥屎，属阳明证，当用攻下法。

热邪结于里，不一定是因为有燥屎，当治以清热除烦，宽中消满（79）。热结邪实，大便不通，既胀满又痛，治以攻下实邪（208、241、254、255）。尽管腹满有虚证的过程，只要眼下见到里实证，不要有顾虑，仍须急下之（254、255）。腹满一证，只要是中下焦的病变，都应从下焦治，不应从上焦治（249）。

二十四、腹中痛

《伤寒论》中出现“腹中痛”7次，“腹痛”4次，“腹满痛”2次，“腹中急痛”1次。

1.伤寒五六日中风，往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，或胸中烦而不呕，或渴，或腹中痛**……**小柴胡汤主之。（该方煎服法：若腹中痛者，去黄芩，加芍药三两）（**96**）

2.寒实结胸，无热证者，与三物小陷胸汤，白散亦可服。（白散方服药法：**……**腹中痛，与芍药三两如上法）（**141**）

3.少阴病，下利清谷，里寒外热，手足厥逆，脉微欲绝，身反不恶寒，其人面色赤。或腹痛**……**通脉四逆汤主之。（该方煎服法：腹中痛者，去葱，加芍药二两）（**317**）

4.霍乱，头痛，发热，身疼痛，热多欲饮水者，五苓散主之。寒多不用水者，理中丸主之。（理中丸方下有作汤加减法：腹中痛者加人参，足前成四两半）（**386**）

5.少阴病，四逆，其人或咳，或悸，或小便不利，或腹中痛，或泄利下重者，四逆散主之。（该方煎服法：腹中痛者，加附子一枚，炮令坼）（**318**）

6.少阴病，二三日不已，至四五日，腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者，此为有水气**……**真武汤主之。（**316**）

7.伤寒，胸中有热，胃中有邪气，腹中痛，欲呕吐者，黄连汤主之。（**173**）

8.伤寒，阳脉涩，阴脉弦，法当腹中急痛，先与小建中汤；不差者，小柴胡汤主之。（**100**）

【按】腹痛是指腹内疼痛，亦称腹中痛。腹内之部位是指胃脘以下，耻骨毛际以上的腹腔内。《伤寒论》中对腹痛的论述，从整体上看，属于少阴病的阴、虚、寒证。其痛比较缓和，其表现多数为兼证，并不是腹痛难忍的急腹症。

霍乱，呕吐自利，发热，头身痛，为表里同病，但表寒轻里寒重，并且口不渴，不用饮水则可知并非现代传染病之霍乱，实为里虚证之中寒，治以理中丸（汤），温中祛寒，补气健脾。159条“理中者，理中焦”，即是理中丸的功用。本方作汤加减法中云：“腹中痛者，加人参，足前成四两半”，可知气虚之甚。

若阳气虚弱，寒水内停，腹痛，小便不利，自下利，四肢浮肿沉重，脉沉微细，治以真武汤，温阳利水；若阳虚比四逆汤严重，脉微欲绝，阳气被格拒于外。虽外有假热，但实为阴寒盛于内，手足厥逆，下利清谷，只有“急当救里”，在四逆汤的基础上，用生附子大者一枚，干姜用量加一倍，治以通脉四逆汤回阳通脉，挽回垂危之阳；若中气虚寒，导致腹中拘急，时时作痛，痛时喜按，腹如舟状，脉弦细，治以小建中汤，温中补虚，缓急止痛，但将军肚之腹痛，则非本方所能治。

《神农本草经》谓白芍“味苦平无毒，主邪气腹痛”。汉代芍药不分赤白，就地取材。南北朝时，陶弘景开始将芍药分为白芍、赤芍两种。仲景在方后加减法中，注明腹中痛加芍药（96、141、317），下利去芍药（316）。

二十五、少腹满、少腹硬

《伤寒论》中出现“少腹满”3次，“少腹硬”1次，“少腹硬满”2次。

1.伤寒表不解，心下有水气，干呕，发热而咳，或渴，或利，或噎，或小便不利、少腹满，或喘者，小青龙汤主之。（**40**）

2.伤寒有热，少腹满，应小便不利，今反利者，为有血也，当下之，不可余药，宜抵当丸。（**126**）

3.病者手足厥冷，言我不结胸，小腹满，按之痛者，此冷结在膀胱关元也。（**340**）

4.太阳病，身黄，脉沉结，少腹硬，小便不利者，为无血也。小

便自利，其人如狂者，血证谛也，抵当汤主之。（**125**）

5.太阳病六七日，表证仍在，脉微而沉，反不结胸，其人发狂者，以热在下焦，少腹当硬满，小便自利者，下血乃愈。所以然者，以太阳随经，瘀热在里故也。抵当汤主之。（**124**）

6.太阳病，重发汗而复下之，不大便五六日，舌上燥而渴，日晡所小有潮热，从心下至少腹硬满而痛不可近者，大陷胸汤主之。（**137**）

【按】少腹满指少腹部胀满不适，亦称小腹满。少腹硬指少腹部胀满不适，按之坚硬。

表不解，或咳或喘，又见少腹满，小便不利，为心下有水气，水停下焦，应予小青龙汤利水平喘，而治其少腹满（40）。若少腹满或少腹硬，反而小便自利者，又见其人如狂，肯定为瘀血证，根据病情的轻重，可选用抵当汤或丸，攻下逐血（126、125、124）。若便秘，舌燥而渴，下午有潮热，又见心下至少腹硬满而痛，并且拒按者，为结胸证，可予大陷胸汤，泄热逐水破结（137）。若手足厥冷，小腹满，按之痛者，为下焦阳虚，寒冷在关元，可选用附子汤，温阳祛寒（340）。

二十六、哕

《伤寒论》中出现9次。

（一）病因

1.阳明病，不能食，攻其热必哕，所以然者，胃中虚冷故也。以其人本虚，攻其热必哕。（**194**）

2.若胃中虚冷，不能食者，饮水则哕。（**226**）

3.伤寒，大吐，大下之，极虚，复极汗者，其人外气怫郁，复与之水，以发其汗，因得哕。所以然者，胃中寒冷故也。（**380**）

4.太阳病中风，以火劫发汗。邪风被火热**……**久则谵语，甚者至哕。（**111**）

（二）治疗

1.阳明中风，脉弦浮大而短气，腹都满，胁下及心痛，久按之气不通，鼻干，不得汗，嗜卧，一身及目悉黄，小便难，有潮热，时时哕，耳前后肿，刺之小差。外不解，病过十日，脉续浮者，与小柴胡汤。（**231**）

2.脉但浮，无余证者，与麻黄汤。若不尿，腹满加哕者，不治。（**232**）

3.伤寒哕而腹满，视其前后，知何部不利，利之即愈。（**381**）

【按】胡老讲："哕者，干呕而不吐，其声连连。"《正字通·口部》："方书谓有物无声曰吐，有声无物曰哕，有物有声曰呕。"另有解释，"哕"即呃逆，俗称打呃，由胃气上逆所致。

哕，虚证居多，或外感寒邪，胃中寒冷；或饮食劳倦，胃中饮多虚冷。治疗应"于寒湿中求之"（259）。但哕亦有实证，气不得下行而上逆，当视其二便，大便不利则通大便，小便不利则利小便，利之哕止。

231条为三阳合病又发黄疸之证。若病之始，脉浮，恶寒无汗，可与麻黄汤；若病程较长，病过十日，脉续浮，时时哕，耳前后肿，其病多在少阳，可与小柴胡汤；若腹满，无尿而哕，则预后多凶，为不治。

二十七、呕吐

《伤寒论》中出现"呕"32次，"吐"40次，"呕吐"3次，"干呕"9次，"欲吐"6次，"不呕"8次。

（一）半表半里证

1.伤寒六七日，发热，微恶寒，支节烦疼，微呕，心下支结，外证未去者，柴胡桂枝汤主之。（**146**）

2.伤寒五六日，呕而发热者，柴胡汤证具，而以他药下之，柴胡证仍在者，复与柴胡汤。（**149**）

3.太阳与阳明合病，不下利，但呕者，葛根加半夏汤主之。

（**33**）

4.伤寒发热，无汗，呕而不能食，而反汗出濈濈然者，是转属阳明也。（**185**）

5.呕而发热者，小柴胡汤主之。（**379**）

6.阳明病，胁下硬满，不大便而呕，舌上白苔者，可与小柴胡汤。上焦得通，津液得下，胃气因和，身濈然汗出而解。（**230**）

（二）热证

1.太阳与少阳合病，自下利者，与黄芩汤。若呕者，黄芩加半夏生姜汤主之。（172）

2.伤寒，胸中有热，胃中有邪气，腹中痛，欲呕吐者，黄连汤主之。（173）

（三）寒证

1.食谷欲呕，属阳明也。吴茱萸汤主之。（**243**）

2.呕而脉弱，小便复利，身有微热，见厥者难治，四逆汤主之。（**377**）

3.干呕，吐涎沫，头痛者，吴茱萸汤主之。（**378**）

4.少阴病，饮食入口则吐，心中温温欲吐，复不能吐。始得之，手足寒，脉弦迟者，此胸中实，不可下也，当吐之。若膈上有寒饮，干呕者，不可吐也，当温之，宜四逆汤。（**324**）

（四）水气

1.伤寒表不解，心下有水气，干呕，发热而咳，或渴，或利，或噎，或小便不利，少腹满，或喘者，小青龙汤主之。（**40**）

2.太阳中风，下利，呕逆，表解者，乃可攻之。其人漐漐汗出，发作有时，头痛，心下痞硬满，引胁下痛，干呕，短气，汗出不恶寒者，此表解里未和也。十枣汤主之。（**152**）

（五）误治变证

1.太阳病，过经十余日，反二三下之，后四五日，柴胡证仍在者，先与小柴胡。呕不止，心下急，郁郁微烦者，为未解也。与大柴胡汤下之则愈。（**103**）

2.太阳病，过经十余日，心下温温欲吐而胸中痛，大便反溏，腹微满，郁郁微烦，先此时自极吐下，与调胃承气汤。若不尔者，不可与。但欲呕，胸中痛，微溏者，此非柴胡汤证，以呕故知极吐下也。（**123**）

3.伤寒中风，医反下之，其人下利，日数十行，谷不化，腹中雷鸣，心下痞硬而满，干呕，心烦不得安**……**甘草泻心汤主之。（**158**）

4.伤寒本自寒下，医复吐下之，寒格，更逆吐下，若食入口即吐，干姜黄芩黄连人参汤主之。（**359**）

（六）治疗原则

1.伤寒呕多，虽有阳明证，不可攻之。（**204**）

2.呕家有痈脓者，不可治呕，脓尽自愈。（**376**）

【按】有声有物谓之呕，有物无声谓之吐。但临床上对于泛吐的症状，都称呕吐，似无严格区分的必要。吐之物，一般指饮食和痰饮，吐甚者可有胆汁，肠液。“呕逆”即呕吐气逆；“喜呕”指经常作呕；“时呕”指有时作呕；“反呕”指病不应呕，而反作呕；“干呕”指欲吐而呕；临床患者常说“恶心”，是指胃脘难受，欲吐不吐，与仲景谓“呕逆”“干呕”“哕”略同，虽病机各异，但均属胃气上逆所致。

“呕吐”或“恶心”为半表半里之主证，临床视其兼证而选用柴胡剂，最为常见。呕而发热者，可与小柴胡汤，和解少阳；呕而恶寒发热，关节烦疼者，可与柴胡桂枝汤，和解太阳、少阳；呕而无汗恶风者，可与葛根加半夏汤，解表止呕。

热证呕吐，实证居多。呕而下利，与黄芩加半夏生姜汤，清热止呕；呕而下利，腹中痛，与黄芩汤，清热燥湿，止痛止呕。

寒证呕吐，虚证居多。膈上有寒饮，干呕，脉弱无力，四肢厥逆

者，当温之，与四逆汤，回阳止呕；呕而头痛，吐涎沫，与吴茱萸汤，温胃散寒，降逆止呕。

痰饮内停呕吐。表不解，心下有水气，干呕，咳喘，与小青龙汤，解表化饮；水饮停及胸胁，心下痞硬满，引胁下痛，干呕，短气，以十枣汤，攻逐水饮。

表证误下后，可致呕吐。若呕不止，心下急，郁郁微烦者，与大柴胡汤下之；若大下后，虽有大便微溏，但腹微满，胸中痛，仍欲吐，胃气不和者，可与调胃承气汤，泻热和胃；若表未解下之，邪热内陷，其痞硬满，肠鸣，下利，心烦干呕，此胃气已虚，与甘草泻心汤，益胃缓中；若胃气已虚，更行吐、下，使原有寒格之呕吐，下利，更加严重，与干姜黄芩黄连人参汤，燥湿温阳止呕。

总之，呕之气机是向上向外，属表证，此时虽有阳明证，不可用攻下之法。桂枝汤证有鼻鸣干呕，不可下即为明证。痈、脓之证，如有呕吐，脓成破溃，邪去呕吐自愈，不可治呕。以上二则为治呕之原则性大法。

二十八、不能食、能食

《伤寒论》出现“不能食”15次，“能食”10次。

（一）吐、下后的不能食

1.太阳病**……**一二日吐之者，腹中饥，口不能食。三四日吐之者，不喜糜粥，欲食冷食，朝食暮吐，以医吐之所致也，此为小逆。（**120**）

2.得病六七日，脉迟浮弱，恶风寒，手足温，医二三下之，不能食而胁下满痛，面目及身黄，颈项强，小便难者，与柴胡汤，后必下重。（**98**）

（二）胃寒的不能食

1.阳明病，若中寒者，不能食，小便不利，手足濈然汗出，此欲

作固瘕，必大便初硬后溏。所以然者，以胃中冷，水谷不别故也。（**191**）

2.阳明病，不能食，攻其热必哕，所以然者，胃中虚冷故也。以其人本虚，攻其热必哕。（**194**）

3.若胃中虚冷，不能食者，饮食则哕。（**226**）

（三）热扰于胃的不能食

阳明病，下之，其外有热，手足温，不结胸，心中懊憹，饥而不能食，但头汗出者，栀子豉汤主之。（**228**）

（四）有燥屎的不能食

阳明病，谵语，有潮热，反不能食者，胃中必有燥屎五六枚也。若能食者，但硬耳。宜大承气汤下之。（**215**）

（五）能食与否辨寒热

阳明病，若能食，名中风；不能食，名中寒。（**190**）

（六）病欲解的能食

1.伤寒三日，三阳为尽，三阴当受邪。其人反能食而不呕，此为三阴不受邪也。（**270**）

2.伤寒热少微厥，指头寒，默默不欲食，烦躁。数日，小便利，色白者，此热除也。欲得食，其病为愈**……**（**339**）

3.下利后，当便硬，硬则能食者愈。今反不能食，到后经中，颇能食，复过一经能食，过之一日当愈**……**（**384**）

（七）死证的能食

1.伤寒，脉迟六七日，而反与黄芩汤彻其热。脉迟为寒，今与黄芩汤复除其热，腹中应冷，当不能食，今反能食者，此名除中，必

死。（**333**）

2.凡厥利者，当不能食，今反能食者，恐为除中**……**（**332**）

【按】不能食是指进食很少，或素有胃疾，自感脘胀欲呕畏食，病情加重时怕进饮食，证情要辨虚、实、寒、热。“虚”者，因误吐、误下所致，发病一二日为轻（小逆），邪气尚浅，只是中气虚弱，调养即可恢复。若病程延至六七日以上仍不能食者，为胃气已伤，可致胁下满痛，面目及身黄，变为他证。“寒”者，不能食又兼小便不利，大便初硬后溏，水谷不别而下，为胃中寒冷，虽有虚热和大便初头硬，不可攻下。热者，里热扰于胃不能食，并有心中懊憹，但头汗出者，栀子豉汤主之。实者，腑中实热，燥屎内结，又见谵语，潮热者，宜大承气汤下之。190条更以能食与不能食，观察胃气之虚实而区分寒热。能食者，胃气素健，可攘成阳明热证；不能食者，则成胃中虚寒之证。

能食是指食欲、食量和正常人没有区别，即“饮食如故”（129）。不论伤寒或下利，若脾健胃气不虚，虽有病但不影响饮食，也不呕，大小便正常，病程又短，仅二三日，可判断病情不会再发展，预后良好。俗称“有病能吃，恢复就快”，前人说“补肾不如补脾”，有一定的道理。

若病程较长，六七日不愈，脉迟寒多，腹中寒冷，又有手足厥冷及下利，可知全身的情况都不好，本不应能食，此时“反能食”，为胃气将绝，名曰“除中”，必死，俗称“回光返照”。

二十九、发黄

《伤寒论》中出现“发黄”8次。

（一）病机

1.太阳病，医发汗，遂发热，恶寒，因复下之，心下痞。表里俱虚，阴阳气并竭，无阳则阴独，复加烧针，因胸烦，面色青黄，肤者，难治。今色微黄，手足温者，易愈。（**153**）

2.伤寒脉浮而缓，手足自温者，是为系在太阴。太阴者，身当发黄，若小便自利者，不能发黄。至七八日，大便硬者，为阳明病也。（**187**）

3.阳明病，发热，汗出者，此为热越，不能发黄也。但头汗出，身无汗，剂颈而还，小便不利，渴引水浆者，此为瘀热在里，身必发黄，茵陈蒿汤主之。（**236**）

（二）热证

1.太阳病中风，以火劫发汗。邪风被火热，血气流溢，失其常度。两阳相熏灼，其身发黄。（**111**）

2.太阳病，身黄，脉沉结，少腹硬，小便不利者，为无血也。小便自利，其人如狂者，血证谛也。抵当汤主之。（**125**）

3.太阳病**……**但头汗出，余处无汗，剂颈而还，小便不利，身必发黄。（**134**）

4.阳明病，无汗，小便不利，心中懊憹者，身必发黄。（**199**）

5.阳明病，被火，额上微汗出，而小便不利者，必发黄。（**200**）

6.阳明病，面合色赤，不可攻之。必发热，色黄者，小便不利也。（**206**）

7.阳明中风，脉弦浮大而短气，腹都满，胁下及心痛，久按之气不通，鼻干，不得汗，嗜卧，一身及目悉黄。（**231**）

8.伤寒七八日，身黄如橘子色，小便不利，腹微满者，茵陈蒿汤主之。（**260**）

9.伤寒，身黄，发热，栀子柏皮汤主之。（**261**）

10.伤寒，瘀热在里，身必黄，麻黄连轺赤小豆汤主之。（**262**）

（三）寒湿证

1.阳明病，脉迟，食难用饱，饱则微烦头眩，必小便难，此欲作谷瘅。虽下之，腹满如故，所以然者，脉迟故也。（**195**）

2.伤寒发汗已，身目为黄，所以然者，以寒湿在里不解故也。以为不可下也，于寒湿中求之。（**259**）

【按】发黄是指以目黄、面黄、身黄、尿黄为主要症状。此证从目

睛黄染开始，继则遍及全身。其病因为：①由于火逆复加烧针误治而来；②由于素有瘀血所致；③因湿热与寒湿之邪造成。其中临床尤以瘀热在里发黄为常见。

因误治者，发汗复下之，伤气损津，面色青黄，暗淡无泽，皮肤组织失去濡养而肤瞤不宁，为难治。

有瘀血者，身黄，少腹硬，小便自利，其人如狂，脉沉结，为血与热邪互结，蓄于下焦，以抵当汤攻下瘀血。

湿热发黄为常见，证见一身及目悉黄如橘子色，身无汗，腹微满，口渴能饮，小便不利，尿色黄赤而量少，证属湿热较重兼腑气壅滞，治以茵陈蒿汤泻热退黄。若身黄初起，并兼有风寒束表之发热恶寒，治以麻黄连轺赤小豆汤，清热利湿，解表散邪。若身黄如橘子色，发热，口渴，心中懊憹，外无头痛恶寒等表证，内无腹满便秘等里证，为热重湿轻，治以栀子柏皮汤清热利湿退黄，本方加茵陈则效果更好。若脾胃虚弱，寒湿在里，身目为淡黄，多不发热，不渴，小便不利，大便溏薄，此证属阴、虚、寒之太阴发黄，不可下之，应温中散寒，除湿退黄。

临床还有脾胃气不足，气血虚损，身、面、手俱黄，呈萎黄之色，但其目睛与小便不黄，头晕心悸气短，全身疲乏，脉细无力，应与虚劳、失血同治。

三十、谵语

《伤寒论》中出现“谵语”27次，“郑声”1次，“语言必乱”1次。

（一）病因

1.伤寒，腹满，谵语，寸口脉浮而紧**……**（**108**）

2.太阳病二日，反躁。凡熨其背而大汗出，大热入胃，胃中水竭，躁烦，必发谵语**……**（**110**）

3.太阳病中风，以火劫发汗。邪风被火热，血气流溢**……**但头汗出，剂颈而还，腹满，微喘，口干，咽烂，或不大便，久则谵语**……**（**111**）

4.形作伤寒，其脉不弦紧而弱，弱者必渴，被火必谵语，弱者发热，脉浮，解之当自汗出愈。（**113**）

5.夫实则谵语，虚则郑声。郑声者，重语也**……**（**210**）

6.伤寒四五日，脉沉而喘满，沉为在里，而反发其汗，津液越出，大便为难，表虚里实，久则谵语。（**218**）

7.少阴病，咳而下利，谵语者，被火气劫故也。小便必难，以强责少阴汗也。（**284**）

8.太阳与少阴并病，头项强痛，或眩冒，时如结胸，心下痞硬者**……**发汗则谵语，脉弦，五日谵语不止，当刺期门。（**142**）

9.三阳合病，腹满，身重，难以转侧，口不仁，面垢，谵语，遗尿。发汗则谵语。下则额上生汗，手足逆冷。若自汗出者，白虎汤主之。（**219**）

10.伤寒脉弦细，头痛发热者，属少阳。少阳不可发汗，发汗则谵语。此属胃，胃和则愈，胃不和，烦而悸。（**265**）

11.若已吐、下、发汗、温针，谵语，柴胡汤证罢，此为坏病。知犯何逆，以法治之。（**267**）

（二）辨生死

1.直视，谵语，喘满者死，下利者亦死。（**210**）

2.发汗多，若重发汗者，亡其阳，谵语，脉短者死；脉自和者不死。（**211**）

3.伤寒若吐、若下后不解**……**独语如见鬼状。若剧者，发则不识人，循衣摸床，惕而不安，微喘直视，脉弦者生，涩者死。（**212**）

（三）治例

1.若胃气不和谵语者，少与调胃承气汤。（**29**）

2.伤寒十三日，过经，谵语者，以有热也，当以汤下之**……**（**105**）

3.伤寒八九日，下之，胸满，烦，惊，小便不利，谵语，一身尽重，不可转侧者，柴胡加龙骨牡蛎汤主之。（**107**）

4.妇人中风，发热恶寒，经水适来，得之七八日，热除而脉迟，身凉，胸胁下满，如结胸状，谵语者，此为热入血室也。当刺期门，随其实而取之。（**143**）

5.妇人伤寒，发热，经水适来，昼日明了，暮则谵语，如见鬼状者，此为热入血室。无犯胃气及上二焦，必自愈。（**145**）

6.阳明病，其人多汗，以津液外出，胃中燥，大便必硬，硬则谵语，小承气汤主之。若一服谵语止者，更莫复服。（**213**）

7.阳明病，谵语，发潮热，脉滑而疾者，小承气汤主之。（**214**）

8.阳明病，下血，谵语者，此为热入血室。但头汗出者，刺期门，随其实而泻之，濈然汗出则愈。（**216**）

9.汗出谵语者，以有燥屎在胃中，此为风也。须下者，过经乃可下之。下之若早，语言必乱，以表虚里实故也。下之愈，宜大承气汤。（**217**）

10.二阳并病，太阳证罢，但发潮热，手足**漐漐**汗出，大便难而谵语者，下之则愈，宜大承气汤。（**220**）

11.下利谵语者，有燥屎也。宜小承气汤。（**374**）

【按】谵语是以神志不清，胡言乱语为特征的一种临床表现，多见于里实证和里热证。其语声响亮有力，言多语无伦次。郑声为神志昏沉，语声低微，念念重复，多见于里虚之证。

谵语病人体质为阳、实、热，多见于三阳合病，表虚里实。证见头痛发热，大汗出，腹满，不大便，口干，口渴，咽烂，脉沉弦有力。发病诱因为“邪风火热”“误吐误下”“反发其汗”“温针”“熨其背”，被火气劫故也。体质和病因二阳相灼，胃中水竭，津液外出，其火上炎但头汗出，必发谵语。

谵语并见直视喘满，或下利不止，或独语如见鬼状，不识亲人，循衣摸床，脉短或涩者，津液告竭，必死。若脉自和或弦者，正气恢复，尚有生机。

各种谵语之证，均不外里热里实。若腹满潮热，大便难下，应随其证选用三承气汤急下之；若汗多，口渴甚者，可用白虎汤清热保津；若谵语较轻，只是烦、惊，一身尽重，证虽实而人已虚，可用柴胡加龙骨牡蛎汤和解镇惊；若热入血室，兼有往来寒热，可用小柴胡汤和解少阳，便秘加大黄，或刺期门而泻之。

上诉所用方证，若一服谵语止，更莫复服，不必尽剂。

三十一、烦躁

《伤寒论》中出现“烦躁”15次，“烦”38次，“躁”7次。

（一）病因

1.微数之脉，慎不可灸。因火为邪，则为烦逆，追虚逐实，血散脉中，火气虽微，内攻有力，焦骨伤筋，血难复也。脉浮，宜以汗解，用火灸之，邪无从出，因火而盛，病从腰以下必重而痹，名火逆也。欲自解者，必当先烦，烦乃有汗而解。何以知之？脉浮，故知汗出解。（**116**）

2.吐利，发汗，脉平，小烦者，以新虚不胜谷气故也。（**391**）

3.伤寒一日，太阳受之。脉若静者，为不传。颇欲吐，若躁烦，脉数急者，为传也。（**4**）

4.伤寒六七日，无大热，其人躁烦者，此为阳去阴故也。（**269**）

5.当汗不汗，其人躁烦，不知痛处，乍在四肢，按之不可得，其人短气但坐，以汗出不彻故也，更发汗则愈。（**48**）

6.太阳病二日，反躁。凡熨其背而大汗出，大热入胃，胃中水竭，躁烦，必发谵语**……**（**110**）

7.少阴病，欲吐不吐，心烦但欲寐，五六日自利而渴者，属少阴也**……**（**282**）

（二）表热

1.太阳病，初服桂枝汤，反烦不解者，先刺风池风府，却与桂枝汤则愈。（**24**）

2.伤寒发汗已解，半日许复烦，脉浮数者，可更发汗宜桂枝汤。（**57**）

（三）里热

1.发汗吐下后，虚烦不得眠，若剧者，必反复颠倒，心中懊**憹**，栀子豉汤主之**……**（**76**）

2.伤寒下后，心烦，腹满，卧起不安者，栀子厚朴汤主之。（**79**）

3.发汗，若下之，而烦热，胸中窒者，栀子豉汤主之。（**77**）

4.太阳病，过经十余日**……**呕不止，心下急，郁郁微烦者，为未解也，与大柴胡汤下之愈。（**103**）

（四）里实

1.阳明病，不吐、不下，心烦者，可与调胃承气汤（**207**）

2.阳明病，下之，心中懊**憹**而烦，胃中有燥屎者，可攻。腹微满，初头硬，后必溏，不可攻之。若有燥屎者，宜大承气汤。（**238**）

3.大下后，六七日不大便，烦不解，腹满痛者，此有燥屎也。所以然者，本有宿食故也，宜大承气汤。（**241**）

4.得病二三日，脉弱，无太阳、柴胡证，烦躁，心下硬，至四五日，虽能食，以小承气汤，少少与，微和之，令小安。（**251**）

5.病人不大便五六日，绕脐痛，烦躁，发作有时者，此有燥屎，故使不大便也。（**239**）

（五）半表半里

伤寒五六日中风，往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜

呕，或胸中烦而不呕……小柴胡汤主之。（**96**）

（六）表里俱实证

太阳中风，脉浮紧，发热，恶寒，身疼痛，不汗出而烦躁者，大青龙汤主之。（**38**）

（七）寒饮证

1.发汗已，脉浮数，烦渴者，五苓散主之。（**72**）

2.中风，发热六七日，不解而烦，有表里证，渴欲饮水，水入则吐者，名曰水逆，五苓散主之。（**74**）

3.病人手足厥冷，脉乍紧者，邪结在胸中，心下满而烦，饥而不能食者，病在胸中，当须吐之，宜瓜蒂散。（**355**）

（八）阳虚证

1.下之后，复发汗，昼日烦躁不得眠，夜而安静……干姜附子汤主之。（**61**）

2.发汗，若下之，病仍不解，烦躁者，茯苓四逆汤主之。（**69**）

3.伤寒二三日，心中悸而烦者，小建中汤主之。（**102**）

4.少阴病，吐利，手足逆冷，烦躁欲死者，吴茱萸汤主之。（**309**）

（九）伤津

1.太阳病，发汗后，大汗出，胃中干，烦躁不得眠，欲得饮水者，少少与饮之，令胃气和则愈……（**71**）

2.伤寒脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急，反与桂枝，欲攻其表，此误也。得之便厥，咽中干，烦躁吐逆者，作甘草干姜汤与之，以复其阳……（**29**）

3.少阴病，得之二三日以上，心中烦，不得卧，黄连阿胶汤主

之。（**303**）

4.少阴病，下利，咽痛，胸满，心烦，猪肤汤主之。（**310**）

5.少阴病，下利六七日，咳而呕，渴，心烦不得眠者，猪苓汤主之。（**319**）

（十）辨死证

1.少阴病，恶寒而踡，时自烦，欲去衣被者，可治。（**289**）

2.阴病，吐，利，躁烦，四逆者，死。（**296**）

3.少阴病，四逆，恶寒而身踡，脉不至，不烦而躁者，死。（**298**）

4.少阴病，脉微细沉，但欲卧，汗出不烦，自欲吐，至五六日，自利，复烦躁不得卧寐者，死。（**300**）

5.伤寒六七日，脉微，手足厥冷，烦躁，灸厥阴。厥不还者，死。（**343**）

6.伤寒发热，下利，厥逆，躁不得卧者，死。（**344**）

【按】烦躁，是指心中烦躁不安，手足躁扰不宁的症状。烦多为自觉证属阳，躁多为他觉症属阴。总之，烦躁多为热证，烦为热之轻，躁为热之甚。临床二者多为互见，故常烦和躁并称。究其病因，表、里、寒、热、虚、实均有。

表热，服桂枝汤后邪未尽，表欲解时，正邪交争则烦，若脉浮数，应更服桂枝汤及刺风池、风府，使热邪从汗而解。

里热，若虚烦不得眠，心中懊憹者，为无形之热，治以栀子豉汤，清里热止烦躁。若呕不止，郁郁微烦者，治以大柴胡汤，使热邪下泻而烦自解。

里实，若欲吐不能吐，欲解无大便，心烦者，与调胃承气汤，泻热和胃。若心中懊而烦，胃中有燥屎者，为阳明腑实的烦躁，可苦寒攻下，用大承气汤。

表寒内热，表里俱实，证见脉浮紧，身疼痛，不汗出而烦躁者，治

以大青龙汤，散风寒清里热。

邪在半表半里，心烦喜呕或胸中烦，故用小柴胡汤和解祛邪。

寒邪壅塞胸中，胸阳被寒邪所遏则烦，治以五苓散，温阳利水。

阳气不足亦可致烦，若脉沉微的烦躁，为阳气虚而阴寒盛，治以干姜附子汤，急救回阳。若阳虚津液不足而烦躁者，治以茯苓四逆汤，回阳救阴。若气血不足兼里虚的心悸心烦，治以小建中汤，温中补虚。若脾胃虚寒，水气上冲，烦躁欲死者，治以吴茱萸汤，温中散寒，去饮降逆。

大病伤津之后，可致烦躁。若胃中干，烦躁不得眠，欲饮水者，少少饮之，胃气和则愈。若阳气损伤，咽中干，烦躁吐逆者，治以甘草干姜汤，以复其阳。若血虚热盛，心中烦，不得安卧入眠，治以黄连阿胶汤，补血泻火。若水郁化热，灼津而竭，心烦不得眠，治以猪苓汤，利尿泻热。

预后，若烦躁复见手足逆冷，下利，呕吐，脉微沉细或脉不至者，此为阳气已绝，多为死证。若证虽有烦，欲去衣被而不逆冷，为阳气恢复，仍可治疗。

三十二、奔豚

《伤寒论》中出现2次。

1.发汗后，其人脐下悸者，欲作奔豚，茯苓桂枝甘草大枣汤主之。（**65**）

2.烧针令其汗，针处被寒，核起而赤者，必发奔豚。气从少腹上冲心者，灸其核上各一壮，与桂枝加桂汤，更加桂二两也。（**117**）

【按】奔豚是指患者自觉有气从少腹上冲心胸咽喉的病证，如豚之奔样。《金匮》描述："奔豚病从少腹起，上冲咽喉，发作欲死，复还止，皆从惊恐得之。"

65条为里有停水，发汗表不解，激动里水，脐下悸动，伴有气上冲，欲作奔豚，用苓桂甘草大枣汤，温阳利水以制豚作。117条为误用烧针取汗，针处受寒红肿，引起剧烈之气上冲心，用桂枝加桂汤，降气

治冲逆以泄奔豚之气。

以上二方证特点的区别点，在于有无水饮。65条，证为阳虚水饮内停，故重用茯苓半斤利水；117条，证为阳虚所致阴寒气上冲，故重用桂枝五两治气上冲。

三十三、狂

《伤寒论》出现“如狂”2次，“发狂”2次，“惊狂”1次。

1.太阳病不解，热结膀胱，其人如狂，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，当先解其外。外解已，但少腹急结者，乃可攻之，宜桃核承气汤。（**106**）

2.伤寒脉浮，医以火迫劫之，亡阳，必惊狂，卧起不安者，桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤主之。（**112**）

3.太阳病六七日，表证仍在，脉微而沉，反不结胸，其人发狂者，以热在下焦，少腹当硬满，小便自利者，下血乃愈**……**（**124**）

4.太阳病**……**小便自利，其人如狂者，血证谛也。抵当汤主之。（**125**）

【按】狂证指面红而赤，狂言乱动，意识失常，不听劝告，脉弦大滑数，多为阳、实、热证。仲景论说：轻证为如狂、惊狂，魂魄不宁，精神离散，卧起不安，其人喜忘，亡阳亡津液，致阳气衰者为狂；重症为发狂，如狂状，狂言妄行，谵语如见鬼状，独语不休，大便当硬，小便自利，为阳明里实证。

本证多由误治，热邪传入半表半里或里，邪热结于膀胱部位而为瘀血证。瘀血证急性发作期，以发狂为主，而不是有内出血的病人，而意识正常者。膀胱蓄水五苓散证有小便不利，而此瘀血证是小便自利，此为鉴别要点。

桃核承气汤证：表不解误汗，邪热传于里，结于下焦，血不行而致瘀，急性发作，瘀热上犯心神，其人如狂，腹证为少腹急结，脉浮。宜本方破血下瘀。

抵当汤证：表不解误下，邪热入里，与本有久瘀互结于下焦，小便

自利，瘀热上犯神明，其人发狂。腹证有少腹当硬满，屎虽硬而大便反易，其色必黑。脉微而沉。宜本方攻逐瘀血。

桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤证：伤寒表证无汗，医以火劫迫汗，大汗后，亡阳即亡津液亡血，血不足以养心，心怯则惊狂，卧起不安，宜本方温阳涤痰，镇心安神。

三十四、小便不利、小便利

《伤寒论》中出现“小便不利”25次，“小便难”6次，“小便少”2次，“小便利”10次，“小便自利”6次，“小便数”5次。

（一）亡津液的小便不利

1.大下之后，复发汗，小便不利者，亡津液故也；勿治之，得小便利，必自愈。（**59**）

2.太阳病二日，反躁，凡熨其背，而大汗出，大（一作火）热入胃，胃中水竭，躁烦，必发谵语；十余日，振栗，自下利者，此为欲解也；故其汗从腰以下不得汗，欲小便不得，反呕，欲失溲，足下恶风，大便硬，小便当数而反不数及不多；大便已，头卓然而痛，其人足心必热，谷气下流故也。（**110**）

3.伤寒八九日，下之，胸满，烦、惊，小便不利，谵语，一身尽重，不可转侧者，柴胡加龙骨牡蛎汤主之。（**107**）

4.阳明病，本自汗出，医更重发汗，病已差，尚微烦不了了者，此必大便硬故也；以亡津液，胃中干燥，故令大便硬；当问其小便日几行，若本小便日三四行，今日再行，故知大便不久出；今为小便数少，以津液当还入胃中，故知不久必大便也。（**203**）

5.病人小便不利，大便乍难乍易，时有微热，喘冒不能卧者，有燥屎也，宜大承气汤。（**242**）

6.太阳病，发汗，遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸者，桂枝加附子汤主之。（**20**）

7.太阳病中风，以火劫发汗，邪风被火热，血气流溢，失其常

度；两阳相熏灼，其身发黄，阳盛则欲衄，阴虚小便难；阴阳俱虚竭，身体则枯燥，但头汗出，剂颈而还；腹满微喘，口干咽烂，或不大便，久则谵语；甚者至哕，手足躁扰，捻衣摸床；小便利者，其人可治。（**111**）

【按】小便不利是指小便量减少，或小便排出有困难的一种证候，亦称“小便少”“小便难”。古代无“输液”之法，观察小便利与不利，显得至关重要。小便不利多见于“大下”“复发汗”“大汗出”，或“误吐”之后，造成全身的水分减少，其结果可造成多种变证。

（1）汗多则尿少，汗少则尿多，身体无病时有自我调节的功能。因“复发汗”有“亡津液”之虞，但体健不虚仍有小便者，勿治之，能自愈。

（2）病程稍久又复下之，津液损失过多，小便不利，胸满，烦，惊，谵语，为邪热传至少阳，治以柴胡加龙骨牡蛎汤，和解泻热，镇惊安神。

（3）发汗太过，汗出不止，其人恶风小便难，为汗多亡阳（38）之太阳表虚证，治以桂枝加附子汤扶阳解表。

（4）邪热传阳明，津液内伤则小便不利，但大便乍难乍易，为津液尚未枯竭，应速攻下实热，荡涤燥结，选用大承气汤。

（二）蓄水的小便不利

1.若脉浮，发热，渴欲饮水，小便不利者，猪苓汤主之。（**223**）

2.太阳病**……**若脉浮，小便不利，微热，消渴者，五苓散主之。（**71**）

3.本以下之，故心下痞，与泻心汤，痞不解，其人渴而口燥烦，小便不利者，五苓散主之。（**156**）

4.伤寒五六日，已发汗而复下之，胸胁满微结，小便不利**……**柴胡桂枝干姜汤主之。（**147**）

【按】外邪未除，脉浮，发热而渴，小便不利，为热邪与水互结于下焦，有二证：其一，渴欲饮水，小便不利，水多致阳气不足为寒证，治以五苓散温阳化气利水。其二，水气停蓄，小便不利，水少热多，脉

浮发热，而为热证，治以猪苓汤滋阴泻热利水。

（三）亡津液的小便利

1.病人不恶寒而渴者，此转属阳明也，小便数者，大便必硬，不更衣十日，无所苦也**……**（**244**）

2.趺阳脉浮而涩，浮则胃气强，涩则小便数，浮涩相搏，大便则硬，其脾为约，麻子仁丸主之。（**247**）

3.太阳病，若吐，若下，若发汗后，微烦，小便数，大便因硬者，与小承气汤，和之愈。（**250**）

4.阳明病，自汗出，若发汗，小便自利者，此为津液内竭，虽硬，不可攻之；当须自欲大便，宜蜜煎导而通之。（**233**）

【按】小便利是排尿通畅顺利的一个症状，与小便不利相对而言。前面亡失津液的小便不利，关系到全身的水分减少。此小便利或小便数的亡失津液，仅限于肠道里的水分偏走膀胱而缺失。不恶寒而口渴者已转属阳明，以致大便硬，多日不更衣，病情缓者无所苦，宜麻子仁丸、蜜煎导润肠通便。证情偏重，因肠腑燥实而烦者，应与小承气汤攻下存阴。大便即通，不需再服，即“和之愈”。

（四）蓄血证的小便利

1.其人发狂者，以热在下焦，少腹当硬满，小便自利者，下血乃愈**……**抵当汤主之。（**124**）

2.太阳病，身黄，脉沉结，少腹硬，小便不利者，为无血也；小便自利，其人如狂者，血证谛也。抵当汤主之。（**125**）

3.伤寒有热，少腹满，应小便不利，今反利者，为有血也**……**（**126**）

【按】少腹又满又硬，其人如狂（不安）或发狂，小便自利如常，为蓄血证，下血乃愈，用抵当汤攻逐瘀血。若少腹满而不硬，为无瘀血，当利其小便，随证治之。

（五）小便利或不利与发黄的关系

1.太阴者，身当发黄；若小便自利者，不能发黄。（**187**）

2.阳明病，被火，额上微汗出，而小便不利者，必发黄。（**200**）

3.阳明病，无汗，小便不利，心中懊**侬**者，身必发黄。（**199**）

4.伤寒，脉浮而缓，手足自温者，系在太阴；太阴当发身黄，若小便自利者，不能发黄。（**278**）

5.太阳病**……**但头汗出，余处无汗，剂颈而还，小便不利，身必发黄。（**134**）

6.阳明病，脉迟，食难用饱，饱则微烦头眩，必小便难，此欲作谷瘅。（**195**）

7.阳明病，面合色赤，不可攻之。必发热，色黄者，小便不利也。（**206**）

【按】阳明病，身热，法多汗，大便秘结，可知湿热淤积在里。若身无汗，又加上小便不利，则湿热无去之径，必然郁蒸向上，故但头汗出，心中懊侬，恶心欲吐。湿热蕴结太过，势必发为谷瘅（黄疸的一种），身黄如橘子色，应与茵陈蒿汤，泻热利湿退黄。若属阴、虚、寒的太阴病，小便自利，腑内无湿淤积，则不能发黄。

（六）小便色白

1.伤寒，不大便六七日，头痛，有热者，与承气汤；其小便清者，知不在里，仍在表也，当须发汗。（**56**）

2.若小便色白者，少阴病形悉具。小便白者，以下焦虚有寒，不能制水，故令色白也。（**282**）

3.伤寒，热少微厥，指头寒，默默不欲食，烦躁。数日，小便利，色白者，此热除也。（**339**）

【按】小便色白是指小便清澈色白而不黄赤，说明一无里证，二主下焦阳虚之证，三为里热消退之征候。56条，六七日不大便为里证，头痛有热为表证。若二者同时出现，见小便色白为无里实证，当先解其表，治其头痛有热。反之，见小便黄赤而少，当先攻里，急下存阴。

三十五、不大便

《伤寒论》中出现“不大便”12次，“不更衣”2次，“大便硬”13次，“大便难”5次，“燥屎”8次。

（一）实证

1.伤寒不大便六七日，头痛有热者，与承气汤。（**56**）

2.阳明病**……**手足濈然汗出者，此大便已硬也，大承气汤主之。（**208**）

3.伤寒**……**不大便五六日，上至十余日，日晡所发潮热**……**谵语者，大承气汤主之。（**212**）

4.潮热，手足**漐漐**汗出，大便难而谵语者，下之则愈，宜大承气汤。（**220**）

5.病人不大便五六日，绕脐痛，烦躁，发作有时者，此有燥屎，故使不大便也。（**239**）

6.大下后，六七日不大便，烦不解，腹满痛者，此有燥屎也。所以然者，本有宿食故也，宜大承气汤。（**241**）

7.伤寒六七日，目中不了了，睛不和，无表里证，大便难，身微热者，此为实也。急下之，宜大承气汤。（**252**）

8.少阴病，六七日，腹胀，不大便者，急下之，宜大承气汤。（**322**）

（二）虚证

1.……与承气汤一升**……**若不转气者，勿更与之。明日又不大便，脉反微涩者，里虚也。为难治，不可更与承气汤也。（**214**）

2.若不大便六七日，恐有燥屎，欲知之法，少与小承气汤，汤入腹中，转失气者，此有燥屎也，乃可攻之。若不转矢气者，此但初头硬，后必溏，不可攻之，攻之必胀满不能食也。欲饮水者，与水则哕。（**209**）

3.若不大便六七日，小便少者，虽不受食，但初头硬，后必溏，未定成硬，攻之必溏。（**251**）

（三）伤津

1.阳明病，其人多汗，以津液外出，胃中燥，大便必硬，硬则谵语，小承气汤主之。若一服谵语止者，更莫复服。（**213**）

2.伤寒四五日，脉沉而喘满，沉为在里，而反发其汗，津液越出，大便为难，表虚里实，久则谵语。（**218**）

3.阳明病，本自汗出，医更重发汗，病已差，尚微烦不了了者，此必大便硬故也。以亡津液，胃中干燥，故令大便硬。（**203**）

4.趺阳脉浮而涩，浮则胃气强，涩则小便数，浮涩相搏，大便则硬，其脾为约，麻子仁丸主之。（**247**）

5.脉阳微而汗出少者，为自和也。汗出多者为太过。阳脉实，因发其汗，出多者，亦为太过。太过者，为阳绝于里，亡津液，大便因硬也。（**245**）

6.太阳病，若吐，若下，若发汗后，微烦，小便数，大便因硬者，与小承气汤，和之愈。（**250**）

【按】不大便多指粪便干燥硬结，排便间隔时间长，通常在四至七天排便一次，粪便艰涩难下。今称“大便秘结”“大便艰难”。

不大便有实证、虚证及津伤燥结证。

实证：不大便五至六日，或十余日，腹胀，腹满痛，烦躁，谵语，午后潮热，手足汗出，头痛眼花，无表证，此为燥屎内结，为阳、实、热证，应急下之，治以大承气汤攻下热结燥屎。

虚证：不大便五至六日，虽有腹胀，但初头硬，后必溏，燥屎未成，不可用攻下之法。

津伤燥结证：其人多汗，亡津液，肠中燥，大便硬，此为表虚里实，燥结未甚，可与小承气汤，破滞通腑；若胃热，小便数，胃气强脾气弱，经常便秘，大便艰难，可与麻子仁丸，润肠泻热通腑。

凡用攻下通腑之法，大便通时，止后服。

三十六、下利

《伤寒论》出现“下利”45次，“下利清谷”7次，“利（大便）”33次。

（一）病因

1.太阳与阳明合病者，必自下利。（**32**）

2.自利，不渴者，属太阴，以其脏有寒故也。当温之，宜服四逆辈。（**277**）

3.自利而渴者，属少阴也。虚故引水自救。（**282**）

4.若自下利者，脉当微厥，今反和者，此为内实也。调胃承气汤主之。（**105**）

（二）虚寒证

1.脉浮而迟，表热里寒，下利清谷者四逆汤主之。（**225**）

2.下利厥逆而恶寒者，四逆汤主之。（**353**）

3.少阴病，下利清谷，里寒外热，手足厥逆，脉微欲绝，身反不恶寒，其人面色赤。或腹痛，或干呕，或咽痛，或利止脉不出者，通脉四逆汤主之。（**317**）

4.下利清谷，里寒外热，汗出而厥者，通脉四逆汤主之。（**370**）

5.少阴病，二三日不已，至四五日，腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者，此为有水气**……**真武汤主之。（**316**）

6.少阴病，下利，脉微涩，呕而汗出，必数更衣、反少者，当温其上，灸之。（**325**）

7.伤寒服汤药，下利不止，心下痞硬，服泻心汤已，复以他药下之，利不止**……**此利在下焦，赤石脂禹余粮汤主之。复不止者，当利其小便。（**159**）

（三）表证

1.太阳病，桂枝证，医反下之，利遂不止。脉促者，表未解也。喘而汗出者，葛根黄芩黄连汤主之。（**34**）

2.太阳与阳明合病者，必自下利，葛根汤主之。（**32**）

（四）半表半里证

1.伤寒十三日不解，胸胁满而呕，日晡所发潮热，已而微利。此本柴胡证**……**先宜服小柴胡汤以解外，后以柴胡加芒硝汤主之。（**104**）

2.伤寒发热，汗出不解，心中痞硬，呕吐而下利者，大柴胡汤主之。（**165**）

3.太阳与少阳合病，自下利者，与黄芩汤。若呕者，黄芩加半夏生姜汤主之。（**172**）

（五）伤阴证

1.少阴病，下利，咽痛，胸满，心烦，猪肤汤主之。（**310**）

2.少阴病，下利六七日，咳而呕，渴，心烦不得眠者，猪苓汤主之。（**319**）

（六）气郁证

少阴病，四逆，其人或咳，或悸，或小便不利，或腹中痛，或泄利下重者，四逆散主之。（**318**）

（七）水饮食滞证

伤寒汗出解之后，胃中不和，心下痞硬，干噫食臭，胁下有水气，腹中雷鸣，下利者，生姜泻心汤主之。（**157**）

（八）脾胃虚弱证

伤寒中风，医反下之，其人下利，日数十行，谷不化，腹中雷

鸣，心下痞硬而满，干呕，心烦不得安。医见心下痞，谓病不尽，复下之，其痞益甚。此非结热，但以胃中虚，客气上逆，故使硬也，甘草泻心汤主之。（**158**）

（九）里热证

1.热利下重者，白头翁汤主之。（**371**）

2.下利欲饮水者，以有热故也，白头翁汤主之。（**373**）

3.下利后更烦，按之心下濡者，为虚烦也。宜栀子豉汤。（**375**）

（十）里实证

1.少阴病，自利清水，色纯青，心下必痛，口干燥者，可下之，宜大承气汤。（**321**）

2.下利谵语者，有燥屎也。宜小承气汤。（**374**）

（十一）治疗原则

1.太阳中风，下利，呕逆，表解者，乃可攻之。（**152**）

2.下利腹胀满，身体疼痛者，先温其里，乃攻其表。温里宜四逆汤，攻表宜桂枝汤。（**372**）

（十二）下利病机的好转

1.下利有微热而渴，脉弱者，今自愈。（**360**）

2.下利脉数，有微热汗出，今自愈。（**361**）

3.下利脉数而渴者，今自愈。设不差，必清脓血，以有热故也。（**367**）

4.少阴病，脉紧，至七八日自下利，脉暴微，手足反温，脉紧反去者，为欲解也。虽烦，下利，必自愈。（**287**）

5.少阴病，吐，利，手足不逆冷，反发热者，不死。脉不至者，

灸少阴七壮。（**292**）

6.少阴病，下利。若利自止，恶寒而踡卧，手足温者，可治。（**288**）

（十三）下利病机的恶化

1.下利，手足厥冷，无脉者，灸之。不温，若脉不还，反微喘者，死。（**362**）

2.伤寒六七日不利，便发热而利，其人汗出不止者，死。有阴无阳故也。（**346**）

3.少阴病，恶寒，身踡而利，手足逆冷者，不治。（**295**）

4.少阴病，下利止而头眩，时时自冒者，死。（**297**）

5.伤寒六七日，大下后，寸脉沉而迟，手足厥逆，下部脉不至，喉咽不利，唾脓血，泄利不止者，为难治。（**357**）

6.少阴病，吐，利，躁烦，四逆者，死。（**296**）

7.伤寒发热，下利至甚，厥不止者，死。（**345**）

8.少阴病，脉微细沉，但欲卧，汗出不烦，自欲吐，至五六日，自利，复烦躁不得卧寐者，死。（**300**）

9.伤寒，下利日十余行，脉反实者，死。（**369**）

（十四）下利病机的顺逆

1.伤寒四五日，腹中痛，若转气下趋少腹者，此欲自利也。（**358**）

2.下利后脉绝，手足厥冷，晬时脉还，手足温者生，脉不还者死。（**368**）

3.少阴病，下利，脉微者，与白通汤。利不止，厥逆无脉，干呕，烦者，白通加猪胆汁汤主之。服汤，脉暴出者死，微续者生。（**315**）

4.下利脉沉而迟，其人面少赤，身有微热，下利清谷者，必郁冒

汗出而解，病人必微厥，所以然者，其面戴阳，下虚故也。（**366**）

5.下利脉沉弦者，下重也；脉大者，为未止；脉微弱数者，为欲自止，虽发热不死。（**365**）

【按】下利是指大便稀薄，排便次数增多，今称泄泻、腹泻。下利涉及的病证极广，表现形式多种多样。《伤寒论》中下利出现有52次之多，对下利的描述，也是名目繁多：有“自利”“自下利”“利不止”“利遂不止”“微利”“快利”“泄利”“协热利”“热利下重”“下利清谷”“自利清水，色纯青”“身倦而利”“厥利”“久利”“吐利”。

凡自利者不外脏有寒湿和内腑食滞两大病因，治疗根据其兼证而治之。

里虚脏寒证：若下利清谷，手足厥逆而恶寒者，治以四逆汤，回阳救逆。下利更见脉微欲绝者，治以四逆汤，干姜用量增加一倍，名曰“通脉四逆汤”，意在温中回阳以通脉；若下利身有水气，腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛者，治以真武汤，温阳利水。

里热里实证：若热利腹痛，里急后重，渴欲饮水者，治以白头翁汤，清热燥湿止利；若心下硬痛，热结旁流，下利黑水，臭秽不堪者，应急下之，治以大承气汤，峻下燥实热结；若热结旁流，便秘难忍，亦可用小承气汤，泻热通腑。

下利兼有表未解者，治以葛根芩连汤，解肌清热燥湿；下利兼有胸胁满而呕者，治以小柴胡加芒硝汤，和解清泄去实；下利兼有胃中不和，嗳气肠鸣，胃肠有水湿者，治以生姜泻心汤，和胃化湿；下利兼有水谷不消化，肠鸣，心下痞者，治以甘草泻心汤，和胃补中消痞。

下利之治疗原则：下利，呕逆，兼有表证，应先解表；下利兼有腹胀，身体疼痛，应先温里而后解表。若下利，证见口渴，能进饮食，手足温而不厥，身有微热汗出，脉虽弱而不紧，为阳气开始恢复。若下利，证见手足逆冷，或厥逆脉不至，烦躁不能眠，为有阴无阳，病情危重。

三十七、便脓血

《伤寒论》中出现“便脓血”8次，“清脓血”1次，“便血”3次，“清血”1

次。

（一）便血的病因

1.太阳病，以火熏之，不得汗，其人必躁。到经不解，必清血，名为火邪。（**114**）

2.少阴病，八九日，一身手足尽热者，以热在膀胱，必便血也。（**293**）伤寒，先厥后发热，下利必自止。而反汗出，咽中痛者，其喉为痹。发热无汗，而利必自止，若不止，必便脓血。便脓血者，其喉不痹。（**334**）

3.伤寒发热四日，厥反三日，复热四日，厥少热多者，其病当愈。四日至七日热不除者，必便脓血。（**341**）

4.若脉数不解，而下不止，必协热便脓血也。（**258**）

5.伤寒**……**若厥而呕，胸胁烦满者，其后必便血。（**339**）

6.下利，寸脉反浮数，尺中自涩者，必清脓血。（**363**）

7.下利脉数而渴者，今自愈。设不差，必清脓血，以有热故也。（**367**）

8.淋家，不可发汗，发汗必便血。（**84**）

（二）治例

1.少阴病，下利，便脓血者，桃花汤主之。（**306**）

2.少阴病，二三日至四五日，腹痛，小便不利，下利不止，便脓血者，桃花汤主之。（**307**）

3.少阴病，下利，便脓血者，可刺。（**308**）

【按】便脓血是泛指肉眼观察，大便中脓与血混杂而下，或先便后血，或先血后便，或单纯便血，今称“痢疾”，并非指大便有黑血。

便脓血多为阳、实、热证，病因主要是湿、热、食滞，虚证甚少。

太阳病，误用火熏发汗，其人烦躁，或阳邪内郁，胸胁烦满，四至五日或八至九日不解，火热内攻、迫血妄行。若火攻于上，咽中痛，则

发为喉痹；若邪热下行，阴络损伤，脉数而口渴，下利不止，则发为脓血便，可选用黄芩汤，清热止利；若日久病仍不解，腹痛，小便不利，便脓血，则肠虚滑脱，可选用桃花汤，温中固脱。

三十八、瘀血

《伤寒论》中出现“瘀血”2次，“蓄血”1次。

1.阳明证，其人喜忘者，必有蓄血。所以然者，本有久瘀血，故令喜忘。屎虽硬，大便反易，其色必黑者，宜抵当汤下之。（**237**）

2.病人无表里证，发热七八日，虽脉浮数者，可下之。假令已下，脉数不解，合热则消谷喜饥，至六七日，不大便者，有瘀血，宜抵当汤。（**257**）

3.太阳病不解，热结膀胱，其人如狂，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，当先解其外。外解已，但少腹急结者，乃可攻之，宜桃核承气汤。（**106**）

【按】胡老讲：“食毒、水毒、瘀血三者，均属人体的自身中毒，为发病的根本原因，亦是中医学的伟大发明。”“其他所谓病因者，只不过是诱因或近因而已。”瘀者缓也，瘀血古人称为恶血，是指血液循环缓慢或蓄积人体局部，从而失去了血液本身的功能，反而为一大害处，故亦可称为血毒。

瘀血多属内热，脉数，无表里证。其人喜忘，能消谷善饥，大便色黑反易解，可与抵当汤，攻逐蓄血。若其人如狂，少腹急结者，可用桃核承气汤，破血下瘀。凡腹满硬而小便通利者，就要考虑是否有瘀血，这是《伤寒论》的治疗大法之一。

三十九、差后劳复

《伤寒论》中出现1次。

1.大病差后劳复者，枳实栀子豉汤主之。（**393**）

2.伤寒差以后，更发热，小柴胡汤主之。脉浮者，以汗解之；脉

沉实者，以下解之。（**394**）

3.大病差后，从腰以下有水气者，牡蛎泽泻散主之。（**395**）

4.大病差后，喜唾，久不了了，胸上有寒，当以丸药温之，宜理中丸。（**396**）

5.伤寒解后，虚羸少气，气逆欲吐，竹叶石膏汤主之。（**397**）

6.病人脉已解，而日暮微烦，以病新差，人强与谷，脾胃气尚弱，不能消谷，故令微烦，损谷则愈。（**398**）

【按】伤寒为大病，初愈时，脾虚胃弱，气血未复，应注意调养，过劳过饱均可使疾病复发。大病后，若更发热，与小柴胡汤扶正祛邪；若胸上有寒喜唾者，与理中丸温中散寒；若腰以下重，与牡蛎泽泻散利小便；若虚羸少气胃有虚热者，与竹叶石膏汤清热和胃，益气生津；若饮食过多日暮微烦者，减少饭量可愈。

四十、潮热

《伤寒论》中出现12次。

（一）阳明腑实潮热

1.……日晡所发热者，属阳明。（**240**）

2.阳明病，脉浮而紧者，必潮热发作有时，但浮者，必盗汗出。（**201**）

3.阳明病，潮热，大便微硬者，可与大承气汤，不硬者，不可与之。（**209**）

4.阳明病，谵语，发潮热，脉滑而疾者，小承气汤主之。（**214**）

5.阳明病，脉迟，虽汗出不恶寒者，其身必重，短气，腹满而喘。有潮热者，此外欲解，可攻里也。手足濈然汗者，此大便已硬也。大承气汤主之。若汗多，微发热恶寒者，外未解也。其热不潮，未可与承气汤。若腹大满不通者，可与小承气汤，微和胃气，勿令至大泄下。（**208**）

【按】潮热，是指发热如潮水一般，日晡定时而来，一日一发，病位在里，属阳明，后世又称“午后潮热”。若一日数次发热，则并非潮热。

治疗里热证，若表热而里不热，汗多，微发热恶寒，为外未解也，其热不潮，只宜清解；若有潮热，汗出不恶寒，腹满不通，大便已硬者，为里实可下之证，非承气辈莫属。

（二）少阳里实潮热

1.伤寒十三日不解，胸胁满而呕，日晡所发潮热，已而微利。此本柴胡证，下之以不得利，今反利者，知医以丸药下之，此非其治也。潮热者，实也。先宜服小柴胡汤以解外，后以柴胡加芒硝汤主之。（**104**）

2.阳明病，发潮热，大便溏，小便自可，胸胁满不去者，与小柴胡汤。（**229**）

【按】潮热兼有胸胁苦满而呕吐，可知病位在少阳半表半里。若见潮热轻，大便溏或微利，宜服小柴胡以解外。外者，半表半里偏于外；若见潮热重，大便不畅或便结，即可用小柴胡汤加芒硝汤，治其燥实。实者，半表半里偏于里。

第三章　伤寒论证治辨析

宋本白文《伤寒论》十卷标题用“辨某某病脉证并治”10次，强调凭脉象和证候而施治，以下对10个原则性的证治大法，进行分析鉴别，辨其疑似是从，厘清主次，立法处方。以冀阐明仲景所突出的“随证治之”（16）、“以法治之”（97、267）、“以法救之”（244）在“六经辨证”中的重要性。

一、汗

1.太阳病，外证未解，脉浮弱者，当以汗解，宜桂枝汤。（**42**）

2.太阳病，脉浮紧，无汗，发热，身疼痛，八九日不解，表证仍在，此当发其汗。服药已微除，其人发烦目瞑，剧者必衄，衄乃解。所以然者，阳气重故也。麻黄汤主之。（**46**）

3.服桂枝汤，大汗出，脉洪大者，与桂枝汤，如前法。若形似疟，一日再发者，汗出必解，宜桂枝二麻黄一汤。（**25**）

4.伤寒脉浮缓，身不疼，但重，乍有轻时，无少阴证者，大青龙汤发之。（**39**）

5.脉浮者，病在表，可发汗，宜麻黄汤。（**51**）

6.脉浮而数者，可发汗，宜麻黄汤。（**52**）

7.伤寒脉浮紧，不发汗，因致衄者，麻黄汤主之。（**55**）

8.阳明病，脉浮，无汗而喘者，发汗则愈，宜麻黄汤。（**235**）

【按】汗法，就是通过发汗，开泄皮肤肌腠，逐邪外出，解除表证的一种治疗方法。太阳病是外邪侵入人体的第一阶段，多种疾病从此而发生。其病位在表，其主要证候是极易鉴别的自汗出和汗不出，虽原则上均应予以汗解，有一分表证解一分表，但自汗必须用桂枝汤法，无汗必须用麻黄汤法。

若头痛发热，汗出恶风，欲解外者，宜桂枝汤。桂枝汤的功用，原文有“发汗”8条、“解外”2条、“解肌”1条、“解表”1条、“攻表”1条、“救

表”1条、“调和营卫”3条、“和解”1条、“救邪风”1条。教材归纳为解肌祛风或解肌发表，调和营卫。胡老讲：“解肌”在仲景时代，实与“发汗”同义，“解表”“解外”又与“解肌”同义，这样加在一起，发汗就有12条之多。桂枝汤证已有发热汗出，何以再发汗。其实，仲景在12条桂枝汤方后有服药后要达到“遍身漐漐微似有汗者益佳，不可令如水流漓”。本方姜、枣、草为甘温之品，又喝稀粥增加谷气，从而起到养胃增液，发小汗而解热，调和营卫而固表止汗的作用。对于气虚不足以祛邪，虽汗出而邪不去者，用之最当。

若恶寒发热，头痛身疼，无汗而喘，“病在表，可发汗”，宜麻黄汤，发汗解表平喘。

若恶寒发热，寒热俱重，脉浮紧，身疼痛，不汗出而烦躁者，宜大青龙汤，发汗解表除烦。

若项背强几几，无汗，恶风，或下利，宜葛根汤，发汗解表止利。

以上发汗解表的四个方证，均强调服药后盖被，取微似有汗，一服汗出病差，停后服，不必尽剂，并告诫“汗多亡阳”。

胡老讲：麻黄汤证，恶寒，身疼痛，都很重，睡在床上，头、身、腰、四肢怎么放都喊痛；大青龙汤证，发热、恶寒很重，不汗出而烦躁，盖两床被子还喊冷。此二方证，发病1～2小时后，就不存在了，会迅速变为它证，我们在门诊是看不到的。因此，临证解表，用葛根汤比麻黄汤、大青龙汤好使。因为葛根、麻黄加桂枝，实为发汗法与补中增液法（桂枝汤）同用，若身体不虚，内热明显，口干而渴者，加生石膏一两半（45克），效果很好。

二、不可汗

《伤寒论》出现“不可发汗”12次，“不可更发汗”1次。

1.太阳病，发热恶寒，热多寒少。脉微弱者，此无阳也，不可发汗，宜桂枝二越婢一汤。（**27**）

2.脉浮紧者，法当身疼痛，宜以汗解之。假令尺中迟者，不可发汗。何以知然？以荣气不足，血少故也。（**50**）

3.少阴病，脉细沉数，病为在里，不可发汗。（**285**）

4.咽喉干燥者，不可发汗。（**83**）

5.疮家，虽身疼痛，不可发汗，汗出则痉。（**85**）

6.少阴病，脉微，不可发汗，亡阳故也。（**286**）

7.下利清谷，不可攻表，汗出必胀满。（**364**）

8.脉微而恶寒者，此阴阳俱虚，不可更发汗，更下，更吐也。（**23**）

【按】仲景以脉而析证。脉微弱（27）、尺中迟（50），脉细沉数（285），脉微（28），均主虚、主里、主津液亏血不足，此三者为虚证，都不可发汗，发汗不仅亡阳，而且会亡失津液。古人无法输液，发汗解表不要损伤津液是定理。咽喉干燥，恶疮不愈的疮家，经常有鼻出血的人，此三者为阴虚火旺之证，虽有表证，亦不可发汗，否则阴阳俱虚，病生他变。364条下利清谷，为里虚寒证，即是有表证，也为表里同病，宜先救其里，不可攻表。若误发汗解表，则汗出亡津液，虚其胃肠，必胀满不能食。

仲景在少阴病中再三论“汗法”，可以证明少阴病是阴、虚、寒的表证，并强调少阴病之表证，脉微细，但欲寐，不可以太阳之法发汗解表，“无少阴证者，大青龙汤发之”。（39）

三、误汗

1.问曰：证象阳旦，按法治之而增剧，厥逆，咽中干，两胫拘急而谵语。师曰：言夜半手足当温，两脚当伸，后如师言，何以知此？答曰：寸口脉浮而大，浮为风，大为虚，风则生微热，虚则两胫挛，病形象桂枝，因加附子参其间，增桂令汗出，附子温经，亡阳故也。（**30**）

2.大青龙汤服药法下：取微似汗。汗出多者，温粉粉之。一服汗者，停后服。若复服，汗多亡阳遂虚，恶风烦躁，不得眠也。（**38**）

3.病人脉阴阳俱紧，反汗出者，亡阳也。此属少阴，法当咽痛而复吐利。（**283**）

4.少阴病，脉微，不可发汗，亡阳故也。（**286**）

5.未持脉时，病人手叉自冒心，师因教试令咳，而不咳者，此必两耳聋无闻也。所以然者，以重发汗，虚故如此。（**75**）

6.汗家，重发汗，必恍惚心乱，小便已阴疼，与禹余粮丸。（**88**）

7.病人有寒，复发汗，胃中冷，必吐蛔。（**89**）

8.病人脉数，数为热，当消谷引食，而反吐者，此以发汗，令阳气微，膈气虚，脉乃数也。数为客热，不能消谷，以胃中虚冷，故吐也。（**122**）

【按】太阳病是多种疾病的初起阶段，邪气虽盛，正气也不虚，尚可奋起抵抗。正邪交争，病情变化迅速，变化证更为多端。汗法为太阳病的治疗大法，使用得当，很多病证在太阳阶段即可治愈。若失汗或误汗，则病情变化迅速，误治变证最多，仲景用占《伤寒论》一半的条文，详加论述。太阳病之原发病，不过22条，只占太阳病178条的12.3%，可知坏病何其多。其中误汗、误灸、烧针、火攻是主要原因，均为医之过。胡老讲："误汗后，不是亡阳，便是伤津。阳虚证误汗后，往往先亡阳；阴虚证误汗后，往往先伤津。"

表证应先辨虚实，继论汗法。表实证，脉浮紧，正气不虚，单用汗法，即可祛邪外出，如麻黄汤、大青龙汤、葛根汤等，仲景强调发汗只能用一次，不可复发汗，否则就是误汗。表虚证，脉浮缓，正气已虚，用桂枝汤甘温益胃，生津增液，治疗谷气不足的"阳浮而阴弱"诸证。要求啜热稀粥，微似有汗出，不可大发其汗。本方可以一用再用。若经汗、吐、下、火攻、烧针误治后，表仍不解，仍可用桂枝汤"救表"，而不可再用麻黄汤了。

胡老讲：使用汗法，不管用何方证，只为求得小汗，调和营卫，维护正气。服药后，汗多身如洗，即为发汗太过，亦称误汗，多指麻黄汤、大青龙汤、葛根汤，如需要只能发一次汗。桂枝汤后有"乃服至二、三剂"，大青龙汤后有"一服汗者，停后服"。切记。

四、下

1.太阳病三日，发汗不解，蒸蒸发热者，属胃也。调胃承气汤主之。（**248**）

2.伤寒吐后，腹胀满者，与调胃承气汤。（**249**）

3.若腹大满不通者，可与小承气汤，微和胃气，勿令至大泄下。（**208**）

4.其后发热者，必大便复硬而少也，以小承气汤和之。不转矢气者，慎不可攻也。（**209**）

5.阳明病，其人多汗，以津液外出，胃中燥，大便必硬，硬则谵语，小承气汤主之。若一服谵语止者，更莫复服。（**213**）

6.伤寒六七日，目中不了了，睛不和，无表里证，大便难，身微热者，此为实也。急下之，宜大承气汤。（**252**）

7.阳明病，发热，汗多者，急下之，宜大承气汤。（**253**）

8.发汗不解，腹满痛者，急下之，宜大承气汤。（**254**）

9.少阴病，得之二三日，口燥，咽干者，急下之。（**320**）

10.少阴病，自利清水，色纯青，心下必痛，口干燥者，可下之，宜大承气汤。（**321**）

11.少阴病，六七日，腹胀，不大便者，急下之，宜大承气汤。（**322**）

12.太阳病不解，热结膀胱，其人如狂，血自下，下者愈，其外不解者，尚未可攻，当先解其外。外解已，但少腹急结者，乃可攻之，宜桃核承气汤。（**106**）

【按】下是攻逐体内积滞，通泄大便的一种治法，常用于阳明病里热、燥实的瘀滞之证。①若发汗表不解，无形之实热壅滞肠胃，胃气不和，腹胀满者，治以调胃承气汤，以小泻有稀便为效。②若汗多伤津，胃肠干燥，大便必硬，但无燥屎，解便困难时有谵语（有苦难言），脉滑疾，治以小承气汤，通气和胃，泻下结粪而不致大泻下。③若病过六七日，仍身热汗多，潮热，燥屎形成，腹胀满痛而谵语，语言错乱，痛苦不堪，眼花目呆不识人。此时的胃家实证，不论病人体质之强弱，正气之虚实，都须急下存阴，通结泻热，慎不可延误。即便是少阴病见到

此证，也须刻不容缓“急下之”“急则治其标”，否则可有死证之虞。下之后，脉弦（阳气还）者生，脉涩（亡阴）者死。

胡老讲：热结膀胱，少腹急结的桃核承气汤证（106），以及少腹当硬满的抵当汤证（124），均可见有形之实邪，虽出自于太阳篇，但确属阳明实证。五版教材《方剂学》述：“此二方功用，前者是破血下瘀，后者攻逐蓄血”，均属下法。成无已却说：“太阳经邪热不解，随经入腑，为热结膀胱。”但106条又讲：“外解已，但少腹急结者，乃可攻之。”不难看出，“膀胱”“少腹”均指部位，并非指“经”“腑”。124条“下血乃愈”，是指瘀血、瘀脓自大便排出，而并非是自膀胱小便排出。桃核承气汤与三承气汤，都名曰“承气”，自报大名为攻下法，不言而喻。

阳明三急下之主证为腹大满实痛。少阴三急下证危在旦夕，不但阳气衰微，而且津液即将亏尽。此“六急下”证，均为今日之“危重病”。仲景时代，“急下”是唯一可能有效之法，急下救人，不是活便是死。舍此，别无它法。若今日遇此凶险危证，早已送ICU抢救。唯有胡希恕先生卓见胆识，功力非凡，提笔命方，“急下”救人。王国玮主编的《伤寒温病燕京医学四流派》（中国中医药出版社2013年版）一书中载：1982年，北京中医学院针灸名家单玉堂，患肺心病住院，病情恶化，神智昏迷，二便不通，已出现心衰合并肾功能不全。学院领导邀请本院六位知名专家，董建华、王绵之、刘渡舟、胡希恕、赵绍琴、杨甲三会诊，众专家提出“扶正保心肾”的治疗方案。84岁的胡老诊完舌象脉象后，提出要“峻剂攻下”“小大不利治其标”先解决大小便的问题，态度非常果断。众名老念其年事最高，便都依了。单老服药的第二天，奇迹发生了，大便五次，开始排尿，五天后，肾积水消失，已能下地活动，一周后出院。刘渡舟老师在胡老著作的序言中写道：“每当在病房会诊，群贤齐集，高手如云，唯先生能独排众议，不但辨证准确无误，而且立方遗药，虽寥寥几味，看之无奇，但效果非凡，常出人意料，此皆得力于仲景之学也。”

笔者在无锡见到大师兄冯世纶教授时，问：“胡老给单老处何方？”答：“大柴胡汤合桃核承气汤。”我知道胡老以身试药，亲自服过大柴胡合桃核承气汤，验之速效。因而每遇疑难危证，胸有成竹，药到病除。否则人命关天，岂敢冒如此大险。跟老师实习时，老师病了，面目虚浮，胸闷心慌，腹胀便秘，营养不良致肝脏微大，自己处方，服大柴胡合桃核承气汤二剂，霍然自愈。当时我和同学都非常惊讶，于是问老

师："病成这样，怎么能服大黄、芒硝？要请别的老师处方，肯定得用黄芪、党参。"老师说："你们看，我好了，心不慌了，能上班了。"今日，我把故事讲给学生听，学生赞不绝口，感叹不已："胡老善用经方，出神入化，炉火纯青！""单老服药，疗效神奇，如汤泼雪！""胡老治病，犹如仲景在世，名不虚传！"

五、不可下

《伤寒论》中出现"不可下"9次，"不可攻"9次。

1.太阳与阳明合病，喘而胸满者，不可下，宜麻黄汤。（**36**）

2.太阳病，外证未解，不可下也，下之为逆。欲解外者，宜桂枝汤。（**44**）

3.结胸证，其脉浮大者，不可下，下之则死。（**132**）

4.阳已虚，尺脉弱涩者，复不可下之。（**286**）

5.手足寒，脉弦迟者，此胸中实，不可下也**……**（**324**）

6.诸四逆厥者，不可下之，虚家亦然。（**330**）

7.腹濡，脉虚，复厥者，不可下，此亡血，下之死。（**347**）

8.伤寒呕多，虽有阳明证，不可攻之。（**204**）

9.阳明病，心下硬满者，不可攻之。（**205**）

10.此但初头硬，后必溏，不可攻之**……**不转矢气者，慎不可攻也。（**209**）

【按】胃家实或身热，汗自出，不恶寒反恶热，均称阳明病，治疗当用下法。实热、燥屎、宿屎、水饮、蓄血等实邪，也该使用下法。若病情严重，仲景还设有"三急下"，急下存阴，急下救逆，可转危为安。但阳明重证，常伴有兼证，病情复杂而多变，仲景特嘱，还有不可使用下法者。

（1）凡邪在表：恶寒（164），喘而胸满（36），脉浮大（132），面合而赤（邪在表）（206），虽有阳明证，不可用下法。

（2）邪在半表半里：呕多（204），心下硬满（205），胸中实（324），虽有阳明证，不可用下法。

（3）阳明腑证未实：初头硬，后必溏（209、238），虽有腹胀满，不可用下法。

另外，舌上苔滑，脉弱、脉虚、脉迟的“虚家”，“亡血”证（347），手足寒（324），诸四逆厥者（330）等，在八纲辨证中，属阴、虚、寒之证，虽有阳明证，亦不可使用下法。

仲景举例：

太阳中风表虚证，素有宿疾之喘家，误下后微咳，邪气尚未内陷，仍可气机上逆作喘，证见痰湿阻肺，咳嗽微喘。治疗仍与桂枝汤解肌祛风，加厚朴、杏仁下气消痰，宣肺止咳。

下气后表不解，气上逆而作喘，里有热而汗出。无大热是指微有热，并未达到承气汤之大热。麻杏石甘汤清热宣肺，止咳平喘，治今日上呼吸道感染，或肺炎使用抗生素无效者，效果非常好。胡老讲：本方不能减味使用，只能加味。热重者加金银花、黄芩、桔梗；痰多者加半夏、陈皮、贝母；咳重加紫菀、白芍；哮鸣声重加射干。麻黄必须蜜炙，生石膏必须打碎，否则个别病人服药后头痛。炙麻黄与生石膏的用量比例，一般以1 ： 5或1 ： 6为宜。

六、误下

1.太阳病三日，已发汗，若吐，若下，若温针，仍不解者，此为坏病，桂枝不中与之也。观其脉证，知犯何逆，随证治之。（**16**）

2.太阳病，下之微喘者，表未解故也。桂枝加厚朴杏子汤主之。（**43**）

3.太阳病，下之，其脉促，不结胸者，此为欲解也；脉浮者，必结胸；脉紧者，必咽痛；脉弦者，必两胁拘急；脉细数者，头痛未止；脉沉紧者，必欲呕；脉沉滑者，协热利；脉浮滑者，必下血。（**140**）

4.脉浮数者，法当汗出而愈。若下之，身重，心悸者，不可发

汗，当自汗出乃解。（**49**）

5.大下之后，复发汗，小便不利者，亡津液故也。（**59**）

6.下之后，复发汗，必振寒，脉微细。所以然者，以内外俱虚故也。（**60**）

7.伤寒，医下之，续得下利清谷不止，身疼痛者，急当救里。（**91**）

8.下后，不可更行桂枝汤，若汗出而喘，无大热者，可与麻黄杏子甘草石膏汤。（**162**）

【按】胡老讲："失治者多变证，误治者多坏病。"从《伤寒论》书中看，仲景治病不赞成用火攻、温针、烧针（16、117），全书超过一半讲误治。所误汗、吐、下，以误汗、误下为最多，仲景统称为"坏病"（16、267）。怎么办？"观其脉证，知犯何逆，随证治之"（16），"以法治之"（97、267），"以法救之"（244），胡老称之为"辨证施治"。

里证误下，多致亡津液（58）、内外俱虚（60）。少阳病禁汗、吐、下（264、265），少阳误下则悸而惊（264）。

太阳受邪，因感风寒，病位在表，治疗多用汗法，祛邪外出，其余治法，均属误治。若有兼证，也要遵循先表后里的治疗原则。表证误下，可使表邪内陷，变为它证。表证"打吊针、输液"，寒凉之液进入人体，很不利于邪从汗解，我们可以叫"误下"。虚证误下，可损伤中气脾胃。虚人之体，静脉点滴抗生素，损伤消化系统，很不利于正气的恢复，我们也可以叫"误下"。

七、辨汗、下先后

1.本发汗，而复下之，此为逆也。若先发汗，治不为逆。本先下之，而反汗之，为逆。若先下之，治不为逆。（**90**）

2.伤寒，医下之，续得下利清谷不止，身疼痛者，急当救里，后身疼痛，清便自调者，急当救表。救里宜四逆汤，救表宜桂枝汤。（**91**）

3.伤寒大下后，复发汗，心下痞，恶寒者，表未解也。不可攻痞，当先解表，表解乃可攻痞。解表宜桂枝汤，攻痞宜大黄黄连泻心汤。（**164**）

4.下利腹胀满，身体疼痛者，先温其里，乃攻其表。温里宜四逆汤，攻表宜桂枝汤。（**372**）

5.太阳病，过经十余日，反二三下之，后四五日，柴胡证仍在者，先与小柴胡。呕不止，心下急，郁郁微烦者，为未解也。与大柴胡汤下之则愈。（**103**）

6.伤寒十三日不解，胸胁满而呕，日晡所发潮热，已而微利。此本柴胡证，下之以不得利，今反利者，知医以丸药下之，此非其治也。潮热者，实也。先宜服小柴胡汤以解外，后以柴胡加芒硝汤主之。（**104**）

【按】胡老讲："疾病的发生，必有病邪所反应的病位。"病位绝不会超出表、里和半表半里三者。病在表（51），病在里（285），故表、里是绝对的。半在里半在外（148），故内外是相对的，治疗亦应遵循先外后内的"表里原则"（103、104）。表证该用汗法，里证当用下法或用温里之法。若表里同病，当先解表，有一分表证解一分表。治疗使用汗法，使邪从汗解，待表证解除后，再论治里，此为仲景定理，也是使用汗法治疗一切外感表证之常法。

该用汗法解表，就不能用下法，"太阳病证不罢者，不可下，下之为逆"（48）。没有一种病是可以先泻下再发汗的，否则必先伤阴后亡阳。病该用下法，就不可发汗解表，故少阳、阳明禁用汗法。

病有缓急，治有先后，先后错施，则为误治。表证急者，当先解表；里证急于表证者，当先救里。《伤寒论》中举例如下。

（1）32条接31条，太阳与阳明合病，项背强几几，无汗，恶风，又自下利。先以葛根汤发汗解表，待表解后再治下利。此为先表后里之治则。

（2）48条，二阳并病，因汗出不彻，太阳未罢，转属阳明。即太阳未解，阳明病又起，不可用下法治阳明病，只能先解表用小发汗之法。此为先表后里之治则。

（3）36条，太阳与阳明合病，喘而胸满，宜麻黄汤发汗解表，宣肺平喘，如果有里证，也不可用下法。此亦先表后里之治则。

（4）220条，二阳并病，太阳表证已罢，但发潮热，大便难而谵语，可用大承气汤峻下燥屎热结，下之则愈。此为表解后方可用下法。

（5）189条，“阳明中风，口苦，咽干，腹满，微喘，发热，恶寒，脉浮而紧。若下之，则腹满小便难也”。该条为太阳与阳明合病，里热而又有外邪，即表里同病。胡老讲：“应先解表，宜大青龙汤。”结果被医者误下，成为腹满小便难之坏病。此条举例，违背了先表后里、先汗后下之治则。

（6）164条，恶寒为表不解，心下痞为半表半里证。正治法为，先用桂枝汤解表，后用大黄黄连泻心汤攻痞。此为先解表，后治半表半里。少阳为太阳之里，亦即先表后里之治法。

（7）104条，若有柴胡证，或呕，或胸满而呕，少阳半表半里为里之外，先与小柴胡汤以解外。若呕不止，心下急，或潮热，为里实，则以证选用大柴胡汤（103），或柴胡加芒硝汤（104），此为半表半里证合病里证，即少阳阳明合病。亦即先表后里之治法。

（8）91条，身疼痛为表证，又有正气虚之下利清谷。扶阳为《伤寒论》第一要义，里证急于表证，治应先用四逆汤救里。此为先里后表之治法。

（9）100条，阳脉涩，阴脉弦。阴主里，弦主痛，涩主气血不足，以致腹中急痛。应与小建中汤补气血建中气，缓急止痛。药后痛止，少阳证不差者，再与小柴胡汤，扶正祛邪。此为先里后表之治法。

对以上经文之辨析，足以证明胡希恕先生以八纲释六经的正确性和实用性。若以足太阳膀胱经、足少阳胆经和足阳明胃经，来解释上述表、里和半表半里的治疗先后法则，可能是很难理解的，也不适用于临床的辨证治疗。

八、和

1.伤寒五六日，头汗出，微恶寒，手足冷，心下满，口不欲食，大便硬，脉细者，此为阳微结。必有表，复有里也。脉沉，亦在里

也。汗出为阳微。假令纯阴结，不得复有外证，悉入在里，此为半在里半在外也。脉虽沉紧，不得为少阴病。所以然者，阴不得有汗，今头汗出，故知非少阴也，可与小柴胡汤。（**148**）

2.伤寒五六日中风，往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，或胸中烦而不呕，或渴，或腹中痛，或胁下痞硬，或心下悸，小便不利，或不渴，身有微热，或咳者，小柴胡汤主之。（**96**）

3.妇人中风，七八日续得寒热，发作有时，经水适断者，此为热入血室。其血必结，故使如疟状，发作有时，小柴胡汤主之。（**144**）

4.阳明病，胁下硬满，不大便而呕，舌上白苔者，可与小柴胡汤。上焦得通，津液得下，胃气因和，身濈然汗出而解。（**230**）

5.吐利止而身痛不休者，当消息和解其外，宜桂枝汤小和之。（**387**）

6.不恶寒，但热者，实也。当和胃气，与调胃承气汤。（**70**）

7.太阳病，若吐，若下，若发汗后，微烦，小便数，大便因硬者，与小承气汤，和之愈。（**250**）

8.得病二三日，脉弱，无太阳，柴胡证，烦躁，心下硬，至四五日，虽能食，以小承气汤，少少与，微和之，令小安。（**251**）

【按】和是一方面祛邪，一方面扶正，达到祛邪而不伤正的治疗大法，亦称“和解”（387）。适用于病邪在半表半里的少阳病。其代表方证有小柴胡汤、大柴胡汤、柴胡桂枝干姜汤、四逆散和半夏泻心汤。少阳病证候反应的病位在半表半里。因病邪不在表，不能用汗法解表，病邪不在里，也不能用下法攻里，故只能用和法。用和法还不能伤及正气，即不能伤及广大胸腹腔诸多脏器的正常生理功能。所以用柴胡、黄芩、半夏、枳实、大黄祛邪的同时，必用参、草、姜、枣扶正，保胃气。胡老讲：“少阳虽禁汗，禁吐，禁下，实指单用此三法而言。”

胡老讲：来门诊看中医的患者，原始病很少，继发病和久病较多，大多缘于失治和误治。失治者多“变证”，误治者多“坏病”。“坏病”多在半表半里之少阳和厥阴。今日经多方治疗的慢性病，来看病时已无麻黄汤证和大青龙汤证，并且此二方证只能用一次，汗出之时，已不可“再发

汗”。来诊者的承气汤证更少，便通之时，已不能“再下之”。所以大多数慢性病都羁留在有广大胸腹腔诸多脏器的半表半里。临床可见糖尿病、高血压、冠心病、脑梗后遗症、手术后综合征等多种慢性病的太阳病，已不是学生、工人、农民、军人等人群的太阳病，麻桂、青龙已无用武之地。慢性病患者的脏腑功能都很差，抗病能力低下，并且食饮多，活动少，和法可以大行其道。上焦得通，津液得下，胃气因和，身濈然汗出而解。（230）

胡老善用经方，运用合方治疗疑难杂症，更有独招绝活，炉火纯青，效如桴鼓，名扬中外，刘渡舟老师曾给予高度评价。胡老临床常用的“和法的经典合方”是：和而兼汗用柴胡桂枝汤；和而兼下用大柴胡和小陷胸汤；和而兼温用小柴胡合吴茱萸汤；和而兼清热用小柴胡加生石膏；和而兼化湿用小柴胡合五苓散；和而兼补用小柴胡合当归芍药散；和而兼祛瘀用大柴胡合桂枝茯苓丸；和而逐瘀峻下用大柴胡合桃核承气汤。以上“和法”的八个合方方证，胡老称：“临床常遭遇的方证，常须识此，勿令误也。”

《伤寒论》有并病、合病。伤寒六经三阳病，并病为一经病之证未罢，他经病之证又起，合病为两个阳经或三个阳经同时受邪而发病。三阴病无并病及合病。三阳病有太阳与少阳并病（142、150、171），太阳与少阳合病（172），阳明与少阳合病（256），及三阳合病（219、268）共计7条。另外，二阳合病（32、33、36），二阳并病（48、220）共计有5条。证明少阳与太阳，少阳与阳明，三阳同时发病，都与少阳有关，在临床比较常见。虽少阳病篇的经文只有10条，小柴胡汤证只有1条，但小柴胡汤在太阳病、阳明病、厥阴病、阴阳易差后劳复病均有论述（太阴病、少阴病无论述），多达16条。这些经文充分证明，胡老以少阳病和法为核心，以柴胡剂为主打方证，临床用于常见病，多发病，疗效突出，深受好评。刘渡舟老师称赞：“此皆得力于仲景之学也。”学生颂胡老雅号，美其名曰“大柴胡”。一代宗师，享誉杏林。

仲景用和法还有一层意思：和法的用药味数要少，用药剂量要小，不要伤及脾胃之气。每剂药味数多，用药剂量大者，不能称为和法。“吐利止而身痛不休者，当消息和解其外，宜桂枝汤小和之”（387）。 “不恶寒，但恶热者，实也。当和胃气，与调胃承气汤”（70）。“微烦，小便数，大便因硬者，与小承气汤，和之愈”（250）。 “无太阳、柴胡证，烦躁，心下硬，以小承气汤，少少与，

微和之，令小安”（251）。

九、死

《伤寒论》中出现“死证”19次，“不治”2次，“难治”8次。

1.结胸证悉具，烦躁者亦死。（**133**）

2.病胁下素有痞，连在脐旁，痛引少腹，入阴筋者，此名脏结，死。（**167**）

3.直视，谵语，喘满者死，下利者亦死。（**210**）

4.伤寒若吐，若下后不解，不大便五六日，上至十余日，日晡所发潮热，不恶寒，独语如见鬼状。若剧者，发则不识人，循衣摸床，惕而不安，微喘直视，脉弦者生，涩者死。微者，但发热谵语者，大承气汤主之。若一服利，则止后服。（**212**）

5.少阴病，吐，利，躁烦，四逆者，死。（**296**）

6.少阴病，四逆，恶寒而身踡，脉不至，不烦而躁者，死。（**298**）

7.少阴病，脉微细沉，但欲卧，汗出不烦，自欲吐，至五六日，自利，复烦躁不得卧寐者，死。（**300**）

8.伤寒，脉迟六七日，而反与黄芩汤彻其热。脉迟为寒，今与黄芩汤复除其热，腹中应冷，当不能食，今反能食，此名除中，必死。（**333**）

9.伤寒六七日，脉微，手足厥冷，烦躁，灸厥阴。厥不还者，死。（**343**）

10.伤寒，下利日十余行，脉反实者，死。（**369**）

【按】《伤寒论》中言“死”，是指治不好的病或证。还有指病已经相当危重，如果误下，后果必死（132、347）。古时之“死证”，今日抢救治疗，不一定死。分析《伤寒论》中的“死证”，对于在基层工作的临床医生来说，很有必要。若遇危重病人，审证持脉（75），能否用中医治疗，敢不敢开中药处方，或转上级医院治疗，可以心中有数，不至于

误治出错。胡老讲："医者不知死，焉能救生乎。"

三阳病死证6条（太阳2条，阳明4条）。三阴病死证15条（少阴7条，厥阴8条）。少阳、太阴无死证，阴阳易差后劳复病无死证。证明阴、虚、寒的三阴病比阳、实、热的三阳病，要危重得多，治疗也相当棘手。霍乱病无死证，证明仲景所讲的霍乱病，并非今日之烈性肠道传染病霍乱。

死证的脉象：结胸证，其脉浮大者，下之则死（132）；重发汗，亡其阳，谵语，脉短者，死（211）；微喘，直视，脉涩者，死（212）；恶寒，而身踡，脉不至，不烦而躁者，死（298）；服汤，脉暴出者，死（315）；脉不还，反微喘者，死（362）；手足厥冷，脉不还者，死（368）；下利十余行，脉实者，死（369）。

死证的证候：结胸证，烦躁（疑为肝脾肿大）（133）；脏结病，胁下素有痞，连在脐傍，痛引少腹（急腹证、嵌顿疝、结核性腹膜炎）（167）；利遂不止（脱水）（205）；直视，谵语，喘满，息高（肺心病）（210、299）；四逆、恶寒、踡卧，脉不至（298）；自利，复烦躁不得卧寐（300）；亡血（失血症）（347）。

除中：是指中气将绝反而能食的回光返照危象。我下乡接受再教育是在新疆农村。当时，多数重病患者都困在家中，去石河子市看病，有50多公里，只有马车或驴车。很多情况是医生到家中看危重病人，我见过两例"除中"证。其一，男，80岁，甘肃人，患中风卧床不起一年多，最后7～8天，进食很少，突然想吃肥大肉（西北称猪肉为"大肉"），家人给做了一盘子五花大肉片，病人吃得多，家人都非常惊讶，以为病好转了。谁知，病人吃肉以后很糊涂，昏睡不醒，我去后也没有治疗办法，半天后过世。其二，男，70岁，江苏支边人员，理发师，在公社卫生院附近，开了一个理发店，长期患肺气肿、肺心病，呼吸困难，张口抬肩，不能平卧，吸氧气后好一点。最后4～5天，进食很少，突然要吃稠大米稀饭，吃了一小碗后，张口喘息，昏睡不醒，约一小时后就断气了。

十、愈

1.凡病，若发汗，若吐，若下，若亡血，亡津液，阴阳自和者，

必自愈.（**58**）

2.须表里实，津液自和，便自汗出愈。（**49**）

3.复发其汗，荣卫和则愈，宜桂枝汤。（**53**）

4.太阳病，发汗后，大汗出，胃中干，烦躁不得眠，欲得饮水者，少少与饮之，令胃气和则愈。（**71**）

5.太阳病，先发汗不解，而复下之，脉浮者不愈。浮为在外，而反下之，故令不愈。今脉浮，故在外，当须解外则愈，宜桂枝汤。（**45**）

6.太阳病，脉浮紧，发热，身无汗，自衄者愈。（**47**）

7.太阳病，过经十余日，反二三下之，后四五日，柴胡证仍在者，先与小柴胡汤。呕不止，心下急，郁郁微烦者，为未解也，与大柴胡汤下之则愈。（**103**）

8.二阳并病，太阳证罢，但发潮热，手足**漐漐**汗出，大便难而谵语者，下之则愈，宜大承气汤。（**220**）

9.太阳病，若吐，若下，若发汗后，微烦，小便数，大便因硬，与小承气汤，和之愈。（**250**）

10.厥阴病，渴欲饮水者，少少与之愈。（**329**）

11.呕家有痈脓者，不可治呕，脓尽自愈。（**376**）

12.病人脉已解，而日暮微烦，以病新差，人强与谷，脾胃气尚弱，不能消谷，故令微烦，损谷则愈。（**398**）

【按】《伤寒论》中的愈，是指病人经过服药或调理，身体恢复正常。胡老讲课时说：病人已无表里证，不恶寒不发热，不虚不实，六经证候已不复存在，饮食二便正常，持脉平和。仲景总结一句话“阴阳自和者，必自愈”（58）。阴指寒、虚、里、津液；阳指热、实、里、正气（生理功能）。病痊愈了，可以说无寒热，不虚也不实，但不能说不阴不阳或无阴阳，只能“阴阳自和”一言以蔽之。辨证治疗，预防调理，都应按这一定理而进行。

《伤寒论》载：治愈46次，治愈率为69%。病程轻者6～7日愈（7），重者12～13日愈（10、384）。病死21次，死亡率为31%。说

明当年仲景辨证施治的疗效，是比较高的。治疗的方法是解表、攻下、和胃气、疗津液、保阳气，调理饮食二便，对于治疗常见病、多发病，是行之有效的。书中三阳病治愈31次，三阴病治愈13次。说明三阳病病人体质尚好，病邪侵入人体浅，病情较轻，易治；三阴病病人体质已虚，病邪侵入人体较深，病情危重，难以治愈。

中医师承学堂·一所没有围墙的大学

[丛书主编：刘观涛]

“中医新课堂”系列

《中医师承实录》 余国俊/著
《我的中医之路》 余国俊/著
《经方大师传教录》 江尔逊/著
《我的脉学探索》 金 伟/著
《名医师承讲记》 李 静/著
《张锡纯医学师承学堂》 李 静/著
《贾海忠中医体悟·父子亲传实录》 贾海忠/著
《临证传心与诊余静思》 高建忠/著
《朱文锋中医辨证学讲课实录》 朱文锋/著
《朱文锋中医诊法学讲课实录》 朱文锋/著
《平脉辨证传承实录百例》 李士懋/著
《疑难病辨治回忆录》 熊继柏/著

“经方师承大学堂”系列

《经方传真：胡希恕经方理论与实践》 冯世纶/编著
《胡希恕越辨越明释伤寒》 段治钧/编著
《胡希恕讲仲景脉学》 段治钧/编著
《方证相对：伤寒辨证论治五步》 刘观涛/著
《陈慎吾伤寒论讲义》 陈慎吾/著
《陈慎吾金匮要略讲义》 陈慎吾/著
《皇汉医学》 汤本求真/著
《李阳波伤寒论坛讲记》 李坚 黄涛 胡存慧/整理
《经方时方六经辨证应用案解》 鲍艳举 花宝金/著
《黄仕沛经方亦步亦趋录》 何莉娜 等/主编
《全国经方论坛现场实录》 张广中/主编
《当代经方名家临床之路》 李赛美/主编
《伤寒温病误案解析》 张国骏/主编
《伤寒论通俗讲话》 胡希恕/著
《金匮要略通俗讲话》 何 任/著
《王雪华金匮要略讲课实录》 王雪华/主编

“中医名家绝学真传”系列

《开启中医之门》 李阳波讲述 刘力红等/整理
《五行针灸指南》 刘力红 推荐 诺娜·弗兰格林/著
《扶阳讲记》 卢崇汉/著
《扶阳论坛》1、2、3 刘力红 等/著
《圆运动的古中医学》 李可 点校 彭子益/著
《中医运气与健康预测》 庄一民/著

策划编辑 刘观涛
责任编辑 王 琳
文字编辑 宋雨辉
封面设计 宇 听

一所没有围墙的大学

中医师承学堂 新浪博客 http://blog.sina.com.cn/mtjkydd
投稿与学术合作邮箱 liuguantao@vip.sina.com（48 小时回复）

读中医药书，走健康之路
扫一扫 关注中国中医药出版社系列微信

中医出版
（zhongyichuban）

悦读中医
（ydzhongyi）

上架建议 | 中医临床

ISBN 978-7-5132-5632-2

定价：45.00元